

十萬金方

針灸第一集



3283

77

1

統一書號：14086·60

定 價：(8)0.75元

河北省中医研究院編选

十萬金方

河北人民出版社

新學社
PDG

內 容 提 要

本书包括：流行性“乙型”脑炎、肺结核、胃痛、中风、高血压、神经衰弱、精神病、感冒、痢疾等四十多种疾病，共选二百四十五个秘方和验方。

书中的每个方子，都详细地介绍了所取穴位、手法等，并在按语中对每穴的运用、主治症及其作用作了概括的论述。同时，在理论根据及治疗经验方面，均提供了较为丰富的参考资料。

十 万 金 方

针灸第一集

(内科)

河北省中医研究院 编选

河北人民出版社出版 (保定市裕华东路) 河北省书刊出版业营业许可證第三号

河北人民出版社印刷厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168 1/32 · 6 $\frac{3}{4}$ 印张 · 4 插页 · 144,000 字 印数：1—13,000 册 1960年1月第一版
1960年1月第一次印刷 统一书号：14086·60 定价：(8)0.75元

編 者 的 話

一九五八年河北省开展了中医中药全民采风运动，提出了“挖宝”、“采宝”、“献宝”的口号。通过这次全民性的群众运动，仅在方剂方面，每个县、市都搜集了秘方、驗方、民間单方几万件。經過卫生部門逐級挑选后，送到卫生厅的有二十多万件。包括药物疗法、針灸疗法，以及正骨、按摩、气功等等疗法；治疗范围，有內科、外科、妇科、兒科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科……几乎包括了人体的所有疾病。这些疗法，有若干代的祖传秘方，有古方今用的發揮，有临床經驗的創造，有民間流传的土方。有預防法，有治法。为了把这些疗法推广应用，卫生厅移交本院整理。我們按类、按科、按病編輯。分为內科、外科、妇科、兒科、传染病科、伤科、皮肤科、五官科、針灸科、正骨科、气功科，等等。

編輯体例，一科一册，或一科数册；一病一册，或一册数病；一病有若干疗法，一种疗法有若干治法和方剂。每个方剂的内容，包括：方名（方剂的名稱）、来源（方剂的来源）、主治、症状（适应症的症状）、药物（方剂的組成）、制法、加减法、用法、禁忌、治驗（供方人的治疗病例）等項。为了便于讀者

与供方人研究探討，列有供方人的姓名、住址。最后有編者按語，簡述对本方的使用原則及应注意事項；并将其他供方人雷同的方剂和經驗，尽可能地在按語中附帶介紹；同时并附有各地的有关臨床經驗總結，以指導应用。上列項目，由于原始資料不完善，有的暫缺，留待以后补充。

本书选录的資料，都是供方人的原始資料，經查証疗效可靠，按本书体例編輯。有些方剂是几十人或几百人所献，方剂組成相同，或大同小异，即选录比較完善的，不能一一罗列，特向供方人致以歉意。

此外，本书选录的資料，还包括本省历年来的技术經驗交流座談会上的資料，以及本省各級卫生工作者协会送交本院的技术資料。

一九五八年河北省卫生厅在保定举办了中医中药展覽会，内部出版了“河北省中医中药展覽会医药集錦”一册、“十万金方”（部分初稿）十五册，各地紛紛索购，已刊印十余万册。由于在內容的編輯方面，缺点很多，也有若干差錯，不再刊印。同时对河北省卫生工作者协会編选的“中医驗方汇选（內、外科）”一书，也不再繼續編选，均选优列入本书內容。

本书采用中医中药展覽会“采风館”方剂部分中的“十万金方”命名。所謂“十万”，即“多”的涵义；“金方”言其“好”也，即現代医生的臨床經驗總結，实用有效，或有一定疗效。

本书的內容，限于編者的理論、技术水平，缺点

錯誤之處，在所難免。部分脫稿後，熱愛祖國醫學者紛紛建議迅速出版。為答謝建議者的熱心關懷，邊整理，邊付印，缺點錯誤，更是難免。希望讀者批評指導；並請將使用本書各種療法的臨床經驗，及時函告，以便再版時校正、補充，不勝感謝之至。

河北省中醫研究院

一九五九年十一月

目 录

一、流行性“乙型” 脑炎	1	三十四、中消	81
二、瘧疾	6	二十五、貧血症	84
三、腸伤寒	10	二十六、神經衰弱	86
四、痢疾	11	二十七、中風	99
五、流行性感胃	14	二十八、口眼喎斜	107
六、肺結核	18	二十九、暴瘡不語	144
七、咳嗽痰喘	20	三十、高血压	147
八、梅核气	28	三十一、头痛	125
九、腮腺炎	30	三十二、癲癇	139
十、扁桃體炎	32	三十三、癰病	157
十一、胃腸炎	34	三十四、牙痛	167
十二、胃十二指腸潰 瘍	38	三十五、胃痛	171
十三、便血	45	三十六、腹痛	174
十四、五更瀉	47	三十七、腰痛	178
十五、便秘	49	三十八、肋痛	184
十六、脫肛	51	三十九、背痛	187
十七、遺尿尿閉	53	四十、風濕痹	189
十八、疝氣偏墜	63	四十一、下痿	192
十九、膈肌痙攣	69	四十二、僵僕	195
二十、脾脏腫大症	73	四十三、上臂不舉	197
二十一、肝硬變	74	四十四、落枕	200
二十二、臌脹	77	四十五、手足指趾痛	204
二十三、黃疸	79	四十六、手顫	207
附：針灸經穴圖	211	四十七、中毒急救	209

一、流行性“乙型”腦炎 (共三方)

第一方 霸县医院 王茂林介紹

主治：流行性“乙型”腦炎。

症状：头痛，高烧，昏迷，抽搐，頸項强直，角弓反张。

取穴：哑門 人中 大椎 涌泉 曲池 手三里
列缺 环跳 委中 阳陵泉 中脘

加减法：根据病情，以上述各穴为主，配合下列各穴：

(一) 病情严重，体温过高，刺风府、风池、内关、足三里、經渠、八风、八邪、十宣(放血)等穴。

(二) 神智昏迷，刺中渚、至阴、劳宫等穴。

(三) 角弓反张，刺印堂、素髖、尺澤、合谷、承山等穴。

(四) 呕吐，煩躁不安，刺阳谿、通里、膈俞等穴。

(五) 津液干枯，刺人中、承浆、支沟等穴。

(六) 牙关紧閉，刺颊車、合谷、大陵等穴。

(七) 病情严重，除針刺上述主穴及有关配穴外，并兼服牛黄安宮丸。

手法：用毫針直刺，用平补平泻手法，不灸，留針三十至四十分钟。病輕，每天針一次；病重，每天可針三次。一般針三次，神志可以清醒。

治驗：（一）張××，男，十歲。一九五八年八月十日五點三十分入院，住院號三一二六七。主訴：“發高燒，抽風，昏迷二天。”現病史：三天前早晨患兒自覺腰疼，按摩後見好轉；夜間前額頭痛，發燒口苦，嘔吐頻作——開始嘔吐的是食物，後吐湯水狀液體。當即以刺針治療，症狀未好轉。次日，突然神志昏迷，口吐白色漣沫，抽搐，兩目天吊，陣發性的發作。十二日脈象沉伏不見，體溫四十點八度，脈搏一百四十八次；頸項強直，角弓反張，陣發性抽搐；大便黑色，小便赤短，失禁；眼結合膜充血，胸部皮膚有出血點。經中西醫雙規診斷為流行性“乙型”腦炎，用刺針療法。取穴：廉泉、百會、涌泉；配穴：列缺、八風、八邪、絕骨、照海、印堂，用中等刺激手法。主穴與配穴輪番選用，每次四、五穴，每日針一次，留針三十至四十分鐘。共針二十五次，痊癒，無後遺症。

（二）本縣老堤村劉××，男，四歲。一九五七年八月十四日入院，住院號一五二一五。症狀：高燒、咳嗽、頭疼、嘔吐、昏睡，陣發性痙攣，目上吊，頸項強直，角弓反張，大小便失禁。確診：流行性“乙型”腦炎。治療穴位：勞宮、大谿、后谿、合谷、承漿、人中；中封、攢竹、上星、足三里。針法：用中等刺激手法，每次可選用四、五穴，留針三十至四十分鐘。針四次後，症狀接近消失，遂出院，在門診部繼續治療數日，痊癒。

第二方 安國縣祁州人民公社醫院 李鶴鳴介紹

主治：溫病——流行性“乙型”腦炎、腦膜炎。

症狀：頭痛，發熱，四肢抽搐，角弓反張。

取穴：大椎 陶道 身柱 風池 百會 印堂
曲池 合谷(雙) 中沖(雙) 陽陵泉(雙)

足三里(双) 絕骨 环跳 解谿 太冲 大敦
涌泉 哑門 后谿

手法: 用毫針捻轉进針，用平补平泻手法。先針百会，直刺二分；次針风池五分；然后再針大椎、陶道、身柱，針尖向上斜刺进針五分深，捻轉一分钟，不留針；曲池五分，合谷、后谿、环跳各針二寸，阳陵泉一寸，絕骨五分，太冲五分，大敦二分，均用捻轉手法，一分钟出針；印堂、中冲点刺出血。消化不良，加配三腕、天樞等穴。涌泉留針十至三十分钟，其他各穴不留針。一般針刺三次，症状好轉。

治驗: (一) 本县城內东門里斜街楊××，男，十三岁。一九五五年七月間患本病。主訴：“开始体溫高，头痛，逐漸失語，昏睡，抽搐。”入院检查：体热、头热，瞳孔散大，反射消失，皮肤过敏，四肢抽搐，角弓反张，不能言語，脉象洪数有力。經中西医双規診斷为流行性“乙型”腦炎，用針灸疗法。取穴：先直刺百会二分，风池五分，捻轉手法；继刺大椎、陶道、身柱，針尖向上斜刺五分，捻轉一分钟，不留針；刺肩髃三分，曲池五分，合谷、后谿、环跳二寸，阳陵泉一寸，絕骨五分，太冲五分，大敦二分，均用捻轉手法，一分钟出針。当时抽搐停止，惟人事不省，瞳孔尚未收回，又刺涌泉五分，針尖斜向足根，留針五分钟；刺承浆二分，印堂、中冲放血。針刺后神志清醒，仍不会說話，遂將患者取坐式，平刺哑門一寸二分，患者急呼“好疼”，立即出針。第二日复診：自觉症状完全消失，語言有迟鈍感，刺风池、大椎、合谷。第三日复診：所有症状完全消失，因食欲不佳，刺风池、三腕、气海等穴。經数日观察，未复发。

(二) 本县城北樓家营楊××的女孩。一九五五年八月間就

診。家長代訴：“發燒三天，意識昏迷，每日抽搐數次，大便三日未下，尿赤色。”脈象洪數有力，體溫三十九點五度，微有汗出，腹部脹滿，角弓反張，四肢抽搐，二目天吊，瞳孔散大，神志昏迷。診為流行性“乙型”腦炎。治療取穴：針百會二分，不留針；印堂，放血；人中、承漿各針二分，不留針；風池五分，用雀啄術手法，一分鐘去針；大椎、陶道、身柱各刺五分，捻轉一分鐘，不留針；肩髃三分，曲池一寸，合谷六分，后谿五分，均用捻轉手法，二分鐘去針；環跳二寸，陽陵泉一寸，絕骨五分，解谿五分，太沖五分，均捻轉二分鐘，不留針；涌泉刺二分，留針三十分鐘。因患兒體溫過高，加刺大杼、風門等穴。

第一次針後，角弓反張停止，症狀全部好轉。服加味太極丸二粒，牛黃安宮丸一粒。

第二日復診：脈象數，有輕度陣發性抽搐；神志清醒，大便通暢，身熱已退。繼刺前穴，仍服牛黃安宮丸。

第三日復診：脈象緩和，體溫正常，抽搐未發。有輕微頭疼，消化不良。刺三腕、天樞、氣海、足三里、太陽等穴。

第四日復診：諸症消失，遂停止針藥。囑其家以茅根水代茶飲數日，未復發。

第三方 樂亭縣汀流河人民公社衛生院 王竹庵介紹

主治：流行性“乙型”腦炎。

症狀：高燒，抽搐，昏迷不醒，頭項強直，角弓反張。

取穴：合谷 百會 尺澤（放血）

手法：先用毫針刺百會，向后斜刺四、五分；再直刺合谷一寸五分。二穴均捻轉進針，用瀉法，留針四十分鐘。尺澤用三棱針放血十毫升左右。

治驗：針刺上述穴位治療腦炎患者十例，一般針二次即愈。病情嚴重的，每天針二至三次；病情輕的，每天針一次。

按：流行性“乙型”腦炎，是一種急性傳染病，流行於夏秋季節，是溫病的一種。用中藥治療的一般規律是：初期輕型一般用辛涼透邪，佐以芳化法；重型用辛涼透邪，芳香開竅法；極重型用辛涼透邪，芳香開竅，佐以熄風法；轉輕期用清熱養陰及一般善後的對症處理。針灸治療，根據“實則瀉之，熱者寒之”（內經）的原則，採用有清熱、解毒、消炎、醒腦等作用的穴位和手法，並配合藥物治療，效果良好。一般治療規律，在病情急劇時，先用針刺治療；症狀減輕後，結合藥物療法。針刺上述穴位，適用於本病的各個時期。

針灸治療本病，在晉朝針灸甲乙經中記載：“風痙身反折，先取太陽及膈中，及血絡出血。”“痙取顙會、百會，及天柱、膈俞、上關、光明主之。”“痙互引善驚，太沖主之。痙反折，心痛，形氣短尻臃澀，小便黃閉，長強主之。”“小兒癇痙，嘔吐瀉注，驚恐，……長強主之。”玉龍賦載：“印堂治其驚搐。”勝玉歌載：“頭項強急承漿保。”針灸大成頭面門載：“腦痛，上星、風池、腦空、天柱、少海。”針灸大成小兒門載：“驚風：腕骨。”“角弓反張：百會。”從上述可知古人很早就採用針刺治療本病。這也說明了祖國醫學對急性傳染病的治療方法是豐富多彩的。

上述四方是根據中醫隨症施治的特點，在不同的情況下，根據一般治療規律，靈活運用的。刺大椎、陶道等穴，有鎮靜作用，可以抑制項背強痛，角弓反張的發作；十宣、十二井、尺澤等出血，能散邪熱；合谷、后谿，開竅寧志，醒神昏；涌泉，清胃散熱，引熱下行；曲池，清熱止抽搐；陽陵泉，利小便；中脘，調胃；足三里，降逆，溫四肢；大敦、太沖、后谿、身柱等穴，散身熱；列缺、百會、印堂，清頭部血熱，止頭痛。總之，對於流行性“乙型”腦炎的初期及病情較輕時，採用針灸療法可以治愈；對於重症，結合藥物治療，療效顯著，或以藥物治療，結合針灸，可縮短病程。

二、瘧疾 (共七方)

第一方 武清县大长亭卫生院 李文玉介紹

主治：瘧疾。

症状：寒热往来，間日一发。

取穴：身柱

取穴法：坐位。于第三胸椎下取之。

手法：在发作前一小时，用二十四号毫針沿皮向下刺身柱三分，捻轉至发生胀感为度。留針十至二十分钟，至全身感觉发冷时出針。隔日刺一次。

治驗：此方治愈瘧疾六十例，一般二至三次即痊愈。

第二方 邢台眼科医院 刘瑞济介紹

主治：瘧疾。

症状：发热恶寒，或先寒后热，或先热后寒。

取穴：天椎 陶道 間使(双) 曲池(双) 身柱

合谷(双) 章門(双) 肝俞 内关 承山 后谿

手法：在发作前两小时，用毫針强刺激(泻法)，留針三小时。一般針三次，即停止发作。如有其他兼症，随症加减配穴。

治驗：本院职工张××，男，四十五岁。一九五八年八月下旬，发热恶寒，隔日发作一次。經化驗检查，有瘧原虫。服药无效。

八月二十九日用針灸治療，在發作前三小時針刺。取穴：大椎、陶道、間使、合谷，用雙針齊刺的強瀉手法，留針三小時。針刺大椎、陶道兩穴時，有強烈反應（向下反射）；刺合谷穴反應到肩部。針後未復發。為了鞏固療效，第三天又針一次，再進行血檢，已無瘧原蟲。

第三方 龍烟鋼鐵公司宣化醫院 薛孝先介紹

主治：瘧疾。

症狀：先冷後熱，定時發作。

取穴：陽陵泉 陰陵泉

手法：用毫針，在發作前一、二小時針刺。初發者，從陽陵泉刺入，透至陰陵泉，用瀉法；久發者，從陰陵泉刺入，透至陽陵泉，用補法。捻轉進針，捻轉出針，不留針。必要時配合迎，用隨補瀉手法。

治驗：用上述穴位治療瘧疾患者多人，均獲得滿意療效。茲舉二例介紹如下：

（一）李××，男，三十三歲，農民。門診一〇〇一號。主訴：“三天前的下午二時，先冷後熱，至五時緩解。隔日又復發，疑為瘧疾。”本人及家族均無瘧疾病史。檢查：脈象弦實，舌白苔，食慾不振，大小便無顯著變化。聲強耳鳴，口苦心煩。診斷：瘧疾初發。取陽陵泉穴，用瀉法。每日針一次，三次即痊癒。

（二）張家口市宣化鎮新生街王××，女，二十五歲。門診一二〇二號。主訴：“患瘧疾，下午發作，兩天發作一次，已有月余，服藥無效。”本人及家族無瘧疾病史。檢查：脈象緩弱，身體虛弱，顏面蒼白，舌淡較潤，耳聾目眩，說話聲弱，自感心煩，食慾不振，精神萎靡，大便二至三日一次。診斷：脾虛久瘧。在未發

作前三小时，取阴陵泉穴，用补法，针刺六次，痊愈。

第四方 磁县柳园人民公社医院 王天德介绍

主治：瘧疾。

症状：头疼，发冷发烧，隔日一次。

取穴：合谷 委承間

取穴法：委承間，指委中与承山穴的中間。

手法：用毫针刺合谷穴，大指向前捻轉进入劳宫穴，活动肌肉，旋轉提出；再用三棱针刺委承間出血（男左女右）。在发病前一小时针刺。

第五方 石家庄市第二医院 李曾树介绍

主治：瘧疾。

症状：間日发作。

取穴：后谿 間使 大椎

手法：用毫针直刺后谿、間使两穴，捻轉进针，用平补平泻手法；大椎穴稍向上斜刺五至六分，有麻木感，留针三十分钟。强壮者，可以酌增留针时间。在发病前二小时针刺，一般三次即痊愈。

第六方 河北中医学院 江鸿祺介绍

主治：瘧疾。

症状：发热恶寒，定时发作，时有呕吐。

取穴：大椎 内关 間使 陶道

手法：用二十八号毫针，先针大椎穴五分，后针内关穴

五至八分。发热時間长，重刺捻針一百六十度；发冷時間长，輕刺捻針九十度。大椎与陶道两穴交互运用。发热較重，加刺間使穴；无汗发热，加刺合谷穴。均用重刺激手法，捻轉一百六十度。

附注：針后一日內，吃流动食物，宜少食，最好絕食一日。

第七方 邯鄲市第二医院 游貞祥介紹

主治：瘧疾。

症状：間隔性发作，两季肋部发胀。

取穴：主穴：手足十宣 后谿 間使 大椎

配穴：陶道 身柱

手法：在发作前两小时針刺。用毫針捻轉进針，用平补平泻手法；或点刺出血。后谿、間使两穴，留針十分钟；大椎穴留針二十分钟；其余各穴刺入五至七分，不留針。发冷发热时，用重刺激手法。大椎穴起針后，用拔火罐疗法，可降低体温。如两季肋部发胀，摸有硬块，可針刺块头、块中、块尾，各进針七分深；加刺脾俞、章門、足三里（針取患側），各留針三十分钟。三次即痊愈。

按：瘧疾的发病，解放前在我省多是散在性的发生；解放后，由于連年开展以除四害讲卫生为中心的爱国卫生运动，各地出现了許多四无城市和县、乡。因此，河北省近几年来，已根絕了瘧疾的发生。但是用針灸治疗瘧疾，是几千年来积累的丰富經驗。今特选录治疗瘧疾的經驗和針灸的穴位，以供作研究針灸机制問題的参考。

三、腸傷寒 (一方)

第一方 霸县医院 王茂林介紹

主治：腸傷寒。

症狀：高烧，腹泄，昏迷。

取穴：主穴：风府 风池 大椎 身柱 合谷

配穴：三阴交 二间 内庭 足三里 解谿

陷谷 中渚 絕骨 大都 少商 期門

中封 間使

手法：用毫針捻轉進針，用平補平瀉手法 留針三十至六十分鐘。每日針一次。如偏于太陽經病，則配大都、少商；偏于少陽者，則配中渚、絕骨；偏于厥陰者，則配期門、間使。

禁忌：針后忌食生冷硬物。

按：祖國醫學對腸傷寒，早有卓越的貢獻。明、清醫家稱為瘟疫。因其初必有精神郁結，消化不良，排泄障礙，濕熱糟粕，因遏在中所造成。吳又可說：“邪在募原。”現代醫學亦說病菌在小腸中繁殖，破壞腸粘膜因達于腸間膜、淋巴結而蔓延全身。治療多以清熱解毒、利小便、鎮肝育陰、開竅通靈等法靈活運用。上述取穴以風府、大椎疏泄頭部熱邪；合谷散面部之熱；身柱專能鎮靜；三陰交調和脾胃；足三里降逆清胃散熱；少商清肺熱；間使清熱除煩躁。諸穴配合，佐使為用，故施治于腸傷寒症候能收到一定的療效。

四、痢 疾 (共三方)

第一方 河間县救济医院 王坤凤介绍

主治: 痢疾。

症状: 腹疼下坠，便血。

取穴: 中脘 天枢 足三里

手法: 用毫针直刺，捻转进针。中脘刺一寸；天枢刺五至八分；足三里刺八分至一寸。均用平补平泻手法，留针一小时。一般针三次即痊愈。

第二方 保定市干部疗养院 王永业介绍

主治: 痢疾。

症状: 大便时里急后重，粪便中含有白色粘液。

取穴: 尺泽 合谷 足三里

手法: 先用三棱针刺尺泽，出血二至三毫升；再以毫针刺合谷、足三里各三分。合谷用补法，足三里用泻法，留捻针一小时。一次即痊愈。

第三方 霸县医院 王茂林介绍

主治: 中毒性痢疾。

症状: 呕吐腹泻，里急后重，便脓血。

取穴: 主穴：十宣 委中 尺泽 大陵

配穴：神門 合谷 中脘 天樞 足三里

勞宮 三陰交 太谿 涌泉

手法：用三棱針刺十宣、委中、尺澤放血；其余各穴用毫針直刺捻轉進針，用平補平瀉手法。一般針二次即痊愈。

禁忌：針后忌食生冷、硬物。

治驗：（一）屈××，男，十四岁。症状：面赤頰紅，精神迟頓，有时发作昏迷，舌色絳紫，声粗而有力。診斷时，忽然腹疼，半小时后即昏迷；清醒后腹急疼，随即下大便，味腥臭色土暗，帶有粘物，手足发冷；体温四十一度；脉象細小。治疗：先刺尺澤、委中、十宣出血，再刺足三里，用瀉法。灸关元三十分钟，复針中脘、天樞（双）、阴陵泉，用中等刺激手法，留針三十分钟。出針后即痊愈。

（二）金××，男，六十岁。症状：腹痛剧烈，面色蒼白，舌上无苔，有时昏迷，抽搐，声音嘶哑，里急后重，大便里有粘物，腥臭，色土紅，脉細似有似无。治疗：先刺十宣出血，瀉足三里，灸关元三十分钟；后針中脘、天樞、三陰交、勞宮、合谷，用中等刺激手法，留針三十分钟。針一次即痊愈。

（三）崔××，男，十一岁。症状：呼吸短促，四肢厥冷，腹痛剧烈，下痢似烂肉样粘物；脉細；体温四十度。治疗：先刺尺澤、委中、十宣出血；后灸关元；再針天樞（双）、足三里、三陰交、勞宮、涌泉，用中等刺激手法，留針三十分钟。出針后，体温降至正常，疼痛大減，逐漸痊愈。

按：針灸治疗痢疾文献記載很多。如針灸大成标幽賦治疗歌云：“痢疾不止連腹痛，天樞三里病即康。”又云：“下痢不止求天樞，又有內关三陰愈。”針灸集成痢疾篇云：“痢疾中气虛弱，

三焦不和所致，水痢不止，中脘穴針神效……。”又云：“瀉痢小腹痛，大腸俞、膀胱俞各三壯，灸之百壯，丹田二十七壯等。”說明祖國醫學用針灸治療痢疾的豐富經驗。現代針灸家亦多用這些穴位配合藥物療法，或單獨用針灸治療，都收到很好的療效。雖然自古至今各家記載治療穴位頗多，但天樞、中脘、足三里等穴在臨床實驗上用之為多。天樞，為大腸之募穴，脈氣聚集之所，甲乙經載：“腹瀉腸鳴，……寒泄食不化，天樞穴主之。”該穴有分理水谷糟粕、清濕熱、導滯滯之功能，故為治痢疾要穴。足三里穴系太陰之表經（足陽明）合土穴，因脾胃相關連，表里相應。又此穴系馬丹陽十二穴之一，“能通心腹脹；善治胃中寒，腸鳴并泄瀉……。”更重要的此穴是四總穴之一。“肚腹求三里”，意思就是說凡肚腹諸病，都應取此穴。本穴有升清降濁、清熱導滯、能調節胃腸的一切功能，故為治痢要穴。中脘，為胃之募穴，又是六腑之會，腑熱者宜取之。針灸大成載：“中脘主飲食不化。”本穴能升清、降濁、利氣，可瀉六腑之滯，有幫助消化，促進食欲的功能，故痢疾之兼食積者，用之卓效。其次合谷為大腸之原穴，屬陽主表，有升清降濁、宣通氣血的功能，有疏風散表、解表退熱的作用，故痢疾兼表症者，此為妙穴。正因為中脘、天樞、三里、合谷等主要治療胃腸疾患，故一般多採用上述各穴加減治療痢疾。至於第三方中毒性痢疾，所選用穴位，是因實熱毒盛，取十宣、委中、尺澤出血，清血中熱，以散熱毒；并配合其他穴位用補法，以達到扶正祛邪的目的。總之，針灸治療痢疾，是根據“虛則補之，實則瀉之，寒則溫之，熱則清之”的原則，施行針刺或灸熇，運用補法或瀉法，辨証論治。

五、流行性感冒 (共五方)

第一方 巨鹿县閻町人民公社 张正道介绍

主治：流感。

症状：高烧，恶寒，头痛，身痛。

取穴：陶道 风門

加减法：咳嗽加肺俞；不能进食者，加中樞、脊中，重者刺足三里。

手法：先将皮肤提起，用三棱针刺陶道、风門一至二分，出血；不留針，不灸。

第二方 元氏县城关人民公社医院 张可明介绍

主治：感冒。

症状：头痛，渾身冷烧，骨节疼痛。

取穴：曲池 手三里 承山 承筋 风池 上星
太阳

手法：用毫针刺入，先补后泄（插为补，提为泄）。刺上星穴，針尖向上刺；其余各穴直刺，不留針。

治驗：王××，男，二十八岁。患感冒。全身冷烧，头痛，骨节疼痛。針刺上述穴位，一次即痊愈。

第三方 阜平县砂窝乡 张惠生介绍

主治：感冒。

症状：发热，头痛项强，恶风寒。

取穴：主穴：大椎 大杼 风门 肺俞

配穴：太阳 风池 合谷

手法：（一）用梅花针：先从弹刺大椎穴开始，然后弹刺大杼、风门、肺俞、太阳、风池、合谷。

（二）用毫针：捻转进针（兴奋法），一般刺三至五分深，留针十至二十分钟。

治验：用毫针或梅花针按上述穴位治疗感冒，效果很好。梅花针与毫针治疗本病的比较，梅花针可以缩短病程。打刺后，患者入睡，汗出，很快地痊愈。每年春季感冒流行时，治愈人数很多，治愈率为百分之百。兹举二例介绍如下：

（一）本县百亩村顾××，男，五十岁。一九五九年三月患感冒。恶寒畏风，鼻流清涕，头痛。经用梅花针治疗，打刺后，随即入眠，渐渐汗出。睡醒后，症状消失，遂痊愈。

（二）本县百亩村张××，女，八岁。一九五九年三月患感冒。恶风，头痛，喷嚏。用毫针刺上述各穴，痊愈。

按：梅花针是我国医针的一种。原始制法：竹篾一根，一端钻孔，用毫针或缝紉针五个，穿入篾孔，用细线捆扎，固定。用五个针制成的，叫做梅花针；用七个针制成的，叫做七星针。这种针术，古代称为“毛刺”，“素问”里有详细记载，长期流传在民间。操作方法：术者右手持针，无名指和小指将针柄尾端固定在手掌内，拇指和中指将针柄左右固定，食指固定针柄前端，然后用手腕的弹力，在人体各刺激部位上进行弹刺，但必须弹准，弹稳。它

的适应症很广，对于慢性病，如哮喘、神经痛、风湿病、高血压、神经衰弱，以及消化系、泌尿系、生殖系的疾病，都有疗效；对于急性传染病的初期，有缓解作用。

第四方 盐山县庆云乡医院 张金铭介绍

主治：感冒。

症状：发烧，头痛，鼻塞，或全身关节痛。脉浮数或浮紧。

取穴：少冲 老商 人中 风府 太阳 内关
足三里

手法：用三棱针点刺二、三分，出血，不留针。一天针一次，一般针刺二次即痊愈。

第五方 保定专署卫生科介绍

主治：流行性感冒。

症状：发热，恶寒，头疼，身体疲倦。

取穴：主穴：少商 中商 老商

配穴：中冲 合谷 百会 印堂 人中

廉泉 中魁

取穴法：中商穴，在拇指的指甲根稍上约一韭菜叶处，少商穴和中商穴的中間；老商穴，在大拇指的外侧，距离指甲根约一韭菜叶处；少商穴，在大拇指的内侧，距离指甲角约一韭菜叶处。

手法：少商、中商、老商三穴，均点刺出血；廉泉穴，留针。

治驗：用上述穴位治疗流行性感冒是张浩志大夫創始，經本科試

治流感病人四十例，有效率为百分之百，治愈率达百分之八十三。复經高阳县卫生防疫站試行，效果与本科試用的疗效相同。在我区实用三年，治疗流感患者数万人，疗效很高。

按：（一）少商穴，是針灸常用的正經穴位；老商、中商二穴不見于文献記載。这三个穴位，河北省医务界称为“三商穴”。用三商穴配人中、中魁两穴，治疗流行性感冒，疗效很高。方法簡便易学，奏效迅速。临床經驗証明，三商穴对于急性传染病引起的咽喉肿痛，水飲不能咽下的喉科疾患，效果也很好。取穴：先刺三商穴，配尺澤、合谷（左右同刺），手法均为点刺。体质健壯的病人，刺三商、尺澤后，挤出血；虛弱的病人，不使出血。

（二）流行性感冒的症状，多表现在上呼吸道。叶天士說：“溫邪上受，首先犯肺。”吳鞠通說：“始于上焦，在于太阴。”因此采用“輕而揚之”，使从解表邪及清里热的方法。以上四方均以大椎、曲池、陶道为主穴。大椎的适应症极广泛，几乎全身疾病均可配合，对于感冒发热，可以迅速退热。临床时可随症加減。咳嗽加肺俞、陶道或天突；鼻流清涕加上星或迎香；头痛加太阳、上星、风池；周身疼痛加曲池、承山、承筋；恶心呕吐加曲池、尺澤、委中；高热，如风門、大杼、风池、合谷、身柱、大椎、陶道等穴，均可选用。

六、肺結核 (一方)

第一方 張北縣對口淖人民公社醫院 劉錦章介紹

主治：肺結核。

症狀：骨蒸潮熱，咳嗽，咯血，盜汗。

取穴：針刺主穴：大杼 大椎 風門 肺俞 太淵
身柱 曲池

灸法主穴：四花 患門 膏肓 百勞 五臟俞
足三里 三陰交 氣海 中極 太沖

手法：用毫針刺大杼、大椎、風門、肺俞、太淵、身柱、曲池七穴，捻轉進針；四花、患門、膏肓、百勞、五臟俞，用艾條灸；其餘各穴可隨症加減，酌情應用。

治驗：（一）李××，女，十八歲。一九五八年九月十八日入院。主訴：“咳嗽吐血，盜汗，已有七個月。近兩個月來，月經不見，飲食不振，身體疲憊，每晚發燒，下半夜盜汗。”確診：肺結核。經注射鏈霉素，療效很慢；採用針灸療法，第一次針灸，均取上列之穴。次日復診：夜間未盜汗，亦未吐血，咳嗽減輕；自覺氣短，不思飲食，當即灸五臟俞穴，針刺胃俞、足三里、三陰交、四花。針灸十三次後，食量大增，精神好轉。十一月三日針刺氣海、中極、肺俞、太沖等穴；灸百勞穴。十一月九日針刺足三里、五臟俞、大椎、氣海、中極；灸膏肓穴。一九五九年一月十五日，恢復健康出院。

(二) 樊××，女。咳嗽，盜汗，潮热，全身消瘦，已有一年。
治法：針刺五脏俞、大椎、間使、气海、中极、中脘、三阴交；灸膏育、四花穴。針灸交換使用，并經常坚持灸法(病人自灸)，两个月恢复健康。

按：中医治疗肺結核，大部以滋阴补肺，强壮健脾为主。針灸治疗本病，能使新陈代謝旺盛，血行循环良好，营养增进，抵抗力增强，消化吸收，同化机能，都能达到好轉。因此，針灸对于本病的全期都有效果，以在一、二期用針灸疗治最为合理。上述各穴多为古代治疗五劳七伤，虛損盜汗，劳热咳嗽的要穴。大椎，銅人載：“疗五劳七伤。”玉龙賦載：“止虛汗。”医学綱目載：“骨蒸劳热不可治者，取大椎。”风門，能泻一身热气，治咳嗽。肺俞，主泻五脏之热，神農經載：“治咳嗽、吐血、顫紅、骨蒸虛劳……。”乾坤生意載：“……同陶道、身柱、膏育，治虛損五劳七伤紧要法。”太渊，甲乙經載：“咳逆煩悶不得臥，胸中滿喘不得息，背痛，太渊主之。”千金載：“主胸滿激呼，……心痛肺胀。”曲池，能泻热，主胸中痛。膏育、四花、患門、百劳等，对一切慢性疾患，如慢性呼吸系病，神經衰弱、虛弱及生殖器疾病均可应用。五脏俞，主要泻五腑之热；其他各穴有健脾、助消化之功，但在临床应用时，可随症加減运用。如咳嗽：膏育、肺俞、风門、大杼、太渊、手三里、三阴交。胸痛：太渊、內关，局部取穴(痛点)。咯血：肺俞、膈俞、尺澤、足三里、百劳、中脘、丰隆、魚际。发热：大椎、曲池、风門、身柱、三阴交。盜汗：大椎、后谿、阴郛、复溜。胃腸障碍：中脘、气海、关元、胃俞、足三里。其中大椎、身柱、四花、患門、膏育等穴，为古代的名家穴法，特别是肺癆的名穴。因此配合应用，治疗肺結核，能获显著疗效。

七、咳嗽痰喘 (共十一方)

第一方 新乐县医院行唐分院 张补才介绍

主治：咳喘。

症状：感冒风寒即发喘，喉中如水鸡声，脉浮紧，按之无力。

取穴：主穴：身柱 灵台 肺俞

配穴：天突 膻中 气海 足三里

手法：用艾卷灸，或直接灸，或用鲜姜片隔灸均可。轻症灸至皮肤发红为止；重症灸至皮肤发白为止。如发生灸疮，可贴敷一般膏药。

治验：本人患有二十多年的慢性支气管炎，经用此方而治愈。

第二方 衡水县赵桥人民公社宋家村 宋瑞林介绍

主治：哮喘。

症状：咳嗽，气喘。

取穴：尺泽 列缺 崑崙 膻中

取穴法：臥位。男先取左，女先取右。

手法：用毫针捻转进针，膻中针尖斜向下方刺一至二分，列缺针尖斜向上刺四分，崑崙斜向前刺五分，尺泽直刺七分。膻中穴用平补平泻手法；其他穴位捻转提插均用泻法，留针一小时。每日针一次。

第三方 唐山市东矿区赵各庄联合診所 徐继介紹

主治：痰喘。

症状：喘息多痰，吐咯难出，胸悶气短。

取穴：肺俞(双) 陶道 膈俞(双)

手法：用毫針直刺陶道一寸，再針肺俞二寸。按天、人、地三部进針，刺入四至五分（人部）后，旋捻发生綫状感觉，再慢慢旋捻进至地部，发生的感觉与人部相同时停針；再針膈俞一寸五分，針法同肺俞穴。随将陶道針捻动，此时患者出現坐不稳、头晕，再捻肺俞，患者即有恶心欲吐之感，最后捻膈俞，患者立即将痰涎随呕吐而出，吐完后起針。針一次症状即減輕，甚至一、二年不喘。

按：此方据徐老先生介紹：系其早年用治癲狂，在初次应用于某病例时，針后即发生恶心，呕出大量痰涎，一次病愈。继而在几例癲狂病治疗中體驗本方效果不大，遂弃而不用。在治疗痰喘病中，使用一般治喘穴效果不大，忆及此法，用治痰喘，針下呕出痰涎甚多，一次喘平，二年未見喘发，效果卓著，遂推广此方。徐老先生并指出肺俞刺浅則无作用；然刺太深，势必穿透胸膜，刺中肺脏可能引起窒息或內出血。讀者使用本方时应注意以下几点：（一）症候适应，喘息有痰声，量多，或咯吐难出者。（二）体格較强健者。（三）針具：选用三十号以上毫針，針身光滑无痕者。（四）深度：应根据患者体质的胖瘦，深浅要适度（胖宜深，瘦宜浅）。（五）进針时应緩緩捻进，至发生一定感应即停針。（六）呕吐时注意护理，以免因剧烈运动而折針。

第四方 河北省中医研究院門診部 景象介紹

主治：哮喘。

症状：咳嗽，气喘。

取穴：膏肓(双) 天突

取穴法：仰臥位，先取天突。

手法：毫針与皮肤面呈四十五度斜角，徐徐捻进天突穴，針尖向下，深度一寸。发酸、麻、胀感觉后捻針，留針二十至三十分钟，疾出針；再掉轉体位灸膏肓穴，以艾卷灸三十分钟。

第五方 涿县涿鎮人民公社医院 史星三介紹

主治：哮喘。

症状：咳嗽，气喘，不能平臥。

取穴：主穴：公孙(双) 内关(双) 合谷(双) 足三里(双)

配穴：中脘 百会 崑崙(双)

手法：用毫針直刺公孙一寸，内关六至七分，合谷一寸五分，足三里、中脘各二寸，崑崙五分，百会沿皮向后斜刺二分。均捻轉提插与以强刺激，留針二小时。每日針一次，二次后改隔日一次。連針十次。

(公孙与内关，合谷与足三里輪換使用，前三次針治时，内关、公孙均同用)

禁忌：忌食葷、生冷及刺激性食物。

第六方 武清县河西务人民公社医院 潘庆奎介绍

主治：哮喘。

症状：咳嗽喘息有痰，春秋易复发。

取穴：喇嘛

取穴法：坐位。于肩贞、曲垣两穴中间微下二分处取之。

手法：用毫针捻转进针，刺入三至五分（视肌肉厚薄而定），后针尖向大椎方向捻进二寸五分至三寸。平补平泻，行三入九出手法（针向前推进三次，退后捻九次），留针三十分钟。隔日针一次。病重者，连针六次后即减轻；病轻者，三次后即减轻。

附注：刺喇嘛穴向大椎进针，针柄与皮肤面不超过十二、三度，勿刺入胸膜中，否则有危险。

治验：本县河西务扶头村薛××，男，五十三岁，农民。一九五九年三月来诊。主诉：“患喘息已二十余年，每年春、秋两季，感寒则发作，喘剧时卧床不安，食欲不振，气短，抬肩张口，痛苦不堪。”治疗：针中府一寸，列缺一寸五分，天突二寸五分，平补平泻，留针三十分钟。针后喘息较轻，经过针三次，则又不见大效；第四次治疗，取喇嘛穴，针入三寸，针锋向大椎穴推进，用三入九出及平补平泻手法，留针十五分钟。针后喘息大见减轻，隔日针一次，连针三次，喘止息平，痊愈。

第七方 天津中医学院附属医院 王绍中介绍

主治：哮喘。

症状：咳嗽喘息，不能平卧，吐痰，喉中有痰鸣。

取穴：主穴：天突

配穴：大杼(双) 风門(双) 肺俞(双) 丰隆(双)

手法：用三十号毫针刺天突穴，进针后针尖向下刺一寸，大杼、风門、肺俞各刺入八分，丰隆刺入一寸，向下方斜刺，用平补平泻手法，留针三十至六十分钟。出针后，除主穴外均以艾条灸十分钟。每天针灸一次，十次后隔日一次。每十次为一疗程。（配穴大杼、风門、肺俞輪流使用）

第八方 天津中医学院附属医院 王紹中介绍

主治：喘息。

症状：咳嗽喘，夜間不能平臥，吐痰，呼吸时喉間发痰鳴。

取穴：脊柱兩側，每側兩縱行常規刺激。胸椎兩側一至五椎，重點刺激，縱橫刺。腰骶部重點刺激，縱橫刺。氣管兩側及肋間隙縱刺。

手法：用七星針垂直彈刺，依取穴順序刺之，手法勿過強，以淺刺后皮膚面發紅點而不出血為適當。初治時每日針一次，十次后改隔日針一次。每二十次為一療程。

禁忌：避風寒及食刺激性食物。

治驗：（一）本市自來水公司劉××，女，二十六歲，職工。一九五八年十月來診，門診病歷九〇七〇號。主訴：“咳嗽，哮喘，呼吸困難，時重時輕，已二十年。”現症：咳嗽，喘哮，喉中痰鳴，呼吸困難，在總醫院、天和醫院檢查治療，診斷為由於神經過敏引起的喘息症。治療后，只解決一時的痛苦，不能根除，平日易發感冒，

夏天亦然，秋冬尤甚，喘息时痰结成白块，嗓子发痒，口发干，睡眠不能平卧。月经史：十一岁初潮，每月行经前易受感冒。食欲不振，大便正常。家族史：父患肺毒瘤故去，母及弟均有哮喘症。检查：体温三十六点六度，脉象沉细，舌苔白，一至八胸椎旁有索条状物，压痛。颈动脉搏动快。诊断：哮喘（支气管喘息）。处理：刺激神经疗法，刺常规脊椎两侧；重点，一至八胸椎旁、颈椎、气管旁，胸肋间隙，用弹刺、重刺手法。经治疗八次后，哮喘逐渐停止，至十六次后，哮喘消失。

（二）本市上海道市委大楼金××，男，一岁。门诊病历八六四六号。主诉（祖母代述）：“哮喘已十个月之久，患儿出生后一百天，因受风寒引起哮喘，痰多，喉鸣，呼吸困难。曾在儿童医院住院八个月，时轻时重，未能治愈，出院后仍喘息。”检查：发育营养中等，精神活泼，头、项、胸部无畸形，两侧对称；体温三十七点五度，脉象浮数，舌苔白腻，三至五胸椎旁有压痛。诊断：哮喘。处理：于一九五八年十月十一日开始治疗，用刺激神经疗法，常规，重点：胸一至五椎，胸肋间、颈椎、气管旁，用轻弹刺手法。经治疗三次后，夜间喘息未犯，但喉中仍有痰；第八次后，因天寒饮食不慎，虽发热，未见喘发，仅喉中痰多；十五次后哮喘消失。

第九方 石家庄市第二医院 高辅汉介绍

主治：喘息。

症状：支气管喘息，咳嗽多痰。

取穴：天柱 膻中 尺泽(双) 灵台

加减法：痰多者加丰隆(双)；虚咳无痰者加灸关元。

手法：用毫针直刺尺泽、灵台各五分，提插捻转，留针二十分钟。取丰隆时深刺一寸，手法同上。留针时间

取艾条灸两天柱、膻中、关元，灸至局部皮肤发紅为度。

治驗：本院李××，男，四十四岁，医师。一九五八年七月間因感冒引起喘息，曾服麻黄素及鎮咳止喘药无效。症状：喘息、咳逆、胸悶，仰臥时呼吸困难。既往：有肺病史。检查：脉象細数。經取穴尺澤、灵台、肺俞、内关、足三里，行平补平泻手法，并配灸天突、膻中。針后即覺胸膈舒暢，喘息停止，迄未复发。

第十方 新乐县医院行唐分院 张补才介紹

主治：气虚痰喘症。

症状：气喘痰鳴，喉中如水鸡声。

取穴：主穴：灵台

配穴：天突 膻中 膏肓 肺俞 足三里

手法：用艾卷灸法，灸至皮肤潮紅为度；每于天气将要寒冷时，灸之能預防痰喘发作。

治驗：本县行唐鎮王××，男，十七岁。主訴：“气喘痰鳴，每当感受寒冷时病即发作，經用中西药虽有效，但容易复发。”脉象浮紧，按之无力，診断为虛寒症。用艾卷灸法，灸第一次后，喘覺輕；三次痊愈，至今未复发。

第十一方 霸县后奕乡医院 錢沛介紹

主治：哮喘（实证）。

症状：咳嗽，喘息，多痰，感寒則发。

取穴：列缺（双） 絕骨（双）

手法：用毫針先刺列缺，进針后斜向上方捻入五分，絕骨

直刺一寸。用平补平泻手法，留针三十分钟。隔日针一次，一般三次即痊愈。

按：哮喘一症，有虚有实。实症：呼吸喘急，张口抬肩，痰液稠粘，发喘鸣，不能安卧，发作急，脉或浮，或迟，或数而有力；虚症：呼吸喘促困难，气怯慌张，声低息短，动则喘促气迫，脉弱无力。在病理方面，素问逆调论篇载：“不得卧而息有音者，是阳明之逆也。足三阳者下行，今逆而上行，故息有音也。”又载：“夫起居如故，而息有音者，此肺之络脉逆也，……”关于病候方面，灵枢经脉篇载：“肺手太阴之脉，……是动，则病肺胀满，膨膨而喘咳。……是主肺所生病者，咳、上气、喘、渴、烦心、胸满，……”“肾足少阴之脉，……是动，……喝喝而喘。”素问痹论篇载：“淫气喘息，痹聚在肺……。”从以上记载来看，哮喘的病候是发于肺、肾，由于足三阳经气逆而不下所致。上列十一方，治疗主要穴位，或在足之太阳、阳明，或在手太阴与足少阴，而间以它穴为配穴。所用穴位，符合原则。关于取穴部位方面，灵枢卫气失常篇载：“其气积于胸中者，上取之。积于腹中者，下取之。上下皆满者，傍取之。”在这个原则的基础上，结合古今经验效穴，如天突、灵台长于治喘；丰隆善于降痰，辨明虚、实、补、泻，则哮喘自无不愈。

八、梅核氣 (一方)

第一方 涿县新城第三医院 周成文介绍

主治：梅核气。

症状：喉中如有物塞，咽之不下，咯之不出。

取穴：天突 列缺(双) 照海(双)

手法：用毫针刺天突穴，进针后，针尖依胸骨向下迅速捻进一寸，列缺刺入三分，照海刺入四分。用平补平泻手法，留针三十分钟。

治验：褚××，女，十八岁。一九五九年七月十四日就诊。症状：喉中发闷，似觉有物堵塞，咽之不下，咯之不出，胸膈胀满，气不得下行。经用上述穴位治疗，四次即痊愈。

按：梅核气的症状，自觉喉中如有异物感觉，咽喉不利，吐之不出，咽之不下，有时似可咽下，但不久又觉升到咽喉间，有时咽间干痒或有痰不爽。检查咽喉不红不肿，亦无变形，所以叫“梅核气”。祖国医学对本病发生的原因，认为是七情所伤，气郁有以致之。盖气郁则津液不行，积而为痰，痰涎与气相搏，逆上咽喉之间，咯之不出，咽之不下，或因烦劳过度，抑郁伤肝，肝气上逆，状如梅核，咽喉为之不利。治疗应以开郁化痰。方中天突一穴属任脉，咽喉之上，取天突以化痰。千金载：“天突主喉鸣暴忤气噎。”灵光赋载：“治喘痰。”医学衷中参西录点本穴治痰，其法是点时屈手大指（指甲长须剪之），以指甲贴喉，指端著穴，直向下用力（勿斜向里）其气即通，指端当一起一点，令痰活动，兼频频挠动其

指端，令喉痒作嗽，其痰即出。照海穴：拦江赋载：“痰涎壅塞，咽干，……用三棱针刺照海出血，刻时安。”席宏赋载：“取百会、太冲、阴交，治咽喉痰。”列缺穴：甲乙经载：“喉痹，咳上气喘，……列缺主之。”拦江赋载：“痰涎壅塞咽干宜此。”根据这些文献的记载，该三穴实有开郁化痰之功，并通过治疗有效的病例，证明有效。如再加上疏肝理气的穴位，在临床上收到的效果，当更能令人满意。

九、腮腺炎 (共二方)

第一方 邯鄲市眼科医院 王順婉介紹

主治：急性腮腺炎。

症狀：发热，兩側或一側頰下肿胀。

取穴：翳風(患側) 頰車(患側) 合谷(雙)

加減法：发烧配少商(雙)，刺出血。

手法：用毫針速刺，捻轉進針。成人針一寸，小兒針五分。搗針瀉法，即速出針，不留針。另用艾灸。每日一次，以局部充血為止。一般二至三次即痊愈。

第二方 石家庄市井陘区医院 杜錦秀介紹

主治：扁桃體炎、腮腺炎。

症狀：咽喉紅腫疼痛，腮腺部紅腫。

取穴：耳部无名穴 少商

取穴法：耳壳外緣 用手摸有小疙瘩的地方，是无名穴。

手法：用三棱針点刺无名穴二、三分深，出血；然后再刺少商穴。患部在右边，刺左側；在左边，刺右側。一般二至三次即痊愈。

按：腮腺炎即“痄腮”。外科准繩載：“腮合发，肌肉浮而不着骨者，名痄腮。”中药治疗以解表清热、解毒消肿为主，如銀翹散、四順清涼飲、紫雪丹、清瘟敗毒飲、白虎湯等劑。針灸疗

法，取翳风、颊车、合谷、少商等穴，对于单纯性腮腺炎疗效显著。针刺时须注意手法的感应，如针合谷穴，手臂有麻木感；针翳风穴，全耳区有麻木感；针颊车穴，患侧颜面有麻木感。若无麻木感，用雀啄术或捻转术。针刺的深浅标准，使患者感到酸、麻、胀、重为度。

十、扁桃體炎 (共三方)

第一方 巨鹿縣醫院 段貴來介紹

主治：扁桃體炎。

症狀：紅腫疼痛。

取穴：天柱 少商 肝俞 啞門 百會 肩井
尺澤 肩外俞 十二井 人迎

手法：急性扁桃體炎用三棱針刺天柱、少商，出血，一至二次可愈；慢性扁桃體炎，用毫針刺肝俞、啞門（五分至一寸）、百會、肩井、尺澤、肩外俞等穴。用平補平瀉手法，留針三十分鐘。十二井穴，每次選用一穴，出血，隔日針一次，十數次即痊癒。

第二方 懷安縣懷安鎮 張九福介紹

主治：急性扁桃體炎。

症狀：咽下困難。

取穴：合谷

手法：用毫針直刺合谷穴五分深，不留針。針后用杏核半個，將仁搗碎，夾在杏核內，蓋在針眼上。稍停片刻，局部起泡，穿刺出黃水；然后用七星蜘蛛窩，貼在針眼上。一般一次即痊癒。

第三方 承德市医院 傅桂林介紹

主治：急性扁桃体炎。

症状：咽喉肿痛，扁桃体紅肿。

取穴：耳輪后緣(双) 少商，合谷

手法：用三棱針点刺耳輪后緣（从耳頸往上推見耳輪后微紅）出血，少商刺出血；用毫針重刺合谷，捻轉一寸深，留針十分钟。一般一次即痊愈。

治驗：用上述穴位治疗急性扁桃体炎多人，无不痊愈。一般針后十几分钟，咽喉疼痛消失，可以进飲食。

按：扁桃体炎，一般分为急性扁桃体炎和慢性扁桃体炎。急性的通常流行在春、冬两季，常見于一岁至五岁的儿童，主要由感冒所引起；恶性热性病、麻疹、丹毒等也是誘因，大都有传染性。本病針灸治疗，可以促进气血的运行，有解热、退肿的作用。上述三方采用各穴，主要以誘导疗法，为針灸的适应症。

十一、胃腸炎 (共七方)

第一方 武清县河西务人民公社医院 孙俊臣介紹

主治：呕吐。

症状：呕哕不止。

取穴：間使(双) 中脘 足三里(双)

手法：用毫針刺間使穴一寸，斜向上方进針，直刺中脘穴一寸，足三里穴針尖向下刺入一寸。用平补平泻手法，留針四十分钟。

第二方 薊县皇庄人民公社医院 白志清介紹

主治：急性胃炎。

症状：呕吐不止，口渴。

取穴：主穴：劳宮(双) 大陵(双)

配穴：内关(双)

取穴法：内关穴握拳取之。

手法：先以粗毫針直刺劳宮、大陵各五分，用泻法（大指向外捻为泻，向内轉为补），留捻十分钟出針；再直刺内关一寸，用补法，留捻十分钟。

附注：刺大陵、内关、劳宮宜用爪甲重切，避免刺伤筋、脉。

第三方 河間县行別营人民公社医院 葛詩泰介紹

主治：腹瀉。

症狀：飲食正常，每日大便排泄五、六次。

取穴：合谷(雙) 曲池(雙)

手法：用毫針刺合谷穴，向上斜刺一寸，曲池一寸二分。用平補平瀉手法，每五分鐘捻動一次，留針三十分鐘。一次即痊癒。

第四方 高阳县刘明庄人民公社医院 秦占魁介紹

主治：急性胃腸炎。

症狀：急性吐、瀉不止，腹痛。

取穴：人中 中腕 下腕 水分 天樞(雙) 氣海
內關(雙) 委中(雙) 陽陵泉(雙) 行間(雙)
十宣 足三里(雙) 太谿(雙)

手法：先用三棱針刺委中、十宣出血，再以毫針直刺人中三分，中腕三寸，下腕二寸，水分、天樞各一寸，氣海、內關各五分，陽陵泉一寸五分，行間、太谿各五分，足三里二寸。中腕用瀉法，足三里捻轉提插，使感應到上腹部，其他穴位用平補平瀉手法。除中腕、陽陵泉留針三十分鐘外，其餘穴位均留捻十分鐘。一次即痊癒。

治驗：本县大百尺乡刘名村王××，男，二十五岁，农民。患急性胃腸炎症，腹痛，吐瀉不止，小腿肚抽筋，厥逆无脉。按上述穴位治疗一次，腹痛、吐瀉均停止而痊癒。

第五方 围场县新建营子医院 齐广珍介绍

主治：急性胃腸炎。

症状：上吐、下泻，急性发作。

取穴：主穴：奇三穴

配穴：申脉(双) 金津 玉液 足三里(双)

内关(双) 合谷(双) 长强 涌泉(双)

取穴法：仰卧位，两足平伸。奇三穴在涌泉穴后二寸半，相当足底后三分之一中间稍偏内侧是穴。（男先刺左侧，女先刺右侧）

手法：奇三穴以毫针刺一寸五分，用三停九转法分三段进针（捻进五分后，停一呼吸将针捻动三下，再进入五分，捻针如上法，如此三次）。呕吐者刺申脉三分，金津、玉液刺出血，足三里直刺一寸，内关五分，合谷八分（手法同上）；泻重者刺长强一寸（针尖向上斜刺），涌泉五分，捻转不留针，其他穴位均留针三十分钟。如发生脱肛，针后用凤眼草煎水洗双脚，再以五倍子焙黄为细末，撒布上，以手托于肛门部，并以掌心熨之。

第六方 永年县南沿村医院 宋子笏介绍

主治：急性胃腸炎。

症状：上吐、下泻、腹痛，下腿转筋。

取穴：金津 玉液 中脘 天枢 承山

手法：用三棱針先刺金津、玉液出血，再以毫針刺中脘一寸五分，天樞一寸，承山八分。用輕刺激手法旋捻留針，并以艾条灸烤針柄，以腹痛停止为度。針后仍可用艾条灸中脘、天樞、承山，以提高疗效。

第七方 石家庄市第二医院 高輔汉介紹

主治：急性胃腸炎。

症状：煩心，呕吐，腹痛，腹瀉。

取穴：主穴：曲澤 委中 十宣 大聚泉

配穴：中脘 內关 足三里 天樞

取穴法：大聚泉穴在舌面正中。

手法：先以三棱針順序刺曲澤、委中、十宣、大聚泉出血（大聚泉穴处可乱刺出血），再用毫針刺中脘二寸，內关五分，天樞、足三里各一寸。用平补平瀉手法，留捻十五分钟，或待腹痛停止后出針。

按：急性胃腸炎，多在夏末秋初之际发生。其病因，乃由于风寒暑湿所感，飲食不慎，邪秽阻滯于中焦，清浊相干，胃腸机能失常所引起，而主要在于飲食失节。因其症状为上吐下瀉，所以叫假霍乱。針灸治疗先取十宣、委中、曲澤等穴，刺出恶血，以解散邪秽，气血可以通暢，再配合中脘、足三里、天樞、关元等升降降浊，調理胃腸。在針刺过程中，根据病情，随症配合他穴，如恶心呕吐者，刺金津、玉液，俱出血；呕吐兼瀉病者，刺委中、曲澤出血；出血后症未痊愈，再取中脘、天樞、关元、足三里，下腿轉筋，取承山、阳陵泉，并可在臍上紫筋处刺出恶血。如属寒症腹痛不止，取气海、关元、三阴交、天樞、足三里等穴。

十二、胃十二指肠溃疡 (共七方)

第一方 邯郸市马头镇卫生院 徐范孔介绍

主治：胃溃疡。

症状：食后胃部疼痛，嗳气吞酸，呕吐或呕血，间歇发作。

取穴：风池(双) 大杼(双) 膈俞(双) 鸠尾 关元
气海 尺泽(双) 内关(双) 大陵(双) 章门(双)
上腕 巨阙 足三里

手法：用毫针捻转进针。风池、大杼、膈俞针尖向外斜刺五至八分，行雀啄术留针；鸠尾针尖斜向下方刺八分至一寸，行提插法(多提少插，提四下插两下)；关元、气海各针入一寸，行补法(多插少提)。针至四次症状减轻，但觉胸部不适时再取尺泽、内关、大陵各刺五分，章门、上腕各刺一寸，仍用补法，至发生感应后，留针三十分钟，隔日针一次。针后上腕、巨阙穴用拔火罐。

禁忌：忌用生冷及不易消化食物；宜吃软性流质食物。

第二方 张家口市桥西区人民医院 庞汉卿介绍

主治：胃溃疡。

症状：胃脘压痛，消化不良，噎气，反酸，腰痛，头前痛。

取穴：内关(双) 照海(双) 公孙(双) 脾俞(双)
胃俞(双) 足三里(双) 肩井(双) 申脉(双)
中脘 下脘 阿是(以上各穴輪換应用)

手法：用毫針直刺内关、足三里各一寸五分，照海、公孙、脾俞、胃俞各五分，肩井二寸，申脉五分，中脘、下脘各二至三寸。用平补平泻手法，每日針一次。

第三方 涿县涿鎮人民公社医院 史星三介紹

主治：胃潰瘍。

症状：噯气吞酸，胃部疼痛，食后即吐。

取穴：内关(双) 公孙(双) 上星 百会 中脘
足三里(双)

手法：用毫針捻轉进針。百会向上斜刺二分，内关五至六分，公孙一至一寸五分，上星一分，中脘二寸，足三里三寸。以上穴位均行直刺，用泻法(男子大指向前捻为泻法，向后捻为补法，女則相反)，留針三至四小时。初針时一日一次，連針三次，改为隔日一次；針五至六次后，再改为二日或三日一次。初起，針二、三次后吞酸、呕吐即止，一般病症針三至十一次即痊愈。

治驗：(一) 本县梁家村鵬××，男，四十四岁。患胃病已十三年之久。症状：噯气吞酸，胃疼，食后即吐。診斷为胃潰瘍。用上述穴位治疗，針十一次即痊愈。

(二) 本县西高庄刘××，男，五十岁。患胃病已有二十五年之久。一九五九年六月就診。症状：噯气吞酸，胃部疼痛，食后即

吐。取上述穴位，另加天枢穴，共針十八次，症状完全停止；唯阴天时感觉胃部不适，現仍在治疗，每隔五、六日針一次。

第四方 张北县西大淖人民公社卫生院 李潤德介紹

主治：胃潰瘍。

症状：胃疼，牽引腰背疼痛，吐酸水，烧心，空腹时尤甚，有时心窝部膨胀，大便时燥时稀。

取穴：中脘 足三里(双) 三阴交(双) 太白(双)
大都(双)

手法：用毫針捻轉进針，用平补平泻手法，留針一小时；針后用艾灸五至十分钟。隔日針灸一次。

禁忌：忌生冷及有刺激性的食物。

治驗：(一) 本县工商联孙××，男，三十岁。主訴：“心窝部疼痛，空腹时尤甚，少进飲食其疼暫止，腰背亦痛。一年前有胃出血病史，大便时燥时稀，多食則膨胀，經常烧心，时有失眠。”經保定市医院診斷为胃潰瘍，久治未愈，后用針灸治疗。取穴足三里、中脘、三阴交，并用艾灸。共針三次，灸九次痊愈。

(二) 张北县县委徐××，男，三十二岁。主訴：“患胃病，經常胃疼吐酸，食后胀滿，牽引腰背疼痛，經张北县医院診斷为胃潰瘍，曾用鎮疼药未效。”取穴中脘、足三里、太白、大都，并用灸法。共針灸三次，痛止而痊愈。

(三) 本县黄盖庄水庫李××，男，三十五岁，工人。自訴：“患胃疼已二年余，胃部有发烧感，吐酸水，有时吐血，飯后腹肌胀痛，曾多方治疗无效。”取穴足三里、中脘、太白、大都，并用灸法。共針灸四次，配合服中药四剂痊愈。

第五方 正定县青同人民公社医院 傅嗣霞介绍

主治：慢性胃溃疡。

症状：胃脘部经常疼痛，吐酸，食物常常呕吐，便秘。

取穴：主穴：上脘 中脘 承满(双) 梁门(双)

气海 天枢(双) 内关(双) 足三里(双)

三阴交(双) 上巨虚(双) 脾俞(双) 胃俞(双)

配穴：下脘 大横(双) 肾俞(双) 大肠俞(双)

合谷(双) 行间(双) 关元 照海(双) 太白(双)

手法：用毫针缓缓捻转进针，用平补平泻手法。腹背部穴用轻刺重灸法（艾炷灸十五至二十分钟）；四肢穴不用灸法。

禁忌：忌生冷、不易消化及有刺激性的食物。

治验：本县青同人民公社西青同村郑××，男，五十五岁。主诉：“患胃溃疡多年。胃部经常疼痛、吐酸，食入即吐，便秘，于一九五七年病情加重，疼痛难忍晕倒在地，六、七日不进食物，这样持续有三月之久。”用针灸治疗，取穴上脘、中脘、承满、梁门、气海、天枢、章门、足三里、上巨虚、三阴交、脾俞、胃俞等为主穴，配用肾俞、大肠俞、下脘、大横、合谷、二间、行间、关元等穴，并用灸法。隔日一次，共针灸十余次即痊愈。

第六方 蔚县大王城人民公社医院 王明业介绍

主治：胃病。

症状：上腹部有硬块，胃脘阵发疼痛，恶心呕酸，胸腹烦满，心烦，后腰背部有放射痛。

取穴：主穴：阳陵泉(双) 中脘 关元

配穴：巨阙 天枢(双) 气海 膏肓(双)

大腸俞(双) 建里 膝阳关(双)

手法：用毫針直刺阳陵泉二寸，中脘三至五寸，关元三至五寸。心煩，刺巨阙四至六寸；呕吐，刺天枢二寸，气海二寸；脘腹痛，刺膏肓五分至一寸，大腸俞五分至一寸，建里四寸，膝阳关五至八分。（各穴位深度，視患者体格强弱的定）用平补平泻手法，留針一至二小时。每日或隔日針一次。

第七方 张家口铁路医院 张惠珍介绍

主治：十二指腸潰瘍。

症状：上腹部不适，噯气吞酸，空腹时心窝部疼痛，向右侧臥則痛剧。

取穴：第五至十二胸椎旁兩側，局部胃区；第五胸椎至第九胸椎旁开一寸五分的纵綫上压痛点为重点。

手法：用梅花針或七星針先打刺第五至十二胸椎兩側纵刺；再纵横各三排打刺胃区，在第五胸椎至第九胸椎兩側綫上的压痛点处应多刺。彈刺叩打以皮肤潮紅为度，勿使出血。每日針一次，数十次即痊愈。

按：（一）梅花針一般背部操作方法，是先从第一胸椎至腰骶，横行叩打，用“正刺法”（針面与皮肤面垂直接触，不可偏斜，下針要平，起針要快，不可拉破皮肤，叩打时要运用腕力）。

正刺法完毕后，再自第一胸椎至腰骶直行，由上而下行“平刺法”

（針面与皮肤面約成四十五度角，在皮肤表面輕輕划過，不可用力，在正刺后大多要平刺）。一般可自第一胸椎至第一腰椎为一区，先行叩打完毕，然后再自第一腰椎至骶部止为第二区，分二次先后进行叩打。但一般应根据与疾病有关的部位以及麻痺区、压痛点等部位，重复进行“重刺”或“密刺”。每次治疗時間，以不超过十五分钟为度。

胃痛、胃潰瘍、胃下垂等在第五至十二胸椎区，或配合前額、后脑、上腹等部行針刺，背部痛点处应多刺較為妥當。

（二）消化性潰瘍，是常見的疾病之一。中医書籍內沒有这个病名記載，在临床上所謂“胃脘痛”、“心痹”，以及其他各种“心痛”，如“胃心痛”、“肝心痛”等，都包含着本症在某种不同阶段的症候。其成因与吃刺激性食物有关，但与精神上的长期刺激与紧张有密切的关系。如隋、巢氏病源心痹論条載：“思慮煩多則伤心，心虛故邪乘之，邪积而不去，則時善飲食，幅幅而海，蘊蘊而痛。”清、叶天士医案中关于消化性潰瘍的症狀統称之为木克土，如“情志不遂，肝木之气逆行犯胃”等，強調本症的发生是不利的外界影响。因此，中医治疗本症除直接作用于胃外，并着重柔肝、平肝、疏肝等法，剧烈疼痛时以通降止痛。針灸治疗是以鎮痛、止血为目的，調整胃的分泌机能，旺盛胃的新陳代謝，促进潰瘍的自然治愈的机能，而减少胃酸过多的分泌以奏效。因此，一般以循經取穴原則，在足陽明胃經，取足三里、承滿、梁門、天樞、下巨虛穴。又因为胃的部位与其他經絡有直接关系，所以又取足太陽膀胱經的大杼、膈俞、膏肓、大腸俞、脾俞、胃俞、上星等穴；任脉中的鳩尾、关元、气海、三脘、巨關、建里等穴；足太阴脾的三阴交、公孙穴。这些穴位配伍的应用，对于消化性潰瘍都是疗效卓著的。以上七方虽然用穴的多少不同，采取穴位各异，但都是本

着与胃有关的經絡进行治疗的，因这些穴位亦是治胃腸疾患的要穴。

1.足三里：为足阳明之合穴。甲乙經載：“胃病者，腹脹，胃脘当心而痛，……取三里。”“腸中寒，脹滿善噫，……腹痛泄，食不化，心下脹，三里主之。”外台秘要載：“胃气不足，腸鳴腹痛，心下脹，三里主之。”針灸大成載：“心腹脹滿，卒心痛，腹痛食不下，三里主之。”近代对于消化不良、胃痙攣等均取足三里。

2.承滿：千金載：“主脇下堅滿痛。”銅人載：“治腸鳴腹脹，上喘气逆，食飲不下，肩息唾血。”

3.梁門：圖翼載：“飲食不思，……大腸滑泄，完谷不化。”凡屬各种胃病，食欲不振，消化不良，均可取之。

4.天樞：甲乙經載：“腸脹腹鳴，……胃腸游气切痛，食不化，不嗜食，……天樞主之。”千金載：“吐血，腹痛雷鳴，灸天樞。”

5.脾俞：“……脇痛腹脹，胸脘暴痛，上气。”外台秘要載：“腹中气脹，引脊痛，脾痛欲呕。”針灸大成載：“腹脹引胸背痛，不嗜食。”凡胃弱、胃痙攣、消化不良均主之。

6.大腸俞：千金載：“腹中雷鳴，腸澼下利，食不消化，小腸絞痛，腰脊疼強，大小便难，不能飲食……。”

7.胃俞：甲乙經載：“胃中寒脹，食多身体羸瘦，腹中滿而腸鳴，呕吐食不下。”針灸大成載：“翻胃呕吐，不嗜食，腹痛，胸脇支滿。”

三脘穴为治胃病的要穴，其他关元、气海、三阴交均为有名的要穴，有强壮作用。上述各方的治疗，在治疗中都占有較为重要的位置，因此对消化性潰瘍能收到滿意的效果。

十三、便 血 (共三方)

第一方 张家口市宣化医院 薛孝先介绍

主治：大便下血。

症状：便血，脱肛，颜面黄白贫血，倦怠，食欲不振。

取穴：长强 会阳(双)

取穴法：伏臥位。会阳在下髂穴下五分处。

手法：用毫针刺长强穴一寸，进针后针尖向上，会阳穴刺八分，捻针使达到酸、麻、重、胀感觉出针。每周刺二至三次，须治疗一至二周。

治驗：采用上述穴位治疗便血二十一例，疗效为百分之百。仅举一例如下：

龙烟钢铁公司职工学校高××，男，二十七岁，学员。主诉：“患大便下血，脱肛已有三月余，每值大便则直肠脱出约二寸许，疼痛下血，每日一至两次，倦怠乏力，食欲不振。”既往曾患过慢性腹泻，病程二年余。检查：颜面黄瘦，有失血病容，脉弦缓兼滑，舌淡，印象为气虚便血脱肛病。经刺长强、会阳两穴，共治疗两周，每周三次。第一周脱肛腹泻减轻，第二周后血止而痊愈。

第二方 怀安县周家河卫生院 王敬书介绍

主治：大便出血。

症状：大便前后皆出血，血色或红或紫，头眩晕。

取穴：下脘 关元

手法：用毫針捻轉直刺下腕二寸五分，关元三寸。用补法，留針一小时，一次可痊愈。

第三方 靜海县流河人民公社卫生所 邓文礼介绍

主治：便血。

症状：大便带血，鮮紅色或血块，小腹疼痛，心中煩热，脉洪大有力。

取穴：曲澤 阳池 大陵（用一側）

手法：用二十八号毫針，捻轉刺曲澤八分，大陵五分，阳池五分。用赤风摇头法泻之（用針之时如手搖鈴状，进退左右搖而振之，进慢，退速），留針十分钟。

按：便血症，祖国医学分为两种类型，有腸风、有脏毒。东垣十书记載：“……腸胃不虛，邪无从而入，惟坐臥风湿、醉、飽、房劳、生冷停寒、酒面积热，以致荣血失道，滲入大腸，此腸风、脏毒之所由作也。挟热下血，清而色鮮，腹中有痛为腸风；挟冷下血，浊而色黯，腹中略痛为脏毒。先便而后血，其来远，先血而后便，其来近，……”。关于治疗方面，医学綱目記載：“腸风下血，取三間、商阳、大陵、内关、命門、承扶。”“下血灸命門，与臍对灸七壮，即止。”“下血灸脊中第二十椎下（腰俞上一寸处），随年壮。”又古今医统載：“百劳灸二、三十壮，断根不发。下血，脉虛涩，非腸风、脏毒也，灸中腕、气海二穴。凡脱血，面色白，脉濡，手足冷，飲食少思，强食即呕，宜灸之，效如神。”又如明代高武針灸聚英記載：“刺长强与承山，善主腸风新下血。”从以上記載来看，古人經驗是非常丰富的。本症只选輯三方，故择录补充，供讀者参考选用。

十四、五更瀉 (共二方)

第一方 交河县寺門村乡医院 董紹卿介紹

主治: 五更瀉。

症状: 每在天将明时, 大便泄瀉一次。

取穴: 照海(双)

手法: 用毫針刺照海穴二至三分, 留針三十分钟, 在留針時間將針捻轉二次。每日或隔日針一次。

第二方 任丘县鄭州医院 刘森銓介紹

主治: 五更泄。

症状: 习惯性夜半后腹瀉。

取穴: 主穴: 照海(双) 百会 命門 腎俞(双)

三阴交(双) 足三里(双)

配穴: 天枢 (双) 关元 水道(双) 归来(双)

大腸俞(双) 脾俞(双) 中脘(双) 次脘(双)

(以上配穴可选择使用)

加減法: 心虛、夜寐不安, 加神門(双)、內关(双)。

取穴法: 照海穴在內踝下微前一分, 緊靠內踝邊緣。

手法: 用毫針刺照海穴, 向丘墟方向針入三至五分, 三阴交刺入五至八分, 足三里針八分至一寸二分。用补法(大指向后, 食指向前), 徐徐捻搦, 以达到酸、

麻感或針下有溫熱感為度，留針三十至六十分钟；出針后再灸百會、腎俞，灸至皮膚灼紅為止。每次除主穴照海、三陰交、足三里針后加灸外，其他配合用穴，均只灸不針，可選擇配用。

禁忌：忌用生、冷食物。

治驗：（一）本縣鄭州劉××，女，四十二歲。門診病歷一八號，一九五九年一月來診。主訴：“自一九五七年十月間發病，腰痠、腹痛，兩肋及少腹每午後經常發脹，腰、背發涼，兩足脛以下冰冷，每逢夜間十二點至兩點的時間內，必須大便一次；每夜如是，至為苦惱。迄今已十三個月，經中、西醫診治未效。”既往病史：胃弱、消化不良，月經有時不正常。診斷：體質營養中等，精神不振，有慢性病容，兩尺脈沉遲無力，寸關脈無異常，舌苔色淡而滑潤。印象：腎氣不足，命門火虛，病在脾、腎。治療：經用上述穴位針灸五次，泄止諸症消失，痊愈。

（二）本縣塔庄郝××，女，四十九歲。門診病歷四號，于一九五九年一月來診。主訴：“患五更泄已五個多月，腰痠、腹痛，四肢無力，夜間不能安臥。”檢查與第一例大致相同，惟兼心臟衰弱。遂依上方加取內關、神門，計針灸六次，入夜睡眠轉好，腹泄停止，痊愈。

按：五更泄乃“腎泄”的別名，為慢性腹瀉之一。祖國醫學文獻中多有論述，諸家均說命火衰微，脾、腎功能失職，以其久泄必虛，所以在治療上不論藥物、針灸，均以溫補腎、命，調脾胃為主。此方針灸并用，而灸多于針，取虛者補之，寒者溫之，以久泄傷陰，故取穴腎俞、命門、三陰交為主，以脾俞、足三里為配，兼取下焦穴位以調之，更取百會以振奮陽氣，相助為功，則陰陽兩得其平而疾愈。

十五、便秘 (共二方)

第一方 正定县南青铜人民公社医院 傅嗣霞介绍

主治：习惯性便秘。

症状：大便经常干燥，排便不畅，腹胀。

取穴：主穴：章門(双) 照海(双) 太白(双)

配穴：中脘 梁門(双) 上脘 气海 内关(双)

三阴交(双)

手法：用毫针捻转进针，刺章門八分至一寸，照海五分，太白三分，以发生感应为度，留针十至二十分钟。配穴中脘可刺一至二寸，梁門、上脘、气海各一寸，内关五分，三阴交五至八分。各穴均用平补平泻手法，针后以艾条灸之。隔日针灸一次，倘系热结则针后不灸。

治驗：本县栗青铜村王××，女，六十四岁。一九五五年患习惯性便秘。胃区胀满，两胁疼痛，食欲不振，已经久治未愈。按上法治疗三次痊愈。

第二方 滄县中医学校 顾炳熙介绍

主治：便秘。

症状：伤寒后期发生的便秘。

取穴：支沟(双) 照海(双)

手法：用毫針刺支沟五分至一寸，照海三至五分。用左右捻轉平補平瀉手法，以得氣為度。留針三十分钟。

按：本方治療熱性病後期的便秘，取支沟、照海兩穴以通便。支沟為三焦脈的經穴，別名飛虎；照海為陰躁脈之所生。此兩穴相配治療便秘，歷代文獻中有很多記載。如醫學綱目載：“大便秘澀，照海五分，補二呼瀉六吸，立通；支沟半寸，瀉三吸。”扁鵲玉龍歌：“大便秘結不能通，照海分明在足中，更把支沟來瀉動，方知妙穴有神功。”在手法方面，可根據靈樞經脈篇“盛則瀉之，虛則補之，熱則疾之，寒則留之，陷下則灸之，不盛不虛以經取之”的原則，適當運用。上列第一方取穴，亦用照海，並配以章門、太白、氣海、內關、中脘等穴，效果當能更好。惟現有腹脹，則足三里亦當取用。

十六、脱肛 (共二方)

第一方 唐山市第二医院 张立群介绍

主治：脱肛。

症状：直腸脱出，不能自收。

取穴：百会 长强

手法：用毫针刺百会穴，进针后沿皮向后刺入一寸；长强向上斜刺一寸。用慢提紧插手法，留针二十至四十分钟。每两天针一次。

禁忌：针后避免劳碌及食刺激性食物。

第二方 曲周医院 李成秀介绍

主治：脱肛。

症状：大便时直腸头突出，甚者平时亦不能收回。

取穴：长强 百会 承山 气海

手法：先仰臥，用毫针刺气海一寸，捻进捻出，用平补平泻手法，不留针；针后加灸，以皮肤发紅为度。后再轉变伏臥，针长强五分，百会沿皮向后刺五分，承山直刺一寸，留针二十分钟。隔日一次，一般十次左右即痊愈。

按：脱肛一症，凡老人气血已衰、小儿气血未壮及产后久痢或便秘等，都能导致本症的发作。不論何种誘因，总由气虛所致。

大腸与肺相表里，肺蘊热則肛閉；虛則肛脫。因此在治疗上应采用升补固脫的方法。上述两方的取穴，都以长强、百会为主穴。长强为足少阴、少阳之会，能收縮肛門之括約肌；百会为手足三阳督脉之会，有升阳补气的功能；至于配承山、气海等穴，有促进直腸迅速收縮的功能。

十七、遺尿尿閉 (共十五方)

第一方 東鹿縣范家庄人民公社醫院 秦起波介紹

主治：夜尿症。

症狀：夜間尿床。

取穴：腎俞(雙)

手法：用毫針直刺腎俞八分，弱刺激，不留針。

治驗：(一) 本縣范家庄趙××，女，十五歲。家庭病史：其母有較嚴重的心脏病及常習性腹瀉，父無它疾。本人無其他疾患，但每夜尿床一、二次。診為夜尿病。按上法取穴治療，針二次後夜間尿床減少；四次後夜有尿即醒；六次已獲痊癒。

(二) 本縣北五井村謝××，男，十六歲。家庭病史：兩世遺傳夜尿病。症狀：每夜尿床數次，用上法取穴治療，三次後尿的次數減少；五次後到天明只有一次尿床；針六次後，隔了一日未尿；八次即完全不尿床。

第二方 唐縣高昌廟鄉庄立村 王洛然介紹

主治：小便失禁。

症狀：小便不自覺的經常滴滴不斷。

取穴：大敦(男取左側，女取右側)

手法：用毫針直刺大敦穴一分，捻轉進針，大指向前，留針半小時。

治驗：經治三例，皆針一次痊癒。

第三方 唐山市东矿区古林联合診所 李玉良介紹

主治：遺尿。

症狀：夜間尿床。

取穴：三陰交(雙) 關元

手法：用毫針直刺三陰交八分，關元一寸五分。慢捻進針，慢捻出針，用平補平瀉手法，留針二十至三十分鐘。隔日針一次。

治驗：應用上述穴位治療四例（其中一例已遺尿十八年），皆已痊癒。一般一至三次見效，五至六次痊癒。

第四方 鹽山縣慶雲鄉玉皇崖衛生所 張金銘介紹

主治：遺尿症。

症狀：夜間遺尿或日間尿失禁淋漓自下。

取穴：主穴：腎俞(雙) 膀胱俞(雙) 關元 氣海
中極 三陰交(雙)

配穴：八髎(雙) 大腸俞(雙) 小腸俞(雙)
足三里(雙) 大敦(雙) 命門 涌泉(雙)

手法：上述穴位每次選用三至六個，用毫針捻轉進針，須辨症使用不同手法。虛者用補，實者用瀉。補針輕輕旋捻，三進一退，由淺而深，至有酸、麻感；瀉法一進三退，由深而淺，至有酸、麻感。留針十五至三十分鐘，徐徐出針。虛症針後加灸。每日或隔日一次，五次為一療程。

附注：施术前令患者排尿，穴位要严密消毒，腹部穴位针刺不宜过深，以免伤及膀胱。

治驗：用上述穴位共治疗十二例，治愈率达百分之九十以上。虛症多于实证，以針灸并用收效迅速。茲举典型病例介紹如下：

(一) 本县和尚村高××，女，四十七岁。因受惊致病，初时。仅在精神激动时小便失禁，继在劳动时則尿液自流，常用丁字带垫厚布于裆中，日易数次。經針灸一次显著減輕，三次即恢复正常。为巩固疗效，三日后复針一次，經九个月后观察无复发。

(二) 本县城內陈××，男，十岁。自幼患夜尿，每夜数次。年岁稍长，虽次数减少，但每夜仍遺尿。經針灸一次痊愈。

第五方 河北中医学院西医学习中医班介紹

主治：遺尿症。

症状：儿童睡眠后遺尿。

取穴：长强 曲骨

手法：用毫針捻轉进針。长强針向上方刺入，深度一至二寸五分，左右旋捻，使感应直达十六椎处。曲骨穴进針后，深度掌握在五分至一寸五分之間，找到感觉使达于阴器周围。二穴均用补法，留針十至二十分钟。隔日針一次。

附注：术前先排尿。

治驗：本症使用上述穴位共治疗十三例，其中痊愈十一例，二例好轉。茲举一例介紹如下：

李××，男，十岁。門診病历九五八号。主訴：“自幼即有尿床习惯，每夜多至五、六次，以往未經過治疗。”經用上述穴治疗

二次，痊愈。

第六方 唐山市卫协第二医院 张立群介绍

主治：遗尿。

症状：年老体衰，昼夜多尿或遗尿。

取穴：主穴：关元 中极 气海

配穴：足三里(双) 复溜(双) 太谿(双)

加减法：第一次主穴减中极加配穴复溜；第二次主穴减关元加配穴太谿；第三次主穴减关元、中极加配穴足三里。

手法：用毫针捻转进针。关元、中极直刺二寸，气海、太谿、足三里各一寸五分，复溜二寸，用慢提急插手法三次，留针三十分钟。每两天针一次，三次即痊愈。

附注：针后静养，勿过劳。

第七方 天津中医学院附属医院 王绍中介绍

主治：遗尿。

症状：睡眠中排尿不知，忽而遗出。

取穴：刺常规，重刺腰骶部，再刺下腹、腹股沟及耻骨联合部。

手法：用梅花针弹刺冲力，顺序垂直刺激以上部位，手法要稍重，以不出血为度。隔日针一次，十次为一疗程。

治驗：（一）本市和平区大理道十三号陈××，女，七岁。門診病历一一三三九号。主訴（母代訴）：“遺尿已經七年，每夜遺尿三次，甚至午睡時間过长亦发生遺尿，平时十至十五分钟即小便一次。曾經西医检查无器质性病变，认为系神經性夜尿症。”現在症状：食欲不振，大便正常。既往症：时常咳嗽。检查：脉象沉細，舌苔白，骶椎旁有痠感。診斷：遺尿症。治疗：用刺激神經疗法，刺常規（脊柱兩側），重点：腰骶、下腹、腹股沟。用彈刺手法輕刺。治疗經過：患儿于一九五九年六月十一日来門診治疗，共針治十一次。在第三次治疗后，排尿間隔時間延長，中間曾有一次尿床，每夜能自醒撒尿；于第八次治疗后，未发生尿床；一月后訪問，未复发。

（二）本市和平区錦州道七十二号邹××，女，八岁。門診病历九九二七号。主訴：“患夜間遺尿已一年，每周只有一二夜不尿床，曾做过一次針灸治疗，未收到效果，飲食、二便均正常。”既往症：无其他疾病。检查：脉象細緩，舌苔白。診斷：遺尿症。刺气海五分，关元五分，三阴交一寸，用提插补瀉法，留針十五分钟；針后气海、关元以艾条灸十五分钟。治疗經過：患者于一九五九年四月二十五日来門診治疗，共針七次。在治疗第三次后減輕，七次后痊愈。

按：本方所附治驗第二例，取穴、刺法均与主方不同，但因治疗的主症相同，故并存之，供讀者参考。

第八方 徐水县医院 张仲奎介紹

主治：遺尿。

症状：夜間尿床。

取穴：腎俞(双) 气海 关元 三阴交(双) 中极

手法：用毫針旋捻進針，直刺腎俞五分至一寸，用平補平瀉手法，找到感應出針；再刺氣海、關元、中極各一寸，三陰交五分。氣海用補法（順經捻轉），其餘各穴均用平補平瀉手法，至發生酸、麻感應後，留針二十分鐘。隔日針一次。愈後可再針十二、三次，以巩固療效。

第九方 天津市河東區大直沽門診部 楊秀峰介紹

主治：尿頻數。

症狀：小便頻數，下腹部墜脹。

取穴：曲骨 關元 中極 水道(雙)

手法：用毫針捻轉進針，直刺曲骨二寸，關元、中極各一寸，水道二寸。進針後用平補平瀉手法，留針一小時。在留針時間內捻轉一次，使感應達于外陰部。

每日或隔日針一次。

治驗：（一）本市棉紡一廠朱××，女，二十一歲，工人。患小便頻數，治療月余未效。一九五九年二月一日開始針灸治療，取穴曲骨、關元、水道，用平補平瀉手法，留針三十分鐘。連針二次，痊愈。

（二）孫××，女，五十九歲，家庭婦女。主訴：“因家務過勞，復感風邪引起小便頻數，少腹時墜痒而引起排尿感，頻頻入廁，患者甚感苦惱。”一九五九年三月三日開始按上述穴位針治，一次後，尿意頻發停止；第二次少腹墜痒感消失；第三次巩固治療，經觀察痊愈。

第十方 天津市建国道門診部 刘文泉介紹

主治：膀胱麻痹症。

症状：尿失禁。

取穴：关元 足三里(双) 三阴交(双)

手法：用毫針直刺关元二至三寸，用強力搗針手法，使感应到外阴部即留針；再刺足三里一寸，三阴交五分。用平补平泻手法，至发生感应后同时去針。每日針一次，四、五次即痊愈。

治驗：(一) 张××，男，二十八岁。主訴：“每日尿液淋漓。”

診斷：外伤性膀胱括約肌麻痹。治疗：取穴中脘、关元、足三里、三阴交。用烧山火手法，留針五十分钟；关元灸二十分钟。共針灸五次痊愈。

(二) 本市清和街向阳里一号賈××，男，五十五岁。門診病历一九五六号。主訴：“經常遺尿。”診斷：小便失禁。治疗取穴及手法与第一例相同。共針灸六次痊愈。

(三) 本市进步道团结西胡同七十一号赵××，男，六十岁。門診病历四七九〇号。主訴：“經常遺尿。”診斷：小便失禁。治疗依上法取穴，用烧山火手法，留針五分钟；关元灸二十分钟。共針灸十次痊愈。

按：烧山火，系三衢楊氏补泻手法之一。針灸大成記載：“烧山之火能除寒，一退三飞病自安，始是五分終一寸，三番出入慢提看。”“凡用針之时，須捻运入五分之一中，行九阳之数，其一寸者，即先浅后深也。若得气便行运針之道，运者男左女右，漸漸运入一寸之内，三出一入，慢提紧按，若覺針头沉紧，其插針之时，热气复生，冷气自除，未效依前再施。”其操作方法是：俟患

者呼气进针，刺入全深度的三分之一；捻转使发生感应，再急进针三分之一；捻转加大感觉，再将深度的最后三分之一刺入。慢提、急按，上下提插几次，向一侧捻转固定，随捣刺即可生热，并应使热感扩散到患部或更远一些为度。此法适应于一切寒性症，如瘫痪的患侧或顽麻、冷痹的局部刺激，可以重复使用。

第十一方 深县李仁村 吴振江介绍

主治：尿闭。

症状：小腹胀满，有尿排不出来。

取穴：曲骨

手法：用毫针直刺，捻转进针。刺一分后停止捻转，咳嗽三声，即能排尿，尿后起针。

附注：此法适用于突然尿闭，效果很好；若时间较长或病势严重，则疗效较差，当配合其他疗法。

第十二方 石家庄第二医院 李曾树介绍

主治：尿闭（有火尿闭）。

症状：下腹不胀满，欲溺又不能排出。

取穴：气海 关元 阳陵泉 足三里

手法：用毫针，各穴均针五至六分，捻进捻出，用平补平泻手法，气海、关元留针二至三分钟，阳陵泉、足三里留针五至六分钟。一般针后三十分钟至二小时即能排尿。

第十三方 蕪县医院 呂耀先介紹

主治：尿閉。

症状：膀胱有尿，排不出来。

取穴：男取气海 水道 女取中极 水道

手法：用毫針直刺一寸至一寸五分，捻进捻出；气海和中极捻轉到感应至阴器为止，留針三十分钟。一般針后三、五分钟即生效。

第十四方 武清县河西务人民公社医院 李贊襄介紹

主治：尿閉。

症状：小便不通，小腹胀滿，痛苦难堪。

取穴：中极 阴陵泉 涌泉 照海

手法：用毫針直刺中极一寸五分，阴陵泉五分至一寸，涌泉五分，照海五分。均用平补平泻手法，留針十至三十分钟。

治驗：本县王庆坨村蔣××，男。患尿閉，腹胀如鼓，痛苦号叫。当时針刺中极，針后患者自觉有气下达阴茎处，随即下小便少許；复針阴陵泉、涌泉、照海穴，均用平补平泻法。当即小便暢通，尿閉霍然而愈。

第十五方 涿县涑水第二医院 王升介紹

主治：尿閉。

症状：小腹如鼓，胀痛，尿不能排出。

取穴：曲骨 中极 气海 三阴交(双)

手法：用毫针刺曲骨穴一寸，中极针入五分后将针柄靠近关元穴，针尖向曲骨捻进一寸至一寸五分，气海、三阴交各针一寸。各穴均用平补平泻手法，留针十至十五分钟。出针后以艾条灸上穴，灸至皮肤微红为度。

按：以上十五方，都是泌尿系疾病，病因虽然很多，基本原因由于膀胱经、肾经疾患所引起。素问宣明五气篇载：“……膀胱不利为癃，不约为遗溺……。”奇病论篇载：“有癃者，一日数十溲，此不足也……。”都扼要地说明遗尿、尿失禁、尿频数、尿闭等泌尿系疾病在于膀胱腑，故在治疗上除膀胱局部取穴，通过任脉诸穴，直接刺激；或在足太阳经腰骶部取穴，间接以促进膀胱功能的作用。按肾主二阴，与膀胱相表里，故治疗尿闭或遗尿等症，以肾与膀胱两经为主。任脉主一身之阴，纵贯膀胱之前，在局部针刺或循经针刺，有全面调整诸阴经的作用。故上述诸病的取穴，只取任脉一经与腰骶部太阳经穴位相配用。通过补或平补平泻的手法，使虚者实之，或兼取强壮作用穴位，如足三里、三阴交等穴位，以奏显著疗效。

十八、疝气偏墜 (共九方)

第一方 唐山市中医門診部 张学增介紹

主治：寒疝。

症状：小腹絞痛，舉丸下垂，腹冷。

取穴：独阴 (双)

取穴法：独阴穴在第二趾之里边，第二节横紋中央是穴。

手法：用毫針直刺，捻轉进針。刺二至三分深，留針一小時，灸針尾以不痛为止。

治驗：玉田县窩洛沽人民公社西王家桥村王××，男，三十七岁。于一九五五年一月十九日就診。主訴：“患疝痛已很久，时好时犯，痛劇則倒地乱滾，似抽筋样，疼痛难忍，經服止痛药无效。”用針灸治疗，取独阴双穴，針尾加灸七八壮后，痛即逐漸減輕，灸至十二壮痛即止，留針一小時，痛止起針。一次即痊愈，始終未犯。

第二方 河北中医学院 宋学儒介紹

主治：疝气症。

症状：阴囊肿大，或左或右，或出或沒，重墜痛引少腹，甚則肢厥，小便閉塞 (屬寒性者)。

取穴：主穴：消疝 (双) 驅疝 (双) 關門 (双)

配穴：行間 (双) 太冲 (双) 曲泉 中极 关元
气海 三阴交 (双) 腎俞 (双) 然谷 (双)

中封(双) 照海(双) (以上各穴可配合輪流使用)

配灸：三角灸

取穴法：仰臥位。消疝穴在关元之旁；驅疝穴在中極之旁，各平开三寸半；闌門穴在阴茎根部旁开三寸。

手法：用毫針捻轉进針，用平补平泻手法。得气后，慢慢捻轉使酸、胀感应到阴部，再向下扩散到股內側，向上扩散到中腕部，有时感觉可达章門部，同时睪丸及少腹部亦似有如綫上提或有气向上抽擣的感觉。三穴感应大致相同，留針二十至三十分钟，徐徐旋捻出針。再施三角灸法。

附注：(一)消疝、驅疝、闌門等三穴下面有动脉应手，刺針时应以压手避开动脉，勿刺过深，以免暈針或出血。

(二)三角灸。以横量患者两口角的长度为标准，从臍中央向左右兩側斜量，成等边三角形，記作灸点，以艾炷或艾卷灸之，至皮肤灼紅为度。

治驗：共治愈七例。茲介紹一例如下：

保定市滿城区西原人民公社孙村王××，男，五十六岁。患疝气已三十余年，发病时右腎囊肿大如拳，下墜痛引少腹，遇寒或过劳时病情尤重。經診斷为寒疝症。取穴除主穴外，配用中極、关元、大敦、太冲、三角灸。共針灸六次痊愈。

第三方 天津市紅桥区西沽街卫生院 华佩文介紹

主治：疝气痛。

症状：睪丸牽引少腹疼痛。感寒則发。

取穴：主穴：大敦(双) 太冲(双) 三阴交(双)

配穴：曲泉(双) 中极

取穴法：仰卧位。大敦于足大趾本节之前，偏内方，与足缝平、微靠前。医者以左手中指托患者大趾关节部，食指、无名指挟其两侧，使拇趾向下屈，医者以拇指切压穴位，即可进针。

手法：用毫针以套管法进针，先刺健侧大敦、太冲各三分，三阴交一寸，曲泉八分，中极一寸，用平补平泻手法，找到感应后出针；再刺患侧，穴位、深度、手法同上。每天针一次。儿童针十次左右可痊愈，成人一次即可止痛。

第四方 河北中医学院 刘殿元介绍

主治：疝痛。

症状：睾丸偏坠，或红肿，或阴囊积水及疝气等疼痛。

取穴：闾门 疝气

取穴法：平卧位。闾门穴在曲骨穴旁开三寸处；疝气穴在关元向患侧旁开三寸五分，均取患侧。

手法：用毫针直刺五分至一寸五分。捻针用平补平泻手法，留针三十分钟至一小时。每日针一次。

附注：如为疝气偏坠，必须将坠痛之睾丸推上再针。

治验：张××，男，五十三岁。患睾丸一侧肿胀、疼痛，扪之有热感。针上穴二次后，肿消即痊愈。

第五方 石家庄市第二医院 李增树介绍

主治：疝气偏坠。

症状：一侧睾丸肿胀。

取穴：主穴：归来（病侧）

配穴：太冲（健侧）

手法：用毫针直刺归来穴一寸，提插捻转使感应到外阴部；再刺太冲穴五至八分。用平补平泻手法，留针三十分钟。每日针一次，三至六次可痊愈。

禁忌：忌刺激性食物及性交。

第六方 静海县辛集人民公社卫生院 李际武介绍

主治：气蛋。

症状：睾丸膨胀时时有气。

取穴：头顶发旋中央点

手法：发旋有几个针几个，按人的胖瘦针一至三分深（胖宜深，瘦宜浅），针尖向前刺。有的当时见效，也有针二、三次痊愈的。

禁忌：忌吃凉东西。

第七方 保定市保专第二医院 刘杰三介绍

主治：副睾肿。

症状：一侧睾丸肿大，呈结节状，疼痛，下坠。

取穴：气冲（双） 归来（双） 大敦（双） 血海（双）

足三里（双）

手法：用毫針旋捻進針，直刺氣沖、歸來各一寸，大敦向上斜刺一分，血海八分，足三里一寸二分。用平補平瀉手法，留針二十至三十分鐘。隔日針一次。

禁忌：忌性交及食刺激性食物。

第八方 懷安縣郭磊莊人民公社醫院 王金貴介紹

主治：睪丸炎。

症狀：睪丸一側或兩側急性發炎，紅腫，熱痛。

取穴：主穴：承山

配穴：三陰交

取穴法：伏臥位，三陰交在內踝上四寸，脛骨邊緣後五分寸。二穴均取患側。

手法：左手切穴，右手以二寸毫針捻刺承山穴（拇指向前，食指向後），捻進七分，用瀉法（指法同上），三陰交針入五分，用補法（拇指向外捻針）。兩穴同時捻轉，以疼痛緩解為度，不留針。另外，還可用下方熏洗。處方：花椒、艾葉、蔥須根（適量）。以水煎七沸，乘熱熏洗患處。一般針洗一次即見效，不再疼痛，紅腫亦消。

第九方 交河縣醫院 張鳳祥介紹

主治：睪丸炎。

症狀：睪丸一側或雙側腫大、發硬、壓痛。

取穴：主穴：腎俞（雙） 志室（雙）

配穴：內庭（雙） 三陰交（雙） 足三里（雙）（在主穴

刺三次后再用)

手法：用毫針直刺腎俞、志室各二寸五分，用平補平瀉手法，使感應到下腹和外陰部；并以艾條灸針柄處，使熱感達于下腹部後出針。每日或間日針一次。三次後再加用配穴，內庭刺五分，三陰交五至八分，足三里一寸。進針後各穴平補平瀉，仍以艾條灸針柄上，灸後出針。一般針十餘次即痊癒。

按：疝氣症包括多種病變在內，如素問骨空論載：“任脈為病，男子內結七疝（沖、狐、癰、厥、疝瘕、瘻、癰）。”靈樞經脈篇載：“足厥陰之脈，……是動則病……丈夫瘻疝。”素問繆刺論載：“邪客于足厥陰之絡，令人卒疝暴痛。”四時刺逆從論篇更根據十二經脈所表現的脈象動變方面，叙出狐疝風、肺風疝、脾風疝、心風疝、腎風疝、肝風疝等名目。後代醫家更因其不同的原因、症狀另立了奔豚疝、食積疝、風濕疝、瘀血疝、木腎、卵脹、水疝、小兒氣疝、小腸氣等。名目繁多，不勝枚舉。在辨證論治上，或主張其治在肝，或主張治在血分、氣分，各執一端。關於這一點，明代張景岳氏認為“前陰小腹之間，乃足三陰、陽明、沖、任、督諸脈之所聚，而不能以厥陰一經概括之。肝主筋，其病在筋，各經之疝均挾肝邪為病”。張氏這種看法，是比較全面的。在治法方面，素問長刺節論篇載：“病在少腹，腹痛不得大小便，病名曰疝。得之寒，刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡見病已。”系統的指出病症和治法，不但要在腹、背兩側鄰近取穴，而且要在治療過程中由少到多的增加穴位，並應用各種補法，使之生熱以祛寒。如有其他兼症，亦當同時進行全面治療。至於睪丸炎症，則适于下肢遠距離循經取穴，以誘導為主，亦當針灸並施。

十九、膈肌痙攣 (共七方)

第一方 邯鄲市眼科医院 王順婉介紹

主治：膈肌痙攣。

症狀：呃逆，脉紧。

取穴：奇穴

取穴法：仰臥位。奇穴于左側阴都穴外开一寸处取之。

手法：用毫針直刺奇穴一寸五分，捻轉搗刺法(重雀啄)，留針時間可具体掌握，如症狀发作剧烈，留針時間可长些。如一次未愈，翌日再針一次。

治驗：何××，男，二十二岁。門診病历〇〇七六〇号。主訴：“患膈肌痙攣两年多，經常发作，甚則食物返出。”印象：膈肌痙攣，經針刺奇穴一次后減輕，三次停止发作。

第二方 天津医科大学附属医院 刘云鶴介紹

主治：打呃。

症狀：呃逆連續发作。

取穴：阴都 中脘

取穴法：仰臥位，中脘穴于臍与蔽骨之中間取之，旁开五分为阴都穴。

手法：用三十号不銹鋼針直刺中脘五分，阴都三分。用平补平泻手法，留針一至二小时。連刺一至三次，每日一次。

治驗：針治呃逆，对日久的慢性症、重症以及手术后引起的一般呃逆症，疗效达百分之九十。茲举一例介紹如下：

何××，男，二十二岁。門診病历五〇〇七六〇号。自訴：“患膈肌痙攣症已两年多，經常发作，逆甚則食物返出。”經針下呃逆即解，連針三次痊愈。

第三方 天津中医学院附属医院 王文錦介紹

主治：打呃。

症状：呃逆，間歇发作。

取穴：上腕 中腕 下腕 足三里

手法：用毫針捻轉进針，直刺上、中、下腕各一至二寸，足三里一至一寸五分。用平补平泻手法，留針三十分钟至二小时，徐徐出針。一次即痊愈。

第四方 涞源县王安鎮卫生院 刘继宗介紹

主治：呃逆。

症状：打呃，連續不断。

取穴：内关(双) 天突

手法：用毫針緩緩捻刺内关一寸，天突斜向下刺五至八分，以中等刺激手法。天突針发生感应后，即旋捻退出，内关留針三十分钟。

治驗：本县王安鎮乡二道河梁××，女。主訴：“呃逆，发作时打呃連声不断，已服中、西药治疗月余未效。”診斷为肝气上逆，胃气不降。取穴内关、天突。連針二次后呃逆減輕，治疗六次痊愈。

第五方 河北省中医研究院門診部 景象介紹

主治：呃逆。

症状：呃逆发作，連續不止。

取穴：气舍(双) 气戶(双) 膈俞(双)

手法：用毫針捻轉进針，直刺气舍三分，气戶三分（針尖向外斜刺），膈俞針尖向上沿皮斜刺二寸。用泻法（拇指向后，食指向前），留捻至呃逆停止后出針。

第六方 天津市和平区解放桥門診部 馬德良介紹

主治：呃逆（膈肌痙攣）。

症状：呃逆上气，发作連續不止。

取穴：奇穴

取穴法：俯臥，两腿平伸于外踝上七寸腓骨邊緣，穴在飞揚、外丘两穴中間。

手法：用毫針捻轉直刺奇穴一寸，用平补平泻手法，留捻二十分钟。一次即痊愈。

第七方 唐山市东矿区古林联合診所 李玉良介紹

主治：呃逆。

症状：陣发性或連續性打呃。

取穴：主穴：养老(双)

配穴：内关(双)

取穴法：平臥，两手外轉，掌心向上于兌骨縫隙中取养老

穴。（男子取左側配右側內关，女子反之）

手法：用毫針先刺养老穴，針入三至五分，捻轉几次，得气后留針。再直刺內关八分至一寸五分，用平补平泻手法，以得气为度，留針二十分钟，快速出針。

按：呃逆古称为嘔，现代医学名膈肌痙攣。其誘发原因甚多。祖国医学认为是气不舒（包括肺气、肝气、胃气），以致胃气上逆不下。在辨症上虽有虛、实、寒、热的不同，均不外以舒气、調气、降逆为主。在針灸疗法方面，取局部穴以鎮靜之，或取四末穴位以誘导之，除取穴于胃之体表穴位如三脘、阴都，以及第一方之奇穴之外，并应着重下肢阳經穴位的刺灸，以降其逆气。如第六方取刺下肢經驗奇穴，一次即停止发作。至于內关穴，系手厥阴之絡別走少阳，善調三焦胸腹諸疾，治疗呃逆，亦有特效。其他有效穴位如膻中、气海、章門、期門等，均可辨症选用。

二十、脾臟腫大症 (一方)

第一方 霸县医院 王茂林

主治：脾脏肿大症。

症状：腹大如鼓，坚硬如石，身体消瘦。

取穴：隐白 大都 太白

手法：用毫针直刺隐白一分，大都、太白各三分。用平补平泻手法，留针十五至三十分钟。每日针一次。

治驗：（一）穆××，女，八岁。检查：脉象沉数，身体瘦弱，飲食减少，腹胀脾大，坚硬如石，有时腹泻。诊断：脾脏肿大症。

治疗：以上述各穴为主穴，配足三里，用平补平泻手法，留针三十分钟。共针刺二周，諸症消失，脾脏恢复正常。

（二）本县叶家庄张××，男，十二岁。检查：脉象沉细，顔面黄瘦，四肢浮肿，大便溏泻，腹部胀大，触有硬块，食欲不振。诊断：脾脏肿大症。按上述穴位治疗，一周即痊愈。

（三）刘××，男，二岁。症状：体温高烧，面黄肌瘦，腹部胀大，大便溏泻。诊断：脾脏肿大症。治疗：针刺隐白、大都，用平补平泻手法，留针五分钟；复刺四缝穴出黄水，不留针。共针二周痊愈。

按：脾大症，其誘发因素頗多，古代医学名痞块，或痞积，认为系由于飲食损伤脾、胃所造成。考之新医学，如慢性骨髓性白血病、血栓性靜脉炎、溶血性黄疸症、肝硬变、慢性淋巴性白血病、迁延性传染病，以及体内寄生虫病等，都能导致不同程度的脾肿大。本方采取对症治疗，并未进行物理检查，原因尚属不明；但从足太阴循經取穴，并配合足三里，以調整消化系功能，在驗例三的治疗中并配用治痞特效的四缝穴，故亦能取得相应的疗效。

二十一、肝硬變 (共二方)

第一方 唐山市卫协联合診所 孙紹廷介紹

主治：肝硬變。

症狀：右肋緣處有硬塊，腹脹，小腹痛，大便秘結，食欲不振，脈左關弦而有力。

取穴：上腕 中腕 下腕 氣海 太冲(雙) 行間(雙)
肝俞(雙) 期門(雙)

取穴法：平臥。期門穴位於乳中綫上于肋骨下緣取之。

手法：用圓利針刺上、中、下腕各一寸五分，氣海二寸，太冲一寸，行間八分，肝俞五分，期門向後外側斜刺一寸。用平補平瀉手法，留針一至二小時。出針後每穴以艾球灸五至七壯。每日或隔日針一次。

禁忌：保持精神愉快，忌生冷食物。

治驗：(一)本市達謝莊子陳×，女，三十二歲，幹部。一九五六年九月二十四日初診。主訴：“胃痛，妨礙飲食，失眠、盜汗，經醫院檢查為胃下垂、肝臟腫大，已二年之久，治療未愈。”現症：腹脹、小腹痛、大便秘結。檢查：脈右沉細無力，左關沉有力；肝臟腫大，肋下三橫指。取穴三腕、行間、太冲、期門，用平補平瀉手法。二十六日復診：取穴同前，加巨闕、氣海、大敦，手法同前。二十八日三診：小腹痛止，飲食增多，取穴復加肝俞。三十日四診：肝臟縮小至肋下二橫指，取穴、手法同前。共經二十三次針治，肝臟腫大消失，食欲恢復正常。復經醫院檢查，已經痊癒。

(二) 本市同善里一号张××，女，三十四岁。一九五六年九月二十五日門診。主訴：“心窩部脹痛，上腹、肋間皆脹硬，大便秘結，飲食減少。”檢查：面目及四肢均發黃色，脈沉數有力，肝腫大至臍，有壓痛。經取穴三腕、期門、行間、太沖，用平補平瀉手法。九月二十七復診：取穴同前加巨闕、氣海、大敦。二十九日三診：心窩脹痛減輕，腹、肋脹硬見軟，取穴、手法同前。十月一日四診：加肝俞、至陽、公孫，各刺五分，厲兌三分，手法同上。至第十五次，發黃症狀消失，肝腫縮小至肋下三橫指；第三十次後，肝腫繼續縮小至肋下一橫指。共經過四十次治療，肝腫大完全消失。在治療過程中，大敦、行間兩穴要輪換使用。

第二方 保定市保專第二醫院 劉杰三介紹

主治：初期肝硬變。

症狀：肝腫大，右肋肋下緣有壓痛，腹脹，發熱，食欲不振，大便秘結。

取穴：腎俞(雙) 大腸俞(雙) 膀胱俞(雙) 脾俞(雙)
胃俞(雙) 八髎(雙) 巨闕 期門(雙)
足三里(雙)

手法：用毫針緩慢捻轉進針，刺腎俞、胃俞各四分，八髎各二分，巨闕、期門各八分，大腸俞、膀胱俞、脾俞各刺入五分，足三里一寸二分。用平補平瀉手法，留針二十至三十分鐘。隔日針一次。

附注：治療中宜靜養，保持精神上愉快，吃軟性食物。

按：肝硬變是一種慢性、全面性、進行性、變質性及破壞性的肝細胞性疾病，伴以活動性的補償變化，及結締組織的增生與收縮，早期由於胃腸道的阻性充血，以及因肝硬化後影響胃腸道的分

泌和吸收机能，故早期症状多有食欲不振，恶心，呕吐，腹胀，大便燥结或泻泄，上腹不适等症状。现代医学对本病尚未有满意的治疗方法。中药治疗的原则，是根据病情虚实定攻补之法。近年来无论在虚症或实症，都有相当满意的疗效。针灸对本病所用的三脘、气海、肝俞、脾俞、期门、足三里为主要刺激点；再根据患者的具体情况，加刺其他穴位，如小便量少加刺关元、阴陵泉；心力衰弱加刺神门、内关、三阴交；吐血或鼻出血加刺尺泽、内关、合谷；腹水加刺肾俞、大腸俞、关元、足三里、三阴交、八髎、外关、阴陵泉；多灸水分及神阙。总之，按症施治，互相调协，以便通过针灸治疗，疏通血行，调其气血，通其经络，增加肝脏的藏血能力，恢复肝脏之正常生理机能，增加肾脏的排泄机能及脾之润滑作用，以达到调气、养肝、健脾、利尿的目的。

二十二、臌 脹 (一方)

第一方 河間中医學院 王洪印介紹

主治：气臌。

症状：每至下午腹脹，三至四小时后消失。

取穴：中脘 足三里

手法：用毫針直刺中脘三寸，足三里二寸。用透天涼手法，留針一小时。每日針一次。

治驗：本县东石相村張××，女，四十六岁。一九五八年五月八日初診。主訴：“一九五五年二月患小便淋瀝，欲尿不能尿，浸淫下衣儿至无干时。至一九五八年三月間，未治自愈。继而发现少腹滿，每天午后自觉由心窝部如向下吹气，須臾腹部脹滿如鼓，經三、四小时后又恢复原状，久治不愈。”检查：脉象洪数有力。印象：湿熱郁于中焦，以致气滯留結为脹，嘱观察后再处理。翌日下午来院急診，检查腹脹大，偏左方为甚，如八、九月怀孕状。当为之取穴足三里，用透天涼手法，下針后，腹部脹气随之消失，并觉有热气自尾闕透出，捫之灼手。經針一次即愈，观察半年，未再发。

按：透天涼手法，針灸大成記載：“透天涼，能除熱，三退一進冷冰冰。口吸氣一口，鼻出五口。”“凡用針時進一寸內，行六陽之數，其五分者，即先深后淺也。若得氣便退而伸之，退至五分之中，三入三出，緊提慢按，若覺針頭沉緊，徐徐舉之，則涼氣自生，熱病自除。如不效，依前法再施。”其操作法是：于患者吸氣時進針，將針刺入所要達到的深度以後，用捻轉法，使之發生感

应。同时将针紧提五分，旋捻加大感觉，再提起五分，随捻随退，退至皮下后，再慢慢捻进，然后分三部退针，如此往复三次，至患者感觉凉气发生，并逐渐扩散后为度。此法适应于一切热性病，针后能使体温下降；但初学者不易掌握，必须手法熟练，才易于产生疗效。

二十三、黃 疸 (共二方)

第一方 保定专区第二医院 刘杰三介绍

主治：黄疸。

症状：颜面、眼球及遍身均发黄色，小便黄，右上腹部痛，食欲不振。

取穴：天柱 风池 肩井 肝俞 胆俞 胃俞
中脘 足三里

手法：用毫针直刺天柱、风池、肩井、肝、胆、胃俞各七分，中脘八分，足三里一寸二分。各穴均用平补平泻手法，留针二十至三十分钟。隔日针一次。

禁忌：忌辛辣、荤腥食物，注意精神愉快、安静。

第二方 衡水县武邑赵桥人民公社医院 馬玉凱介绍

主治：黄疸（阳黄）。

症状：身、面发黄如橘子色，胸胁满，饮食少进，尿黄或不利，全身倦怠乏力，脉象洪大。（脉微细为阴黄）

取穴：阿是

加减法：口渴加中渚穴；小便不利加踝心穴；胸满、食不下加内庭穴。

取穴法：阿是穴于目内眦，翻开上下睑板，于结合膜上有黄筋，筋上即是穴；踝心穴，在涌泉穴后约三横

指，正对内外踝尖，足心处是穴。男先刺左侧，女先刺右侧。

手法：用三棱针点刺阿是穴，勿令出血，令患者低头，刺处流出黄水，上下各挑一次，直至黄疸消失为止。

踝心穴以毫针直刺一寸二分至一寸五分，中渚、内庭三至五分。用平补平泻手法，留针三十至六十分钟。

附注：孕妇禁用此法。

按：黄疸有阳黄和阴黄的分别，上述穴位都是治疗阳黄的有效穴位。因为发黄多是由湿热造成的，它的发病机理与胆、胃、膀胱三经都有密切关系，故在治疗上不论药物和针灸疗法，都以清热利尿为原则。循经取天柱、风池、肩井、胆俞等穴，以泻手足少阳之湿热；取足阳明的足三里、内庭，以消除胸腹满闷，祛胃中之瘀热；取五脏之俞，如胆俞、胃俞、肝俞等穴，以泻本经实热。至于用三棱针点刺阿是穴溢出黄色液体，其目的亦为直接使湿邪外出；同时刺踝心穴，更能引导湿热下行。故针此三经之穴，能达到治愈的目的。

二十四、中 消 (共二方)

第一方 涿县涿县人民公社医院 史星三介绍

主治: 中消。

症状: 多食、食后即飢，形体消瘦，全身无力，腹疼，小便頻数。

取穴: 上腕 中腕 下腕 上星 百会 公孙(双)
内关(双) 足三里(双) 三阴交(双)

手法: 用左手指切穴位，右手持毫针捻转进针。上腕、中腕、下腕各刺二寸，上星向前下斜刺二分，百会向上斜刺二分，公孙一寸，内关六分，足三里一寸至一寸五分，三阴交一寸五分。用泻法，留针三小时。隔日针一次。

禁忌: 忌生冷、葷、辣及香菜等食物。

治驗: (一) 本县王庄村王××，女，六十五岁。一九五八年四月就診。主訴：“四肢无力，每日吃飯六次仍覺飢餓，面色黃白，发热。”检查：脉浮数而大，舌苔黃。診斷：消渴症。取穴：用上述穴位治疗，当日即收效。共针五次痊愈。

(二) 本县下坡店村周××，女，三十六岁。于一九五八年五月就診，門診病历〇〇〇一八五号。主訴：“周身无力，食不知飽，行路困难，腹胀，脉象沉細。診斷为消渴症。取穴：用上述穴位治疗，针至二次症状減輕，自能行走，四次痊愈。

第二方 易县医院 李占魁介绍

主治：中消。

症状：多食善飢，每天食六次，食后仍飢，身体消瘦无力，心慌。

取穴：脾俞(双) 胃俞(双)

加减法：心跳加神門，心煩加心俞。

手法：用毫針捻轉进針，用平补平瀉手法。脾俞、胃俞各斜刺一寸，神門直刺三分，留針一小时；針后艾灸俞穴五至十分钟。隔日針灸一次。

治驗：运用本方，曾治愈三十七例，均已痊愈。

按：消渴一症，包含很广，凡見口渴消水一症，都叫消渴。消渴是一种燥病，就是水火不交，偏胜用事，燥热伤阴的一种症候。历代医家对消渴的症状描写和病理观察叙述甚詳。宋、元以后的医家，又根据病气的偏胜，进一步把消渴分为上、中、下三消。后世医家对中消症状的記載，与金匱要略的精神是相同的。金匱要略載：“趺阳脉数，胃中有热，即消谷引食，大便必坚，小便即数。”尤在涇說：“胃中有热，消谷引食，即后世所谓消谷善飢为中消是也。胃热則液干，故大便坚；便坚則水液独走前阴，故小便数。”对于中消的治法，应針对其原因，除胃腸的燥热，或济胃中的津液，使津液生而不枯，气血利而不結，中消自可痊愈。上述第一方用足三里配三阴交降逆解热，破其热結；配三脘、公孙調整胃腸机能，促进消化；三阴交、內关以治胸滿胃脘不快，风雍气滯，大便艰难；上星、百会以散上焦热邪，同时三阴交又能調整泌尿系疾患的异常，因此中消属脾胃蘊热的症候。这种配穴方法，是对症的疗法。第二方用脾俞、胃俞針灸并施，以加强机体的抵抗能力，

对于机体因饮食过度亢进，造成对人体损害的一种虚热，形成一种恶性循环，食后仍饥的症状是有效的。并随症加神門，以鎮靜安神止怔忡；心俞清心热，因而亦获得疗效。总之，处理中消的方法，当以清虚热，除燥結，兼以养阴补肾为准则。凡合乎这个法则的穴位，都可随症选用。

二十五、貧血症 (一方)

第一方 藁城县大陈人民公社医院 蒲士芬介紹

主治：因鈎虫，瘧疾或其他病后所致的貧血。

症狀：顏面蒼白，呼吸困難，心悸，食欲不振，全身衰弱。

取穴：主穴：大椎 膏肓(雙) 肝俞(雙) 人中

足三里(雙) 中脘 合谷(雙)

配穴：關元 腎俞(雙) 內關(雙) 內庭(雙)

心俞(雙) (以上穴位可分組輪流選用)

手法：用毫針旋捻進針，垂直方向，大椎、人中、膏肓、肝俞、心俞、腎俞、內庭刺五分，中脘、足三里、合谷、關元、內關刺八分至一寸。針達深度后，用輕刺激手法，以發生酸、麻、脹等感覺后留針十五分鐘。隔日針一次，十次為一療程。

治驗：(一) 本縣石家村石××，女，二十九歲。一九五二年春產后患瘧疾，愈后繼發貧血，屢治無效。經用上述穴位針治四次，繼續觀察迄未復發。

(二) 本縣石家村石××，男，四十二歲。一九五七年春患鈎虫性貧血，症狀同上。經用上述穴位針治六次，計時十五天，症狀消失。經鏡檢，于大便中發現鈎虫卵，服四氯乙炔，痊愈。

(三) 本縣冀家庄楊××，男，六十五歲。一九五六年患鈎虫性貧血病，症狀同上。經檢查大便中有鈎虫卵，先用針刺療法，經針治六次，歷時十四天，症狀消失后，繼服四氯乙炔，痊愈。

按：鉤虫病是农村中常見的疾病，它的主要症狀是貧血、萎黃、營養不良、發育不全及胃腸蠕動障礙等。患者常有心跳、頭暈、氣短等。近年來用中藥在治療鉤虫病方面，已取得了很大成就；採用針灸治療鉤虫病亦有文獻報道。雖然在中醫經典著作中，無“鉤虫病”之稱，而其有效穴位，都散在有關症候中。近年來已正在進行研究，至於針灸所以能夠驅除鉤虫，其機理的論述現在尚少。針術是一種機械性刺激，能夠調整身體內部的營衛氣血，改善機體的生理情況，增加機體的自然抵抗力。若人體營養狀況良好，抵抗力自然增強，侵入人體的虫卵不能發育成為幼虫；即發育成幼虫，其壽命亦縮短，或在短時間內自趨死亡，隨糞便排出。本方所採取之足三里、中脘、肝俞、關元等穴，不僅作用於胃腸系統，改善胃腸系統的生理狀態，並且配合大椎、膏肓、腎俞、心俞等的強壯穴位，增加宿主的自然抵抗力，胃腸系統中不適於虫體生活或致其生理機能減退，而從糞便中排出，達到治愈的目的。有關其機制問題，還必須深入探討，才能覓獲。

二十六、神經衰弱 (共十六方)

第一方 天津市汉沽区医院 邵鐸年介紹

主治：神經衰弱。

症状：头晕，头痛，心悸，失眠，耳鳴，遺精，健忘，食欲不振，倦怠乏力。

取穴：内关(双) 中脘 足三里(双) 三阴交(双)
神門(双) 关元 气海 百会 太阳(双)

手法：用三十一号毫針徐徐捻刺内关五分，中脘一寸，足三里一寸五分，三阴交五至八分，神門三分，气海八分；头疼时刺百会三分（針尖向后沿皮刺），太阳三分。用平补平泻手法，留針十五至二十分钟。

关元穴以艾条灸五分钟。隔日針灸一次。

治驗：用上述穴位經治十余例，治愈率达百分之七十至九十。倘无其他合并症，效果甚高。茲举典型病一例介紹如下：

本区姜××，男，四十岁。一九五九年五月門診。主訴：“头晕，有时微疼，心跳，失眠，耳鳴，遺精，精神疲倦，食欲不佳，食后胃部不舒，曾經×医診斷为神經衰弱，治疗多次未效。”检查：脉虛数无力。印象为腎水虛涸，君火独熾，水火不济，故失眠、健忘、虛煩等症时时发作。經取穴内关、神門、中脘、气海、三里、三阴交等，針三次后症状減輕；第四次尚有头痛，加取百会、太阳，針后头痛即止，复加灸关元。共針灸十六次，諸症消失，痊愈。

第二方 天津中医学院附属医院 王紹中介绍

主治：神經衰弱。

症状：头晕，失眠，健忘，心悸，气短，食欲不振，遺精早泄。

取穴：頸、胸、腰、骶、尾椎兩側，每側刺兩縱行。重點刺激，五至八胸椎兩側，腰骶椎兩側。（除常規縱刺外，還可加縱刺橫刺）

加減法：头晕、頭痛，加刺頭部；目昏加刺頸椎一至四旁及眼周圍；便秘及消化不良，配合上下腹部；遺精陽萎配合下腹及腹股溝；局部麻木疼痛，配合局部刺激。

手法：使用七星針，必須掌握好彈刺方法，運用手腕上彈刺的沖力。在刺激時，一觸到皮膚，立刻提起，不可遲緩。力量的輕重，針數的多少，部位的遠近，頻率的急徐，靈活掌握，勿太過，勿不及。當針尖觸及皮膚時，應使之感覺疼，但又不能使之太疼，方能使病人安然合作。刺後必須使針下有向四外放射性的傳導，皮膚有發熱發癢，如觸電樣的麻感，身體有輕鬆舒適的感覺。初期每日一次，十次以後改隔日針一次。每二十次為一療程。

附注：（一）治療前說服解釋，使患者合作，堅定其信心，按療程治療。

（二）針後應注意患者睡眠環境，保持安靜舒適。

(三) 初次刺激后，如有头晕、睡眠不安等反应，多因刺激过重所引起；再针时改用輕刺激手法。

(四) 特殊患者在刺激时，发生心慌、恶心等现象，系因其精神过度紧张所引起，应作解释并稍事休息，即可恢复。

(五) 症状輕者二至三次后即見效，重者十次以后見效。如治滿一疗程无效时，可轉科治疗。

治驗：本方的疗效，据 我院临床統計一百病例的觀察，其中全愈者四十一人，占百分之四十一，显著进步者三十一人，占百分之三十一，进步者二十五人，占百分之二十五，无效者三人，占百分之三，統計有效率为百分之九十七。茲举典型病一例介紹如下：

李××，男，四十岁，干部。門診病历一九一八八号，一九五九年三月二日就診。主訴：“近二年来經常失眠，头晕胀痛，四肢疲乏无力，性欲衰退，食欲不振，两眼視力减弱，大便干燥，小便尚正常。”既往症：患过瘧疾。检查：脉象細弦，舌苔白，身体瘦弱；胸椎五至八旁有索条状物、压痛，頸椎旁有压痛，頸椎一至二处有痠感。印象：神經衰弱。处理：刺激常規，重点胸髓部，胸椎五至八兩側，配合頸椎、上下腹及腹股沟部。治疗經過：患者每日均来門診治疗，刺激部位无变化，治疗期間逐漸好轉，第三次治疗后，睡眠良好，精神振作，以后食欲亦日見增加。第九次治疗后，体重較未治疗前（一月）增加七斤；二十次后，症状完全消失而痊愈。

按：孙惠卿大夫对本病的检查方法是：检查其脊椎兩側在胸椎五至八处兩旁，有索条状物之异常发现，推压时有痠、痛、麻、木的感觉（痠为初发，痛比痠重，麻比痛重，而木感尤重），以上阳性反应，是神經衰弱患者所共有的。另一方面，此部位出現的异

常反应，也代表胃及十二指肠的疾患。希讀者結合症狀參考使用。

第三方 龙烟鋼鐵公司宣化医院 薛孝先介紹

主治：神經衰弱。

症狀：頭暈，失眠，善忘，精神不振。

取穴：脊背兩側由大杼至腎俞兩縱行 大椎

曲池(雙) 合谷(雙)

手法：用梅花針自大杼向下打至腎俞，大椎、曲池、合谷三穴均打三下。每二至三天打一次。

附注：治療期中應注意腦力的使用，勿過勞。

治驗：本公司耐火車間姜××，男，二十七歲，幹部。患神經衰弱症。主訴：“頭暈痛，失眠，善忘，精神不振已三年之久，現在每天不能堅持腦力勞動，甚至連一小時的工作都不能做。”檢查：脈象左寸虛弱無力，右關遲弱，顏面黃瘦。于一九五九年四月二十二日開始用梅花針治療大椎、合谷、曲池穴各捶三下，由大杼穴位向下捶至腎俞穴部位。每兩日針一次，至五月二十五日，已能連續作二至三小時的工作，記憶能力亦恢復，痊癒。

第四方 河北省中醫研究院附屬醫院 王道常介紹

主治：神經衰弱。

症狀：頭暈痛，健忘，驚悸，失眠，精神不振。

取穴：脊柱兩側，胸部、下腹部之條索狀敏感點及局部。

手法：用梅花針捶打脊柱兩旁，用彈刺法，再于其他敏感點局部捶打，適當掌握彈刺沖力。

附注：刺时注意量針。倘发生暈針，可在臀部兩側各密打三排。

第五方 唐山市东矿区赵各庄联合診所 徐继介紹

主治：神經衰弱。

症状：头晕，心悸，气短，失眠，精神不振。

取穴：风門(双) 諶嘻(双) 膏肓俞(双)

手法：用艾絨团成黄豆大小球，每穴灸五至七壮，以皮肤灼紅为度。隔日灸一次。

附注：如灸后起水泡时，以消毒針穿破，盖敷一小块橡皮膏，再灸时依穴位周围进行。

第六方 滄县医院 张发現介紹

主治：神經衰弱症。

症状：心悸，怔忡，健忘，失眠，倦怠无力，食欲不振，用脑时則发头痛，脉微弱。

取穴：百会 头維 风池(双) 合谷(双) 足三里(双) 腎俞(双)

加减法：头痛、煩躁不安、舌紅加太阳(双)、攢竹(双)、神門(双)、間使(双)；心悸、怔忡、失眠、倦怠、消化不良加心俞(双)、中脘；头昏、眼黑、眩暈、皮肤焦悴加肝俞(双)、列缺(双)、三阴交(双)、行間(双)、太冲(双)、太谿(双)。

手法：用毫針捻轉进針，百会向后沿皮刺入三分，风池直

刺五分，头維向后沿皮刺入四分，列缺向上斜刺五分，攢竹向眉心刺入六分，神門直刺五分，中腕直刺一寸五分，足三里直刺一寸二分，心俞直刺五分，腎俞直刺一寸五分，三阴交五分，内关直刺五分，脾、胃俞各刺入一寸，建里直刺一寸五分。各穴进針后，用平补平泻手法，留針三十至六十分钟。如头痛剧烈时，太阳、头維、合谷、神門、間使皆用重刺激手法；如头昏、眼黑、眩暈重者，肝俞、行間、太冲三穴皆当重刺激；其他各穴手法同上。隔日針一次。

第七方 迁安县楊店子人民公社医院 张世昌介紹

主治：虚性头暈。

症状：头暈，心悸，气短。

取穴：主穴：百会 神門(双)

配穴：四神聰 涌泉(双)

取穴法：四神聰穴正坐于百会的前、后、左、右各一寸处取之。

手法：用毫針順序刺入，百会沿皮針尖向后刺入五分，神門直刺五分，四神聰各沿皮向后刺入三分，涌泉直刺三分。各穴刺入后，徐徐捻轉，用平补平泻手法，留針二十至三十分钟，徐徐出針。

第八方 唐山市新軍屯人民公社医院 王春波介紹

主治：神經衰弱性头痛。

症状：头痛，头晕，昏睡不醒。

取穴：主穴：足临泣(双)

配穴：外关(双) 头维(双) 上星 百会

丝竹空 头临泣(双) 申脉(双)

手法：用毫针捻转进针，足临泣直刺五分，外关直刺一寸，头维沿皮向后刺一寸，列缺沿皮向上斜刺二寸，如系偏头痛则取对侧，上星、百会均沿皮向后刺入三分，丝竹空沿皮向眉心横刺三至五分，头临泣沿皮向上刺入三至五分，申脉直刺三分。各穴均用补法，留针一小时，在留针时间内每十分钟轻捻一次。每日针一次。

治验：本方曾治疗神经衰弱性头痛十余例，每天针一次，均不超过三次即痊愈。

第九方 涿县涿镇人民公社医院 史星三介绍

主治：神经衰弱性失眠。

症状：头晕，健忘，心悸，夜不能眠。

取穴：主穴：神门(双) 复溜(双) 上星 百会

足三里(双)

配穴：公孙(双) 内关(双)

加减法：头痛加风池(双)。

手法：用毫针先直刺公孙一寸，先补后泻(男大指向后为补，向前为泻，女则反之)；再刺内关六分。上星一分，百会二分(均向后沿皮刺)，神门三分，均

用泻法；复溜一寸用补法；足三里穴直刺一寸，用平补平泻手法，留针三十分至二小时。

第十方 邯鄲市区丛中乡医院 謝步林介紹

主治：失眠。

症状：夜不能寐，或寐而即醒，醒后即不能入睡。

取穴：阳谿(双) 神門(双) 足临泣(双) 风市(双)
天宗(双)

手法：用毫针捻转进针，阳谿直刺五分，神門四分，用补法；足临泣直刺八分，风市直刺二寸，天宗直刺五分，均用泻法。留针二十五分钟；其他穴位留针二十分钟。每日针一次。

治驗：本方治疗失眠症共十五例，均一至三次痊愈。在针后并内服中药辅助治疗。处方如下：

枣仁安眠湯：生枣仁八錢、茯神三錢、远志二錢、白朮三錢、白朮二錢、甘草二錢。水煎，每日一剂，两次服。

第十一方 唐山市东矿区赵各庄联合診所、徐继介紹

主治：夜梦遗精。

症状：精神萎靡，心悸，心烦，夜間多梦性交之事而遗精，身体瘦弱。

取穴：膏肓(双) 腎俞(双) 志室(双)

手法：先以毫针直刺腎俞、志室两穴，各捻进二寸，旋捻得气后留针；三十分出针，每日针一次。并以艾球隔姜片灸膏肓穴五至七壮，灸后皮肤以灼红为度。

第十二方 唐山市东矿区古林診所 吳佩玉介紹

主治：梦交遺精。

症状：心悸，气促，心神恍惚，梦中性交遺精，面黃肌瘦，精神不振。

取穴：主穴：神門(双) 間使(双) 心俞(双) 膏肓(双)
志室(双)

配穴：三阴交(双) 足三里(双)

手法：用二十八号毫針按天、人、地三部进針法直刺神門、間使、膏肓、心俞各五分，隨用补的手法（針入天部得气后，令患者吸气，医者右手大指向后捻轉九次，于患者呼气时再捻針进到入部，如上法再捻轉一次，然后将針推入地部，仍用上法捻針）。留針三十分钟，徐徐將針退出，用棉球按压針孔。第二次治疗时，上穴去間使加志室，膏肓可不針，单用灸法，与志室穴同灸五至七壮。第三次治疗，于原来穴位再加配穴，手法同第一次。隔一日針灸一次。

第十三方 石家庄市第二医院 高輔汉介紹

主治：梦遺。

症状：梦中性交遺精，心悸，头暈眼花，精神不振。

取穴：志室(双) 腎俞(双) 关元 气海 三阴交(双)

手法：用毫針先刺腎俞、志室各五分，捻轉发生感应后出

針；再刺关元、气海各一寸，三阴交五至八分。捻轉得气后留針一小时。隔日針一次。每次取三个穴位，主穴志室、腎俞、关元、气海可以輪換使用。針治一周后，可間隔二至三日針治一次。

治驗：（一）宁晋县尙××，男，三十岁。患遺精，服药无效。取关元（补法）得气后即起針，針后当夜未遺精。第二診又針关元穴，則又遺精，后改为得气留針一小时，并灸命門，配志室、三阴交穴。用平补平泻手法，得气后留針，以后逐渐痊愈。

第十四方 灤平县中医院 吳滨介紹

主治：阳萎。

症狀：阳萎不举，不能性交。

取穴：主穴：关元 中极 气海

配穴：上髎(双) 次髎(双) 中髎(双)

手法：用毫針直刺关元二寸；中极二寸，气海一寸五分，上、中、次髎各直刺五分。关元用补法，使感应达会阴部，中极、气海、上、中、次髎，进針后以得气为度，留針三十分钟至一小时。隔日針一次，一般針治六次即痊愈。

第十五方 唐山市东矿区古林联合診所 吳佩玉介紹

主治：阳萎。

症狀：阳萎不起，不能性交。

取穴：主穴：公孙(双) 蠡沟(双) 腎俞(双) 志室(双)

配穴：三阴交(双) 中极

手法：用二十八号毫針直刺公孙三至五分，蠡沟沿皮向上刺三至五分，腎俞直刺五至八分，志室直刺五至八分。各穴进針后均用补法（大指向后捻針以及呼气进針为补，反之为泻），留針三十至四十分钟。隔日針一次。

禁忌：治疗期間忌房事。

治驗：深县溫长坨村雷××，男，四十五岁。于一九五六年患阳萎。經針以上各穴，三次即痊愈。

（二）古治十七鉄业社王××，男，三十二岁，工人。患阳萎已一年。經按上述穴位針治，四次即痊愈。

第十六方 石家庄市第二医院 高輔汉介紹

主治：阳萎。

症状：阳萎不起，不能性交。

取穴：关元 命門

手法：用毫針捻刺关元一寸五分，用补法，使感应传导到下腹部阴茎处，得气即将針旋捻退出；再以艾条灸关元和命門穴，灸至皮肤灼紅为度。每二日針灸一次，一周以后，針治間隔時間可延长二至三天針灸一次。

治驗：此方曾治疗数例，效果甚佳。

按：神經衰弱，是神經官能症中的一类。多由于精神过度紧张，如内心冲动、心理創伤或躯体疾患等所引起的高級神經活动障碍的反应状态。一般症状是：头痛、头晕、眩暈、失眠、记忆力衰减、多梦、心悸亢进、眼花、耳鳴、胸背疼痛、食欲不振、消化不

良、性欲减退、阳痿、遗精等病理反应。祖国医学对神经衰弱的认识，在《内经》中记载：“……脑为髓海，……髓海不足，则脑转耳鸣，脘酸眩冒，目无所见，懈怠安卧。”又载：“……思虑过度，面黑目赤，毛悴色夭，精神恍惚，故称肝劳……。”《伤寒论》载：“虚烦不得眠，酸枣仁汤主之。”以及后来医家对神经衰弱病因及症状都有详细的描述。本病症状虽多，不出心、肝、肾三经，脏气亏虚，诸邪相乘所致。在治疗方面，则着重整体治疗。上列十五方，取穴涉及全身经络。因经络在祖国医学理论体系中占着非常重要的地位，它同中医的基本理论、阴阳、五行、营、卫、气、血等有着密切的关系，尤其是对针灸疗法，一直起着重大的指导作用。它具有联系人体的五脏六腑、头身、四肢、百骸的功能，从而将人体各部连系成为一个有机的统一整体。用针灸疗法刺激经络，能加强周身血气的运行和调整人体正常的生理机能，使之恢复健康，彻底治愈疾病；不过神经衰弱最主要的治疗机转，还在于患者本身的精神疗养与内、外环境的有所改善，这也是防治神经衰弱的最有效方法。

祖国医学对于神经衰弱，不仅有完整的理论体系，而且有很宝贵的实际经验。兹综合介绍如下，以供参考。

主要穴位：足三里、三阴交、合谷、内关、神门，并应根据病情进行配合，如：

(一) 失眠：针神门、三阴交、心俞、通里、大陵、合谷。

(二) 多梦：针隐白、厉兑、少商、内关、大敦。

(三) 失眠，多梦：灸大椎、身柱、心俞、魂门。

(四) 前头痛：针头维、上星、印堂、太阳、列缺、照海。

(五) 后头痛：针风池、完骨、穹阴、委中。

(六) 侧头痛：针丝竹空、合谷、行间。

(七) 心悸亢进：针内关、神门、三阴交，灸气海、膻中。

(八) 眩暈，記憶力減退：針百會、四神聰、上星、頭臨泣、
豐隆、行間、解谿、陰都。

(九) 神經性消化不良：針三脘、足三里；灸脾俞、胃俞。

(十) 腹瀉：針合谷、氣海、關元、足三里。

(十一) 便秘：針支溝、天樞、陽陵泉、八髎。

(十二) 遺精早泄：針關元、中極、曲骨、三陰交；灸志室、
八髎。

(十三) 陽萎：針中極、關元；灸命門。

以上舉例所取各穴，在臨床之際，應根據不同的情況，而施以
不同的治療。

二十七、中 風 (共八方)

第一方 蘭縣燕郊人民公社馬起乏保健站 白福增介紹

主治：中風前驅症。

症狀：體質肥胖或體虛感覺指、趾端麻木，頭暈，舌強。

取穴：百會 風池(雙) 肩井(雙) 曲池(雙) 風市(雙)
足三里(雙) 絕骨(雙)

手法：用大艾炷(如小指肚大)先灸百會十壯，次灸風池、肩井、曲池、風市、足三里、絕骨等穴，每穴十至二十壯(體虛者多灸)。灸的次序，雙穴按男先灸左側，女先灸右側進行。隔二日灸一次，每四次為一療程。中間休息十天。

禁忌：灸後宜謹避風寒。

按：中風是臨床上常見的一種突然昏倒的急性疾患。祖國醫學認為中風有先兆之症，如劉元素說：“凡人如覺大拇指及次指麻木不仁，或手足不用，或肌肉蠕動者，三年內必有大風之至。”一般卒中病人發病之前，的確常有全身不適，頭重足輕，時發頭暈，皮膚麻木等不定性的征候。針灸治療，取用前述各穴，以增補氣血，驅風順氣，除痰降火為主要治法，但要注意生活及精神的修養，以促進病勢早愈。本方為中風預防常用的七穴名方，臨床使用，每有卓效。讀者可以自行掌握使用。

第二方 唐山市进步联合診所 刘汇川介紹

主治：口噤不开。

症状：牙关紧閉，口不能开。

取穴：主穴：曲池 合谷 太阳 颊車 内庭

配穴：下关 翳风

手法：用毫針直刺曲池、合谷各一寸，太阳、颊車、内庭、下关、翳风各四至五分。用平补平泻手法，留針三十分钟。

按：口唇部分为足阳明胃脉循行所过，如风寒袭入則筋攣、脉急、牙关紧閉而口噤；或风热内搦則痰涎滯膈，筋脉燥急而发生口噤。本方取穴局部与远距离两法相結合，以疏通經絡，当有卓效。

第三方 安国县城东乡医院 吳鶴鳴介紹

主治：四肢麻木不仁，知覺消失在五个月以內者。

症状：四肢不能移动，趾、指均不能活动，顔面肌肉顫动，六脉沉澀。

取穴：主穴：肩髃 曲池 阳池 后谿 翳风

颊車

配穴：环跳 风市 阳陵泉 絕骨 崑崙

行間 解谿 委中 承山

手法：用二十六号毫針先刺环跳二寸，阳陵泉一寸；再刺肩髃、曲池各一寸五分，阳池三分，翳风、颊車各五分，后谿、风市八分，絕骨、崑崙、行間、解谿

各五分，委中一寸五分，承山八分。用平补平泻手法，留针二十至三十分钟。出针后环跳、肩髃两穴以艾卷灸之，灸至皮肤发红色为度。隔日针灸一次。

治驗：本县城东乡里村李××，男，六十七岁。患四肢麻木，不能活动，颜面肌肉颤动，肌肉知觉消失。一九五九年四月三日来诊。当以二十六号不锈钢针按上述穴位针刺，患者毫无感觉；迨至第三次针灸时，每个穴位才有酸、麻、胀的感觉；在第四次治疗时，除环跳穴仍用二十六号毫针刺刺激外，其他穴位改用三十号毫针；六次后手足开始恢复活动和伸展；第十三次能在床上扶墙试步；第十五次后能挂拐下床活动；治疗至二十三次，已放下拐杖自由活动，痊愈。

第四方 龙烟钢铁公司宣化医院 薛孝先介绍

主治：半身不遂。

症状：中风偏瘫，不語。

取穴：合谷 曲池 手三里 肩髃 阳陵泉 阴陵泉
阳池 天柱 委中 足三里 条口 涌泉
期門 天枢

手法：以毫针先取健侧穴位，合谷刺入五分，曲池、手三里各一寸，肩髃一寸二分，环跳三寸，阳陵泉、阴陵泉各一寸，阳池三分，天柱四分，委中、足三里各一寸，条口二寸，涌泉四分，期門三分，天枢六分。手法用强刺激雀啄术，有感应后出针。（如脑血管栓塞者应用补法）患侧用单刺兴奋术。每天针

一次。（如血压不高者天柱、期門可以不刺）

治驗：疗程长短不定，有时針一次后患側手足能活动，有时針一至二周左右手足才能动作，漸漸在一至二个月内恢复健康。曾治疗九例，茲举二例介紹如下：

（一）宣化府后街赵××，女，四十八岁。住院号八九五号。主訴（爱人代訴）：“患高血压病及副鼻竇炎症。現病状：左半身不遂（左側），已有数日，每日因头痛不能食，精神不振，头痛剧烈，昼夜不得安眠，大便秘，小便赤。”既往史：患有高血压，曾服过西药，因有副鼻竇炎，在张家口医学院附属医院进行过抽脓手术一次。診斷及检查：血压一百四十至二百左右汞柱；脉洪紧，左側半身不遂，一切反应皆失（左側）；舌苔白，微黄；痛头剧烈，因头痛左眼抽小，大便秘，小便赤。治疗經過：入院半个月，經服利血平及注射硫酸鎂，血压降低到一百一十至一百六十汞柱左右。曾突然摔倒地上，又发生严重性的半身不遂，头痛剧烈，日夜不能安眠，服鎮靜及安眠、止痛药等，只能安靜一时，后仍痛如前。經会診：脉象洪紧，配合針灸治疗。取用上述穴位（患側），用强刺激（雀啄术）。因有副鼻竇炎牵引头痛，另針太阳、列缺、风池、上星、印堂，皆以强刺激（雀啄术）。針一次后手足腿能自动，但不太灵活。头痛每針一次可以睡眠三至四小时，但醒后又痛；半身不遂經一周后大有好轉。因患者有便秘症状，处以加減建瓴湯：生怀山药一两、生赭石一两、熟地五錢、生杭芍三錢、柏子仁三錢、当归五錢、川芎二錢、龙齿四錢、生石决明五錢、菊花四錢、草烏四錢、甘草一錢五分、石燕四錢。因有副鼻竇炎，头痛加辛荑三錢、川羌二錢、黄芩五錢；便秘加李仁五錢、火麻仁五錢、当归加至六錢至一两。每日一剂，每剂煎三次。經針灸及配合药物治疗，两周左右，症状減輕，自己能行走及端碗吃飯，逐漸恢复健康，愈后无任何残废。

(二) 龙烟鋼鐵公司炼焦厂张×，男，三十二岁，工人。住院号一五二四号。主訴（同人代訴）：“突然不会說話，右側胳膊腿皆不能动。”現症状：牙关紧閉，舌縮不能言語，神志清醒，大小便失禁，右側半身不遂，上肢較下肢严重，食欲不振。既往史：未患过任何传染病(严重传染病)，右眼較左眼小，微向內斜視。診斷及检查：血压：高压一百一十二；低压七十五汞柱。瞳孔反射較迟鈍，心音弱，肺呼吸正常，印象为栓塞性半身不遂（中风不語半身不遂）。提舉肌反射失常，患側肌腱反射失常，舌微白，脉象右寸虛弱，其他弦平。舌卷，飲食欠佳，大小便失禁。治疗：取用上述穴位。牙关紧閉，舌卷配頰車、廉泉。手法：不遂側，用弱刺激兴奋术，健側用强刺激雀啄术，不留針。在第一周至第二周，每日針一次。經針一至二次，舌能伸出；針十余次后，能說“年”字話；第三至第八周漸漸能行动及說話。后配合中药，处方：人參一錢五分、秦艽三錢、全蝎一錢五分、赤芍三錢、川芎二錢、归尾四錢、地龙三錢、黃芪一两、紅花二錢、桃仁二錢、甘草一錢。服后精神及其他症状逐漸好轉，恢复健康。

第五方 大名县城关人民公社医院 步景仲介紹

主治：半身不遂。

症状：头面軀干半側发凉、麻痺，口眼歪斜。

取穴：絲竹空 肩井 曲池 手足十宣，风門

胃俞 膀胱俞 委中 跗阳

手法：用三棱針刺手足十宣、委中出血。用毫針取患側絲竹空刺一分，向外斜刺风門、胃俞、膀胱俞，直刺跗阳各五分，按天、人、地三部进針。隨用提插捻轉补法，留針十至十五分钟。同时以銅錢蘸麻油刮

肩井穴，刮至皮肤紅紫为度。隔一至三日針一次。

第六方 大名县城关人民公社医院 步景仲介紹

主治：半身不遂。

症狀：头面軀干半側发凉、麻痺，口眼歪斜。

取穴：主穴：肩髃(双) 曲池(双) 肘髎(双) 合谷(双)
环跳(双) 风市(双) 伏兔(双)

配穴：阳陵泉(双) 絕骨(双) 崑崙(双)

取穴法：針环跳穴取側臥位，屈上腿，伸下腿取之。

手法：用毫針先針健側肘髎五至八分，肩髃、曲池各一寸五分，合谷一寸，环跳二寸，伏兔一寸，风市八分，阳陵泉一寸，絕骨、崑崙各五分。用捻轉、提、插手法，留針十分钟。再以艾卷灸患側穴位，灸至皮肤紅潤为度。隔日針灸一次。另服中药輔助治疗。处方：爬山虎一两、山葡萄根一两、全蝎三錢。水煎服，每日服一次。(上药为一剂，服三次)

按：爬山虎为絡石藤之俗稱。能通經絡，利关节，治痹痛、痛毒，并用作强壮药。山葡萄学名千岁藥，能舒筋、止痛。山葡萄蔓生山野間，叶似葡萄，結实如簇状，黄豆大，呈紫黑色，味甜可食。全蝎：主治諸风、癰疹、中风、半身不遂、口眼歪斜、語涩、手足抽掣。张錫純說：“性虽毒，轉善解毒，入肝經，搜风、发汗。”三药相合，用做輔助治疗，取效当更捷。

第七方 涿县涿鎮人民公社医院 史星三介紹

主治：半身不遂。

症状：偏瘫，患侧上下肢失去知觉，不能动转。

取穴：公孙 内关 百会 上星 环跳（患侧）

手法：用毫针先刺患侧公孙八分，内关五分，百会五分（沿皮向后刺入），上星四分（沿皮向前刺入），再直刺环跳穴四寸。捻针用补法（午前针男子以拇指向前，食指向后，针女子则拇指向后，食指向前；午后则反之），留针三小时。

治验：本方经治十余例，均痊愈。二便失禁者本方无效。

第八方 宁晋县寻岩村联合诊所 郭耀武介绍

主治：高血压性半身不遂。

症状：手足瘫痪，口眼歪斜，面色红赤，口角流涎，言语蹇涩，大脉大而有力。

取穴：主穴：百会 人中 涌泉 丰隆 人迎
肩髃 曲池

配穴：合谷 环跳 风市 阳陵泉 足三里
绝骨

手法：用毫针先刺百会、人中三分，次取健侧穴位，刺涌泉、丰隆各八分至一寸，人迎三至五分，肩髃、曲池各一寸五分，合谷一寸，环跳二寸，风市、阳陵泉、足三里各一寸，绝骨五分。丰隆穴用泻法，其他穴位均用平补平泻手法，留针三十分钟。起针后再依次刺患侧穴位，用补法，留针十五分钟。每日针一次。轻者十次，重者十五至二十次可痊愈。

按：半身不遂系中风的后遗症。发病的因素，祖国医学认为主要是思虑过度，七情失节，偏食酒食厚味，痰火内熾，卒受外风的侵袭，以致发病。初起时有中脏、中腑、閉症、脱症之分，继而邪滯于經脉，引起半身不遂。如灵枢刺节真邪篇載：“虛邪偏容于身半，其入深，內居荣卫，荣卫稍衰，則真氣去，邪氣独留，发为偏枯。其邪氣浅者，脉偏痛。”同时灵枢热病篇載：“偏枯，……病在分腠之間，巨針取之，益其不足，損其有余，乃可复也。”已指出治疗原則。古人还举出許多經驗穴位，如肩髃、曲池、大巨、冲阳、腕骨、阳輔、阳陵泉、环跳等。发展到近代，临床上則以曲池、阳陵泉为主；其他配用穴位，除以上列举的效穴之外，并使用天井、手三里、外关、合谷、风市、足三里、悬钟等穴位。在治疗措施方面，均先刺健側，后刺患側，以互相影响。但患側气、血滯閉已久，形成衰弱，宜針灸并用，則恢复較快。

二十八、口眼喎斜 (共八方)

第一方 任邱县汜水乡卫生院 庞萃仁介绍

主治：吊线风（口眼喎斜）。

症状：口眼喎斜。

取穴：颊车

手法：用皮针刺在颊车穴上，用胶布贴住，留针两天再起针。

治验：本街一妇女，二十岁。患口眼喎斜已七年，经多方治疗未愈。针刺颊车、地仓、合谷亦不见效；改用此方针二次即痊愈。

第二方 安国县祁州人民公社医院 李鹤鸣介绍

主治：吊线风。

症状：口眼向一侧歪斜。

取穴：迎香

手法：用长银针刺患侧迎香穴，捻转直刺一至三分，用厚纸一张，剪一小圆孔，露出针柄和针体，以防护患者面部。然后点燃酒精灯烧针柄，至针柄烧红为度；去灯火，候针身冷后出针，针孔处当有小白泡发出。如一次不能彻底痊愈，十日后可再针一次。

治验：此法治愈口眼喎斜患者甚多，治愈率在百分之九十以上。

兹举一例介绍如下：

安国县曲堤村王××，男，五十二岁。一九五六年患左侧口眼喎斜，經多方治疗，效果不甚显著。采用上法治疗，当烧針时患者感到面部輕松舒适，去針后口眼即轉正。十日后依法又治一次，痊愈。

第三方 霸县医院 王茂林介紹

主治：口眼喎斜。

症状：口眼喎斜，有时痙攣、麻痹。

取穴：主穴：列缺 阿是

配穴：地仓 颊車 人中 承浆 童子膠

取穴法：阿是穴在健侧口角内靜脉上。

手法：用毫針刺患侧列缺穴，針尖向上斜刺八分至一寸；取健侧地仓、颊車各針入四分；再刺人中、承浆、童子膠各三分。用平补平泻手法，得气后旋捻出針。隔日針一次。

禁忌：治疗期間忌飲酒。

治驗：本法治疗口眼喎斜，病程最短者一次治愈，病程較長者最多五次治愈。茲举典型病例介紹如下：

(一) 本县中学韓××，男，三十五岁。患口眼喎斜，历时七月余，来院診治。检查：脉象弦数。顏面向右侧傾斜，口角流涎，左目不能閉合，言語发音蹇涩。治疗：取穴患侧颊車、下关、合谷、童子膠，口腔内紫脉上出血，留針三十分钟。第二次治疗中取两侧穴位；第三次治疗后，言語如常，流涎停止，其后患侧、健侧輪換刺之；至第七次，顏面完全恢复正常，痊愈。

(二) 本县人委会張××，男，二十二岁。門診病历五三二八号。現症：口歪、言語、咀嚼障碍，已七年之久。检查：脉象緩

大。治疔：取穴同第一例。經針治二十八次，始恢复正常。

第四方 滄县中医学校 顾炳熙介绍

主治：口眼喎斜。

症状：口、眼歪向一侧。

取穴：主穴：地仓 颊车 太阳

配穴：人中 迎香 承浆 下关 风池

百会 列缺 合谷

手法：用长毫针先刺患侧地仓，进针后针尖向颊车捻进，达颊车穴后，用平补平泻手法旋捻留针；再针两太阳穴八分，旋捻留针；再刺人中、迎香、承浆、下关各三至五分，风池五至八分，百会沿皮向前斜刺三至五分，列缺针入三至五分，合谷五至八分。均用平补平泻手法，留针三十至六十分钟。隔日针一次。

附注：此法一般五至十次可痊愈，虽病程在五年以上，针十次后亦有著效。

第五方 正定县城关人民公社医院 朱从吾介绍

主治：口眼喎斜。

症状：半侧颜面神经麻痹，口眼歪向健侧。

取穴：主穴：地仓(双) 颊车(双)

配穴：风池(双) 人中 迎香(双) 间使(双)

阳白 承泣

加减法：头痛加列缺（双）、头维（双）。

手法：先以毫针刺患侧地仓穴，针透至颊车（勿刺出皮外），用重刺激手法，不留针。再刺健侧地仓、颊车、风池、间使及两迎香、人中穴，捻转留针十五至二十分钟。眼睑不能闭合，取患侧太阳刺出血，配阳白、承泣穴，刺入后轻度捻转一、二分钟，不留针；如头痛时，除刺两侧风池外，再刺两列缺、头维，留捻时间与上同。针后加灸患侧地仓、颊车、间使及人中穴各三壮。从开始治疗起每天针一次，连针三天以后，可每隔二至三天针一次。

治验：本方治疗口眼喎斜，轻者三至四次痊愈，重者六至七次痊愈。

第六方 唐山市东矿区赵各庄联合诊所 张耀先介绍

主治：口眼喎斜。

症状：半侧颜面神经麻痹，口眼歪向健侧。

取穴：地仓（双） 上关（双） 丝竹空（双）

手法：用毫针刺患侧地仓二寸，横向颊车，再刺上关八分，进针后针尖向下。丝竹空沿皮横向眉中，轻刺激留针；再刺健侧，手法用强刺激，不留针；再用梅花针由丝竹空打至上关，由上关打至地仓，循环叩打五至六分钟。然后将毫针起出，或患侧不用毫针，单以梅花针叩打弹刺亦可。每天针一次，连针三天即痊愈。

第七方 藺縣佛辛庄保健站 張潤甫介紹

主治：口眼喎斜。

症狀：半側顏面神經麻痺，口眼歪向健側。

取穴：主穴：地倉 頰車 人中 合谷 下關

配穴：風池 翳風 耳門 頭維

加減法：局部有麻感加四白、迎香；口頰內有青紫筋者刺出血。

手法：用二十八號毫針取患側地倉、頰車各刺入一寸，使兩針尖相對，慢慢旋捻進針，再刺人中五分，合谷、下關各一寸，慢慢旋捻，用輕刺激手法。如患側局部有麻感時刺迎香五分，四白三分。其他配穴如耳門穴可刺入五分，翳風刺入八分，頭維沿皮向後刺入八分，風池可直刺一寸。以上主穴每次均須使用，配穴可酌予採用。留針時間一小時，每兩天針一次。另外檢查患者口角內如有青紫色血筋時，可用三棱針刺筋上出血。輕者五次，重者十次即痊愈。

第八方 河北省中醫研究院門診部 景象介紹

主治：口眼喎斜（吊綫風）。

症狀：口角歪，口閉不嚴，患側眼瞼下垂，鼻唇溝消失或變淺。

取穴：主穴：頰車 地倉 水溝 禾髎 四白

配穴：列缺

取穴法：仰臥位。口角向左歪刺右，向右歪者刺左。

手法：用毫針刺頰車穴，橫針進至地倉穴位，另取刺水溝穴，橫針刺向禾髎，亦須針至禾髎穴部位。四白刺二至三分，列缺斜向上刺八分。用輕刺激補法，留針四十分鐘。在留針時間內，列缺刺入部位以艾條灸之，至出針時止。

附注：（一）本方約治九十例，根據臨床體會，病程在四周以上的較難治；因腦瘤引發本症的非本方所能治療。

（二）治療後患側面部應以毛巾敷遮，勿見風，並保持情緒上的安靜。

按：“口眼喎斜”，又稱“口僻”。本病與現代醫學所稱“顏面神經麻痺”或“面癱”為同一種類的疾病。本病的發生，由於氣血不足，外中風邪所致。歷代醫學文獻，大都列入中風門中，為中風四大症候之一的“中絡症”。金匱要略載：“喎斜不遂，邪在於絡。”巢氏諸病源候論載：“風邪入於足陽明，手太陽之筋，遇寒則筋急引頰，故使口喎僻，言語不正，而且不能平視……。”林珮琴類証治裁載：“口眼喎斜，血液衰弱，不能榮潤筋脈。”醫林改錯口眼歪斜辯載：“若壯盛人無半身不遂，忽然口眼喎斜，乃受風邪阻滯，氣必不上達……。”綜觀上述文獻分析其致病因素，系“身體虛弱，風邪入絡，經絡為風寒阻滯，氣不能上達”所致。在治療方面，靈樞經筋篇載：“足之陽明，手之太陽，筋急則口目為僻，眦急不能卒視……。”又載：“足陽明之脈，……挾口，……環唇。”這種記載已明確指出了本病的經絡所屬，故後世均以這種原則來取穴，如甲乙經載：“口僻，頰髎及顴交，下關主之。”“目痛，口僻，目不明，四白主之。”張景岳說：“目之斜，灸以承泣，

口之喎，灸以地仓，不效者当灸人迎。”玉龙歌载：“口眼喎斜最可嗟，地仓妙穴連頰車。”这些治疗經驗，大都取之阳明經穴。以上八方，取穴处方大都在局部取穴，而主穴都为足阳明經穴，如頰車、迎香、地仓、承泣、下关、四白、承浆等，主要是以經絡病理反应为准繩，因而重点取阳明經穴，并在配穴上取其他阳經穴位，以祛散风邪，調和营卫，促使經脉气血运行正常，經絡平衡統一，从而达到治愈的效果。这也充分說明祖国医学遗产經絡学說是具有科学性的。

二十九、暴瘖不語 (共二方)

第一方 安国县祁州人民公社医院 李鹤鸣介绍

主治：暴瘖。

症状：突然舌强不語。

取穴：聚泉

取穴法：正坐，口张开，聚泉穴在舌面正中央，正对舌面下海泉穴。

手法：术者左手消毒，以拇、食二指钳住患者舌尖，用长圆利针刺聚泉穴，针尖向舌根方向刺入一寸。单刺不留针，出针令恶血流出口外。

治驗：本县北七大村张××，男，二十七岁。于一九五四年七月間，患暴瘖不語来門診。家长代訴：“突然不会說話，飲食、二便正常，經医院治疗数日未效。”检查：精神无异常，舌木强，不能弯曲。印象：暴瘖。經以长针刺聚泉穴寸許，用单刺法，出针后流出恶血，患者当时即能說話，言語恢复正常。

第二方 承德医专附属医院針灸科介绍

主治：不語症。

症状：突然不会說話，听觉正常。

取穴：涌泉

取穴法：平臥位，涌泉于足心人字紋頂点处取之。

手法：用圆利针。进针时将刺侧足腕握住，刺涌泉穴一至

二分，用搗針手法捻搗一分鐘左右，以感覺麻、痛為度；如仍不能言語，再刺另一側。一般只刺一側，語言即恢復正常。

治驗：（一）馬××，男，三十六歲。門診病歷五〇九七〇號。現症（病人筆談）：“四年前突然不會說話，听力正常。病前經常好說夢話，病後就不說了。咳嗽時有聲音，其他無自覺症狀，飲食、起居、勞動均正常。曾作過數次針灸治療，所取穴位，皆為上肢及頸部穴，未發生效果。”既往：健康。檢查：體格中等，營養良好，表情自然，除咽頭反射消失外，其他無異常。診斷：不語症。當時針刺雙側涌泉，進針後立即發言；開始說話口吃，繼用搗刺手法，談話變為流利正常。

（二）趙××，女，二十二歲。門診病歷四三一二三號。主訴（筆談）：“發病已一周，胸內堵塞感、失眠，食欲減退，經過服藥及針灸兩次不效。”既往：健康，月經正常。現症：表情不愉快，能以筆談方式回答問題，不張嘴，拒絕檢查咽喉部。體檢：未發現異常，神經系統反射正常。經針刺涌泉（右側），立即發言，言語恢復正常。半年後復發，不能說話，三小時後來診，為針刺左側涌泉，立愈。

（三）李××，女，十二歲。門診病歷一七二三一七號。其母代訴：“不能說話已三天，能听，能寫字回答問題，平時個性強，好生氣，從來健康。”檢查：體格及咽頭部未發現異常。治療：針涌泉（右側）立即哭出聲來，訴說麻、痛，哭停止後語言恢復正常。

按：暴瘖症是一種發音障礙的失語症。起病促急，輕者聲粗而啞，重者啞不出聲。靈樞憂患無言篇載：“人之卒然憂、患而言無音者，……寒氣客于厭，則厭不能發，發不能下致，其開闔不致，故無音。”“足之少陰，上系于舌，絡于橫骨，終于會厭，兩瀉其血脈，濁氣乃辟。會厭之脈，上絡任脈，取之天突，其厭乃發

也。”素問脉解篇載：“內奪而厥，則為喑俳，此腎虛也。”具體地指出原因、症狀及治療重點取穴之所在。又甲乙經也記載了許多治療暴瘖的經驗穴位：“暴瘖氣梗，刺扶突與舌本出血。”“暴瘖不能言，喉嚨痛刺風府。”“暴瘖氣梗、喉痹、咽痛不得息，食飲不下，天鼎主之。”此外還列舉了很多主治穴位：如“腦戶”、“通谷”、“期門”、“支溝”、“合谷、涌泉、陽交”。上列兩方，取穴于足少陰經脈之上、下兩端，直瀉本經之邪，所以都獲得滿意的效果。

三十、高血壓 (共七方)

第一方 天津市和平区东北角門診部 张利輝介紹

主治：高血压。

症状：头痛，眩暈。

取穴：主穴：上星 太阳(双) 风池(双) 风府(双)
头維(双)
配穴：大椎 合谷(双) 十宣 大敦(双)
至阴(双)

手法：先以三棱針刺十宣、大敦、至阴出血，再用毫針向上沿皮肤刺上星二分，太阳直刺五分，风池直刺五分，风府四分，头維向上沿皮刺四分，大椎直刺三分，合谷五分。进針后捻轉提插，用輕泻手法，留針三十分钟。隔日針一次。第二次治疗时十宣、大敦、至阴不再刺，只第一次时使用。

第二方 天津市和平区劝业場門診部 金鈺堂介紹

主治：高血压。

症状：头眩暈。

取穴：曲池(双) 合谷(双) 足三里(双) 三阴交(双)
血海(双) 太冲(双)

手法：用毫針捻轉进針，刺曲池二寸，合谷六至七分，足

三里一寸五分，三阴交五至七分，血海一寸五分，太冲三至四分。左右捻转，用平补平泻手法，至发生酸、麻感应后停针，留针三十分钟。在留针时间内捻动二至三次。隔日针一次。

第三方 天津市天津化工厂职工医院 宋玉梅介绍

主治：高血压。

症状：头痛、头晕、头胀、眼花、失眠，四肢乏力，食欲不振，或胸前区疼痛。

取穴：主穴：高血压

配穴：百会 太阳（双）

取穴法：仰卧屈膝。高血压穴在足三里穴下一寸五分（即足三里、上巨虚两穴中间）。

手法：用毫针旋捻进针，刺高血压穴一寸五分，使感应达足脛部，百会向后沿皮刺二分，太阳直刺八分。均用中等度刺激，留捻二十至三十分钟。每日针一次，至血压下降到正常症状消失后，再每隔二至三日针治一次。连针十余次，以巩固疗效。

禁忌：勿吸烟、饮酒，保持情绪稳定。饮食物宜低盐或无盐。

治验：本方治疗八例高血压患者，其中病程最短的是六个月以上，最长的是八年；针治次数是六至四十一次，均已全部治愈。兹举典型病例介绍如下：

（一）郝××，女，四十二岁。患高血压已八年。头疼、头胀，眼花、四肢酸疼、倦怠，记忆力差，饮食过少，并经常昏

迷，不能走路。血压：舒张压一百毫米汞柱，收缩压二百一十毫米汞柱。經十六次針治后，舒张压七十毫米汞柱，收缩压一百四十毫米汞柱。症状消失，食欲良好，能外出活动，續作巩固治疗，前后共計三十九次，观察三个月，血压：舒张压七十毫米汞柱，收缩压一百二十毫米汞柱，情况良好，痊愈。

（二）郑××，男，四十二岁。主訴：“患高血压年余，經常头疼、头晕，飲食少，四肢无力，不能坚持工作，經各医院多次治疗，不見好轉。”检查血压：舒张压八十毫米汞柱，收缩压一百九十五毫米汞柱。当即按上方針治，二十三次后血压：舒张压八十毫米汞柱，收缩压一百三十五毫米汞柱。自覺症状完全消失，观察两个半月，血压：舒张压七十毫米汞柱，收缩压一百二十毫米汞柱，一切正常，并已恢复工作，痊愈。

第四方 保定市要山人民公社卫生院 陈文明介紹

主治：高血压。

症状：头晕，头痛，耳鳴。

取穴：第一組：百会 通天 后頂 絡却 大椎

第二組：合谷(双) 足三里(双)(上兩組穴位輪換使用)

手法：用毫針以切指法进針。沿皮向后斜刺百会、通天、后頂各三分，絡却沿皮刺四分，大椎直刺八分（以上第一組穴位在第一次时使用）；第二組穴位足三里、合谷各直刺一寸。上穴均使用雀啄术，留針二十分钟。每两天針一次。

第五方 张家口市机关门诊部 王士胤介绍

主治：高血压。

症状：经常头痛、头晕。

取穴：耳廓部脑皮质区 肾上腺区

取穴法：坐位或卧位。肾上腺区在耳珠前下方凹陷处；脑皮质区在内耳轮下方，耳珠对侧稍下方凸起处。

手法：先用探针或银针在以上两病区内确定敏感点做为刺点，再以二十八号或三十号一寸长毫针直刺下针，深度一分五厘，向一侧捻转，至发生剧痛停针；针刺的强度以局部针之周围稍有突起，色变苍白为度。十五分钟捻转一次，留针一小时。每日针一次。

治验：（一）王××，女，四十岁，平部。患高血压病，经常头痛、头晕。血压：收缩压二百一十毫米汞柱，舒张压一百二十毫米汞柱。按上穴针二次后，血压下降，收缩压为一百二十四毫米汞柱，舒张压八十毫米汞柱。观察两周后未再上升。

（二）王××，女，三十五岁，助产士。主诉：“患高血压病数年，经常头痛、头晕，曾服中药多剂效果不大。”检查血压：舒张压一百一十毫米汞柱，收缩压二百一十毫米汞柱，营养良好，其他无异常发现。一九五九年七月十日开始用上法治疗，取穴脑皮质下区、肾上腺区。共针五次，每次血压均有下降，一周后血压：舒张压八十八毫米汞柱，收缩压一百二十毫米汞柱。观察两周，血压稳定。

第六方 唐山市第一医院介绍

主治：特发性高血压。

症状：头痛、头晕、头胀，往往失眠或心慌、气短，左上胸胀痛。

取穴：人迎（双）

取穴法：仰卧位，于结喉旁平开一寸五分，有动脉应手。

手法：使患者平卧安静五分钟后，用三十二号毫针刺入迎穴，用轻度捻转进针法，深达一寸左右，看到针柄随动脉搏动而振动时，即为达到正确部位的目的。进针后不再用何种补泻手法，留针五分钟。每日针刺一次，五次为一疗程。中间休息一周，再进行第二或第三个疗程。

禁忌：戒烟、酒，少食盐分与脂肪过多食物。

治验：针刺人迎治疗原发性高血压三十四例，一般一个疗程即可，最多不超过两个疗程。在治疗中，有的血压一直下降，有的徐徐下降，个别病例不降。三十四例（包括不同病期）的临床疗效：有效率为百分之百，治愈率以第一期为最高，占百分之七十一。点六。兹举典型病例二例介绍如下：

（一）陈××，男，三十四岁，工人。患高血压已二年之久，经常有头痛、头晕、失眠等症状，经各种治疗未效，患者悲观失望，情绪低落。入院时血压检查：舒张压一百三十毫米汞柱，收缩压一百八十毫米汞柱，理、化及眼底检查无异常，经针刺人迎穴三次后，血压下降，舒张压为一百毫米汞柱，收缩压一百六十毫米汞柱。停止针刺后观察两月，血压未再增高。

（二）张××，女，五十岁，家庭妇女。主诉：“头疼、头晕已四年之久，服过多种中、西降压药物无效。”检查血压：舒张压一百一十毫米汞柱，收缩压一百九十五毫米汞柱。眼底检查：有小动脉硬化，爱克斯光线检查心脏第一弓扩大。经针刺人迎后，血

压：舒张压下降十毫米汞柱，收缩压下降十五毫米汞柱。针刺第二次后，舒张压下降到九十毫米汞柱，收缩压一百六十五毫米汞柱。针第三次后，舒张压续降五毫米汞柱，收缩压续降十五毫米汞柱。针第四次后，血压下降到正常范围，舒张压八十毫米汞柱，收缩压一百四十毫米汞柱，自觉症状完全消失。五次后，停止针刺。观察两个多月，血压未见增高。

第七方 静海县医院 公茂德介绍

主治：高血压。

症状：头晕、头痛、头胀、失眠、心跳、气短或手足麻木等。

取穴：第一组：足三里(双) 鸠尾 曲池(双)

第二组：肝俞(双) 风池(双) 身柱 (以上两组穴位可交替使用)

手法：用毫针以管针进针法入针。第一组穴位：足三里刺入二寸，鸠尾向上斜刺五分，曲池直刺一寸五分。第二组穴位：肝俞直刺七至八分，风池一寸四分，身柱刺三至五分。手法均用强刺激，行六数（提插六次一停，共重复六次），留针二十至三十分钟。每日针一次。

禁忌：针后注意休息，戒烟、酒，饮食宜清淡，忌多盐多脂肪性食物。

治验：应用上述穴位治疗高血压病，根据一九五三年三十八名病例疗效统计，有效率为百分之八十四点二。兹举两例介绍如下：

(一) 张×，女，二十岁，学生。一九五三年三月二十一日门诊。主诉：“自一九五一年六月开始有头晕、头痛等症状。”检

查血压：舒张压八十毫米汞柱，收缩压一百八十五毫米汞柱，其他体征无阳性所见。二十六日开始治疗，针刺足三里、鸠尾、合谷、太阳、丝竹空等穴；十五次后，血压下降到正常，舒张压七十毫米汞柱，收缩压一百一十四毫米汞柱，症状消失；观察期五个月，九月二十九日血压：舒张压七十毫米汞柱，收缩压一百一十毫米汞柱。

(二) 赵××，女，六十岁，工人。因脑瘀血住院六个月，身体已能自主活动，惟尚感头晕、发热、失眠，左侧手足麻木、心跳、气短。检查血压：舒张压一百毫米汞柱，收缩压二百四十八毫米汞柱，心界向左扩大一横指，心音正常，右腿底静脉曲张，返光增强，为针太阳、曲池、丝竹空、少商等穴。针二十八次后，血压下降，舒张压七十毫米汞柱，收缩压一百六十二毫米汞柱，自觉症状至此已消失。观察三个月，血压：舒张压七十六毫米汞柱，收缩压一百五十毫米汞柱。

按：高血压症，祖国医学典籍中无此名称。但本症各种病候的描述，却有很多记载，如内经标本病传论载：“肝病头目眩……。”灵枢五乱篇载：“经脉十二者，……相顺则治，相逆则乱，……清气在阴，浊气在阳，营气顺脉，卫气逆行，清浊相干，乱于胸中，是谓大悞。……乱于头则为厥逆，头重眩仆。”杂病篇载：“厥挟脊而痛者，至顶，头沉沉然，目眈眈然，腰脊强……。”脉要精微论载：“……上实下虚，为厥颠疾。”至真要大论载：“诸风掉眩，皆属于肝；……诸厥固泄，皆属于下……。”喻嘉言说：“半身不遂，口眼喎斜，头目眩暈，痰火熾盛，筋骨时疼，乃源于血虚、血热、挟痰、挟火、经络、肌表之间，先已有其病根，后因感冒风寒，或过食醇酒、膏粱，而助痰火；或恼怒而逆肝气，遂成此疾。”从以上文献记载来看，凡本症的病因、病理、症状等，都很清楚扼要而简单的交代出来。充分说明本症的上实、

下虛，病在肝、腎兩經。由于人們的不注意攝生，身體內、外環境的不相協調，以致腎水不足，肝陽偏亢，筋脈拘攣，氣血逆亂所造成。在不同的體質、誘因的基礎上，出現了輕、重不同的病理反應。在治療上，靈樞載：“……氣在於心者，取之手少陰心主之輸。……氣在於頭者，取之天樞、大杼；不知，取足太陽榮，輸……。”“……申守其輸，而調其虛實……。”“……厥在經脈，故當隨經以治，經氣盛者瀉而疏之……。”“厥挾脊而痛至頂……取太陽腦中血絡。”上面幾節經文指出了其治療重點在足之少陰與足之太陽兩經。治療原則，歷代諸醫家均以祛風、活血、順氣為主。上列諸方，或先取井穴以通氣、活血，或取諸會穴、俞穴以調血、祛風，或于耳區刺其輸穴以鎮痛，或取合穴以利其氣，使血活、氣行，均配合陰陽諸經脈，進行全面治療，所以都俱有療效。在本症的治療經驗方面，據唐山市洼里聯合醫院馮德謙老夫介紹，除刺一般穴位外，同時刺腦中（委中）血絡出血，療效很好，讀者可以參考結合使用。在使用穴位方面，除以足三里、三陰交、曲池、合谷、人迎為主穴外，根據不同的病情酌配鳩尾、百會、風池、太陽、前頂、上星、頭維、絲竹、內關、手三里、陽陵泉、陽輔、太沖、行間、中封、內庭、涌泉、血海等穴，輪流使用。

三十一、頭 痛 (共十六方)

第一方 河北中医学院 刘殿元介绍

主治：风火头痛。

症状：两颧发红，青筋暴现，脉象浮洪。

取穴：阿是(双) 绝骨(双) 崑崙(双) 合谷(双)

列缺(双)

手法：先取阿是穴(颧部青筋上)，以三棱针刺出血；再以毫针顺序刺绝骨、崑崙直刺入五分，捻转进针；合谷、列缺针五至八分。列缺针锋斜向肘部，崑崙捻针使感应上达股部。各穴捻针俱用泻法(吸气进针、呼气出针)，留捻五分钟出针。

治验：阜平县王××，男，二十五岁。患两侧头痛，颜面发红，额上小动脉搏动可见，脉象浮洪。即取上穴，当时痛止。

第二方 天津市立第一医院 楊景輝介绍

主治：头痛。

症状：慢性阵发性全头痛。

取穴：主穴：合谷(双) 足三里(双)

配穴：阳陵泉(双)

手法：用毫针旋捻进针，各穴刺八分至一寸。两侧同时旋捻，以发生酸、麻感应为度，留针三十分钟。每日

或隔日針一次。

治驗：（一）徐××，女，七岁。患陣发性头痛已二年余，发作时疼痛剧烈，痛区以前額及眉棱部位为明显，时伴有呕吐或恶心。体检：无异常发现，脉象两关沉滞，左尺独弦。印象为肝脾不和头痛。按上穴針一次痛止；月余后因哭泣复发，經連續針治五次，半年来未再发作。

（二）张××，女，十八岁。門診病历三四〇三号。患陣发性头痛已二年余，时重时輕，痛区以前額为甚，并伴有胸胁胀悶、肢倦，月經不正常，发作期影响食欲。經取穴阳陵泉、足三里，針五次头痛痊愈。

第三方 磁县柳园人民公社卫生院 王天德介紹

主治：头痛。

症状：前头痛或半側头痛。

取穴：太阳（双） 风池（双）

取穴法：坐位。太阳穴当叩齿时，顳顳部骨縫处肌肉有振动，刺时稍张口取之。

手法：用毫針捻轉进針，深入骨縫中約一寸半，捻針时大指向前九次，向后九次，将針提出一分，稍稍旋捻，使发生感应后，再提針至皮下，此时多数患者痒感消失。再直刺入內，手法如前，如此重复三次后出針。如第一次經過旋捻后，头尚有微痛，必須用上法提插旋捻，迨疼痛消失后，仍依前提插旋捻二次，以巩固疗效。倘施术前头痛不甚剧烈时，則进針后大指向前捻三次，向后捻二次，手法亦可重

复三次后出针。如偏头痛，以风池为主，手法同太阳针法。

治驗：牛××，男。患前头痛，剧烈时，神志昏迷。經針两太阳，一小时内，疼痛消失。

按：太阳、风池专疏泄头部的风热，因此对风热上攻的头痛，可以适用。

第四方 深县城关保健站 刘兆祥介绍

主治：全头痛、偏头痛。

症状：前头痛或半侧头痛。

取穴：百会 合谷(双) 曲池(双)

加减法：前额痛加攒竹(双)、上星；后头痛加风池；偏头痛加头维(双)、太阳(双)；感冒头痛加大椎。

手法：用毫针刺百会，进针向前，沿皮刺入五分，头维向下刺入五分，用平补平泻手法。大椎向前刺一寸五分，合谷刺一寸，用泻法，曲池刺一寸五分，用平补平泻手法。各穴位发生感应头痛停止起针。

附注：前头痛以上星、攒竹为主；后头痛以风池为主；偏头痛以头维、太阳为主；感冒头痛以大椎、合谷、曲池为主。

治驗：(一) 本县南小召村芦××，女，七十岁。头痛三月余，时轻时重，发作前觉上肢发热，下肢发凉，心跳，虽痛轻时亦感头晕。經中西药治疗未效；經取用上穴，針三次，痊愈。

(二) 束鹿南庞营齐××，女，七十三岁。头痛三月，症状与上例相似，經用上述穴位針治四次，痊愈。

第五方 怀安县万全医院 楊宁武介紹

主治：神經性头痛。

症状：头目昏沉鈍痛，或有目眩、耳鳴、心悸、失眠、肢体倦怠乏力等，每因精神受刺激而引起头痛。

取穴：合谷(双) 太阳(双) 肺俞(双) 胃俞(双)

針具：水針(注射器一具，0.5%奴弗卡因溶液6西西)。

手法：注射器严密消毒，吸入药液，以无菌操作术注入上述穴位中(肺俞、胃俞穴位，每次采用对侧各一，呈上下交錯状，重复輪換注射)，每穴注入一毫升，注入肌层中。上穴每日注射一次，連續注射四至五次。

按：水針疗法，是近代針灸科学研究机构試行穴位注射水液或药液疗病的方法，而代用針术。在本法的使用上，也是以經絡診斷为基础，以循經取穴，进行施治。

第六方 東鹿县郭西人民公社卫生院 范溫祺介紹

主治：前头痛。

症状：前額部疼痛，并两側头部有跳痛感或鈍痛。

取穴：中渚(双)

取穴法：坐位，手掌平伸或握拳，于第四和第五掌骨之間液門穴之上，与掌內之少府穴相对。

手法：用毫針捻轉直刺，深度五至六分。左右旋捻提插强刺激，每十分钟搖动一次，使感应上达肩部或头部。留針三十分钟，直拔出針。

第七方 霸县后奕乡医院 錢沛介紹

主治：后头痛。

症状：后脑海部疼痛。

取穴：后谿(双) 风府

取穴法：坐位。后谿两臂平放屈肘，握拳取之。风府正坐头向前倾，后发际上头骨尽处取之。

手法：用毫针刺后谿，捻轉刺向手心一寸，风府捻轉直下刺入六分。左右捻轉，用平补平泻手法，发生感应后留針三十分钟。如头痛未尽消失，可在留針時間內再提插旋捻之。

第八方 汉沽盐場储运厂保健站 韓志英介紹

主治：头痛。

症状：头頂疼。

取穴：列缺

手法：用毫针刺列缺穴，捻轉进針向上斜刺，以有酸、麻、胀感觉为止。留針三十分钟。

治驗：盐場工人刘××，男，三十岁。于一九五九年五月十八日患病。自訴：“头痛，无既往头痛史。”經检查：头頂部皮肤有过敏性压痛，全身未发现任何阳性体征。針列缺一穴，用平补平泻手法，留針三十分钟即痊愈。

第九方 乐亭县城关人民公社医院 赵庆聞介紹

主治：头痛。

症状：头痛，两目視物不明。

取穴：主穴：风府 风池(双)

配穴：足三里(双) 三阴交(双)(两穴輪用)

手法：用毫針先刺风府穴，捻轉进針，針进入皮下后，即斜向兩側风池穴(先向一側留捻十五分钟，提至皮下再向另側风池进針)，得气即留針。足三里或三阴交进針后捻轉，用平补平瀉手法，同时留針。每日或隔日針一次，七次为一疗程。

治驗：本县范庄完小李××，男，三十岁。患慢性头痛一年余，經按上穴針治六次，痊愈。

第十方 宝坻县五百戶卫生院 田士勛介紹

主治：头痛。

症状：陣发性头痛，牽引眼痛，重者目失明；后头痛停止。

取穴：肝俞(双) 命門

手法：用毫針捻轉进針，肝俞刺入五分，命門直刺八分。用平补平瀉手法，旋捻至发生感应为度。留針十分钟。

第十一方 靜海县医院 公茂德介紹

主治：偏头痛。

症状：发作时視力有偏盲、头晕、头胀等不适感，头痛多为一側，有时全头痛，伴有恶心、呕吐，多有家族史。

取穴：主穴：列缺 絲竹空

配穴：太陽 頭維（以上穴位只取患側不取健側）

手法：用毫針管針進針法。列缺斜向肘方刺二至三分，絲竹空直刺六至七分，太陽直刺五分，頭維向后斜刺三分。手法捻轉提插，使用強刺激，留針三十分鐘至二小時。

治驗：一九五五年曾做十二例統計，療效為百分之百。其中一例因勞累復發，其他愈後觀察，均未再復發。茲舉三例介紹如下：

（一）李××，男，二十四歲，軍人。門診病歷六七八五三號。一九五五年十一月二十九日就診。主訴：“自一九五二年二月，頭陣發性刺疼，看書時頭昏，記憶力減退，現在後頭痛顯著，每天上午發病，發作時伴有輕度惡心，不嘔吐，不流淚；但眼有似拳擊樣的不適感覺，不發燒，食欲正常”。檢查：營養、發育均好，心肺無異常，血壓七十至一百一十毫米汞柱，梅毒反應（一）。母親有頭痛史。診斷為偏頭痛。曾針合谷、太陽、陽白等穴後止痛。十二月八日復診，又針太陽、合谷後，停針，追蹤觀察結果，已痊癒。

（二）賈××，男，三十四歲，軍人。門診號七九六九三號。過去沒有頭痛歷史，于一周前因天熱，突然頭痛發作，經抬到宿舍後服阿托品及休息後即愈。此後，每日發生头疼，約每隔二小時痛一次，服藥也不見效。至一九五五年七月二十七日因頭痛不能忍受，而急診來院求治。當時頭痛劇烈，集中在右側額部，並伴有惡心、嘔吐、鼻涕、眼淚交流，自述非常痛苦。近日常因頭痛不能安眠，早晨減輕，早飯後逐漸加劇。查體：身體肥胖，心肺無異常，腹柔軟，肝脾未觸知，頸不強直，瞳孔對光反射正常，膝腱反射正常，血壓八十五——一百二十毫米汞柱。診斷為偏頭痛，于一九五五年

七月二十七日开始針灸。經針合谷、右絲竹空、下关等穴后，当时止痛。由于第二日看电影过累又复发，但症状已不剧烈，而且也不伴有恶心、呕吐、流眼泪等症状。遂于七月三十日入院治疗，住院后針一次已基本止痛，又連續針四次后于八月十二日停止針灸痊愈出院。追踪观察結果，病人自述出院后再沒头痛过。每天坚持十小时工作已毫无問題。

(三) 张××，女，二十九岁。門診号七七七五六号。病人近六、七年来常感头痛，发作时很剧烈，重时不能睜眼。发作时多由前头开始，漸向后头放散，时左时右，有时全头部都疼，伴有恶心、呕吐，每持續二至三天。头痛后数日間有头晕，記憶力减退，常因感冒及情緒不愉快而发病。最近，由一九五五年十二月二十日开始发病，十二月二十九日开始加剧，遂在十二月三十日急診来院求治。查体：左侧副鼻窦有明显压痛，咽喉不充血，心尖部有輕度收縮期杂音，心界不大，肺无异常，腹柔軟，肝脾不肿大。血压七十——一百一十毫米汞柱。一九四四年曾患恶性瘧疾，一九五三年患两側上颌竇炎，經根治术后治愈；母亲有头痛史。診斷为偏头痛。病人于急診来院求治时即接受針灸治疗，針列缺、合谷、絲竹空等穴，針三次后疼痛已基本消失；又連針二次痊愈而停針。追踪观察結果已痊愈，病人情緒很好。

第十二方 武清县河西务人民公社医院 潘庆奎介紹

主治：偏头痛。

症状：发作时視力有偏盲、头晕、头脹等不适感，头痛多为一側，有时全头痛，伴有恶心、呕吐，多有家族史。

取穴：风池(双) 头維(双) 太阳(双) 阿是(均取患側)

取穴法：坐位，阿是穴于头维、神庭联线中间取之。

手法：用毫针刺头维五分，针尖沿皮向下，太阳直刺五分，风池针入一寸（左痛取右，右痛取左），针尖斜向对侧眼窝。阿是穴进针后沿皮向上下两方，捻转不超过一百八十度。其他各穴用平补平泻手法，留针三十分钟。

第十三方 黄驊县旧城人民公社大郭庄 张德甫介绍

主治：习惯性偏头痛。

症状：发作时视力有偏盲、头晕、头胀等不适感，头痛多为一侧，有时有全头痛，伴有恶心、呕吐，多有家族史。

取穴：主穴：颌厌 悬颅 悬厘（均取患侧）

配穴：合谷（患侧）

手法：用长毫针自颌厌刺入，针尖向下捻转针至悬厘穴处（一针担三穴），旋捻用平补平泻手法后留针。再刺合谷穴一寸，旋捻用强刺激手法，留针三十分钟。每两天针一次，针三至五次即痊愈。

第十四方 唐山市东矿区古林联合诊所 李玉良介绍

主治：偏头痛。

症状：阵发性侧头痛，痛时波即眼球发生压痛，重者患侧眼失明。

取穴：主穴：至阴 太阳（均取患侧）

配穴：列缺（患側）

手法：用毫針捻轉進針，至陰針尖向上斜刺二分，太陽直刺六至八分，列缺進針後沿皮向上斜刺三分。各穴均用瀉法（大指向前捻），留針三十分鐘。每日或隔日針一次，重者四次可痊癒。

第十五方 保定市團結人民公社衛生院 臧中興介紹

主治：偏頭痛。

症狀：單側頭痛，發作無時，經久不癒。

取穴：率谷 絲竹空

手法：用毫針由率谷進針，旋捻進針後刺向絲竹空。手法要輕慢，針尖進達絲竹空時停針，留針二小時，徐徐出針。每日或隔日針一次，連針三次，以巩固療效。

治驗：唐縣大張各莊莊××，男，五十六歲。患偏頭痛四年余，屢治未效。一九五九年春來院就診，經用上法一次即痊癒，迄未復發。此法通過治療三十余例，証明效果已達百分之百。

第十六方 天津市建國道門診部 劉文泉介紹

主治：三叉神經痛。

症狀：頑固性頭痛、齒痛。

取穴：睛明 太陽 下關 合谷

取穴法：坐位或仰臥位。三叉神經第一枝痛取睛明；第二枝痛取太陽，第三枝痛取下關。

手法：用毫針捻轉進針。睛明直刺二寸，太陽斜刺二寸，

下关直刺二寸，合谷五至八分。用搗針法，搗針时令患者行深呼吸八、九次，留針十至二十分钟。每日或隔日針一次。

治驗：蔡××，男，六十五岁，工人。門診病历二三〇八号。主訴：“头痛、牙痛，每日痛数十次，开始在十余年前患牙痛，經总医院赵大夫做封閉二次，痛未止，經牙科医院拔牙两个，又做两次組織埋藏，仍未止痛。”現症：头痛、牙痛、面部痛，陣发性疼，口噤不能食物，不能言語及飲水。經用上穴治疗，針刺后痛減十分之八，又針两次痊愈。观察两月，未复发。

按：头痛为常見的一种重要症候，其原因很多；許多疾病，都可能头痛的症状，因此在诊断时必须判明其原因和症状。程钟龄医学心悟載：“头为諸阳之会，清阳不升，則邪气乘之，致令头痛。然有內伤外感之异，外感风寒者宜散之；热邪传入胃腑，热气上攻者宜清之；直中症，寒气上逼者宜溫之。然除正风寒外，复有偏头风（指偏头痛）、雷头风、客寒犯脑、胃火上冲、痰厥头痛、大头天行、破脑伤风、眉棱骨痛、眼眶痛等症；更有真头痛，朝不保暮，势更危急，皆宜細辨。偏头风者，半边头痛，有风热、有血虛。风热者筋脉抽搐，或鼻塞常流浊涕；血虛者昼輕夜重，痛連眼角。雷风头者，头痛而起核块，或头中雷鳴，多属痰火。客寒犯脑者，脑痛連齿，手足厥冷，口鼻气冷。胃火上冲者，脉洪大，口渴飲冷，头筋扛起。痰厥头痛者，胸膈多痰，动則眩暈。腎厥头痛者，头重足浮，腰膝痠軟，經所謂下虛上实是也。腎气衰則下虛，虛火上泛，故上实也。大头天行者，头肿甚如斗，时疫之症也。破脑伤风者，风从破处而入，其症多发抽搐。眉棱骨痛或眼眶痛，俱属肝經。見光則痛者属血虛。痛不可开者属风热。真头痛者，多属阳衰，头統諸阳，而脑为髓海，不任受邪，若阳气大虛，脑受邪侵，則发为真头痛，手足青至节，势难为矣。”程氏这一段記載已

将头痛原因、症状分析詳細，临症当审其原因、症状而治之。針灸治疗头痛，一般疗效很好。古代医书上关于头痛处方的記載很为丰富，至于經穴的选择問題（針灸处方），主要还在明确原因、症状，然后再参考古今处方的例子，以十四經絡的循行作依据，融会貫通，便能迎刃而解。为便于学习参考，茲将古今有关治疗头痛选用的穴位，簡要介紹于下：

（一）素問骨空論載：“大风頸項痛，刺风府。”“……头痛身重恶寒，治在风府。”繆刺論載：“邪客于足太阳之絡，令人头項肩痛，刺足小指爪甲上与肉交者各一痛立已（至阴）；不已，刺外踝下三痛，左取右，右取左，如食頃已（金門）。 ”

（二）千金要方載：“寒热头痛喘渴，目不可視，神庭、水沟。”“头痛如耐，目痛如脱，头維、大陵。”“头痛如錐刺，不可以动，窈阴、二間。”“风眩头痛，天牖、风府、崑崙、关元、关冲。”“偏头痛，前頂、后頂、額厌。”

（三）甲乙經載：“头痛項先痛，腰脊为应，先取天柱，后取足太阳。”“头痛，目窗及天冲、风池主之。”“厥头痛，面肿起，商丘主之。”

（四）伤寒論載：“太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其經尽故也。若欲再經者，針足阳明（三里），使經不传則愈。”“太阳和少阳并痛，头項强痛，或眩冒，时如結胸，心下痞硬者，当刺大椎第一間、肺俞、肝俞。”

（五）类經图翼載：“伤寒头痛身热，針二間、合谷、神道、风池、期門、間使、足三里。”

（六）百症賦載：“額会連于玉枕，头风疗以金針。”“悬顙、額厌之中，偏头痛止。”“强間、丰隆之际，头痛难禁。”

（七）标幽賦載：“头风头痛，刺申脉与金門。”

（八）席弘賦載：“列缺头痛及偏正，重泻太渊无不应。”

(九) 王龙赋载：“攢竹、头維，治目疾头痛。”

(十) 通玄赋载：“絲竹疗头痛不忍。”“头項痛，拟后谿以安然。”

(十一) 灵光赋载：“偏正头痛泻列缺。”

(十二) 王龙歌载：“若是头风并眼痛，上星穴内刺无偏。”

“偏正头风痛难医，絲竹金針亦可施，沿皮向后透率谷，一針二穴世間稀。”

(十三) 胜玉歌载：“头痛头眩百会好，头风眼痛上星专，头項强急承浆保，头风头痛灸风池。”

(十四) 杂病穴法歌载：“偏正头痛左右針，列缺太渊不用补，头风目眩項掣强，申脉金門手三里。”

(十五) 肘后歌载：“頂心头痛眼不开，涌泉下針足安泰。”

(十六) 医学綱目载：“正头痛，百会、上星、神庭、太阳、合谷。”“痰厥头痛取丰隆。”“眉棱骨痛，取攢竹、合谷、神庭、头維、解谿。”

以上所述古人对于头痛治疗取穴，虽然未全部包括，但一般的足够临床的使用。茲再将近代临床常用治疗头痛的取穴，綜合叙述于下：

(一) 头痛要穴：合谷、列缺、风府、风池、太阳、头維、上星、曲池、百会、神庭、大椎等。

(二) 头頂痛：以百会为主，上星、风池、少海、合谷、列缺。

(三) 前头痛：上星、印堂、太阳、合谷、列缺。

(四) 眉棱骨痛：攢竹、头維、絲竹空、列缺、阳白、合谷。

(五) 偏头痛：列缺、头維、太阳、风池、合谷、阳陵泉。

(六) 外感性头痛：太阳、风池、大椎、外关、合谷、曲池。

(七) 神經衰弱头痛：可配合谷、内关、列缺、足三里。

(八) 急慢性传染病引起的头痛：可配合谷、少商、十宣、足

三里、大椎、行間。

(九) 月經病引起的頭痛：可配三陰交。

(十) 呼吸系統疾患引起的頭痛：可配合谷、曲池、手三里。

以上所选有关治疗头痛的穴位，都是前人和近代实践的总结；同时上述治疗头痛十五方，亦都是經過临床，确具有一定疗效，虽然所采穴位稍有出入，但都能获得相同的疗效。这是根据中医理論的“盛則泻之，虛則补之，热則疾之，寒則留之，陷下則灸之，不盛不虛以經取之”的治疗原則，才能收到預期的效果。同时以上穴位的配合，确实能起到“疏通經絡，宣通气血，补虛泻实，調和阴阳”的作用。

三十二、癲 癇 (共十八方)

第一方 天津中医学院附属医院 王紹中介绍

主治：精神病。

症状：精神失常，譫妄或不語，神志有时模糊不清，多幻觉、恐惧、头痛、失眠，有躁狂行动。

取穴：脊柱两侧 頸椎 头部 手心

手法：用七星針或梅花針彈刺常規。先刺脊柱两侧、腰、骶、尾椎部分重刺，頸椎、头部、手心均纵横刺之。每日刺一次。

治驗：韓×，男，三十六岁，干部。門診病历一〇四五号。一九五九年五月十一日門診。主訴（家人代述）：“一年来經常失眠、头晕，因受刺激，于一个月前精神突然失常，住精神病防治院，一个月出院，仍头晕、头疼、失眠，精神不正常，食欲尚好，大便干燥，小便正常。”既往症：一九五二年患过精神病。检查：脉象細弦，舌苔薄白。血压：高压一百三十；低压七十八毫米汞柱。体温：三十七度，五至八胸椎旁有压痛，发现索状物。診斷为精神病。处理：用刺激神經疗法，彈刺手法。常規脊椎两侧，腰、骶、尾椎重刺，頸椎、头部、手心纵横刺。治疗经过：五次后精神好轉，头晕、头疼、失眠減輕。因回家一次，情緒不好，又犯病。治疗十次，睡眠食欲增加；十五次后，症状大輕；二十次后，精神良好，恢复工作。

第二方 唐山市东矿区赵各庄联合診所 徐继介紹

主治：癲狂。

症状：不識尊卑，打人罵人，乱跑乱走。

取穴：陶道 肺俞(双) 膈俞(双)

手法：用毫針分天、人、地三部捻轉直刺进針。陶道一寸，肺俞一寸五分，膈俞一寸。針刺入天部(皮部)时无手法，达人部(針刺深度的二分之一)时停止下刺，行先泻后补手法(补拇指向前，泻拇指向后)，提插旋捻后再将針进达地部(即針刺的全部深度)时，再捻轉提插，行先补后泻法，再留針。針后十至三十分钟，病人将发生呕吐，迨吐完后起針。

附注：此法适用于癲狂患者倒痰，效果很好。

按：用本方倒痰，所取各穴，古今文献均未載治痰，其所以产生呕吐倒痰的作用，实为刺激部位与手法致其涌吐。陶道为足太阳、督脉之会穴，膈俞又为血之会穴，肺俞为肺脏之要穴，三穴左、右、中均位于膈上；而癲狂之疾，复多有痰郁中、上二焦，郁閉而难通(俗謂痰迷心窍)，下虛上实以致悶乱，病邪从阴則发癲，从阳則发狂。治疗方法或吐或下，不外乎解結、攻逐。此方取穴于上部以逆治之法，針刺取先补之法以升气，則諸阳之气与阴血皆奔于上，然后泻之。逆之不已必致发生呕吐、暈眩，則痰涎去而郁閉通。然此方的适应范围，應該选择气实、体实、新病患者，并有痰郁的症状，动則气逆，寸脉沉滑等。再本方各穴均取直刺进針，深度均在一寸或一寸以上。进針时宜徐緩，以不刺透胸膜为度。

第三方 唐山市东矿区赵各庄診所 徐继介紹

主治：癲癇。

症狀：自言自語，哭笑不定，幻想或幻覺，不眠。

取穴：三陰交(雙) 足三里(雙) 巨闕

取穴法：仰臥位。三陰交在內踝上三寸腓骨後緣一橫指處。足三里在膝眼下四寸五分（即三里下一寸五分處）。男取左，女取右。

手法：用毫針壓指法捻轉進針，刺三陰交二寸，足三里三寸，均用平補平瀉手法，留針時間作輕度捻轉；巨闕直刺五寸，下針後捻轉提插一分鐘（提針上下幅度不超過三分），留針四十分鐘。

按：本方所列症狀，頗與現代醫學的精神分裂症符合。而精神分裂症的症狀則頗為複雜，其特點為精神生活與活動表現不協調，思想、情感與活動之間發生矛盾，起病緩慢，症狀有突發性的精神錯亂，多幻覺，有怪僻舉動而動作重複，傻笑或木僵，言語不聯貫，智力障礙，嚴重者則飲食、衣着、大小便不能自理。本方適用精神病的沉默型，治療上當取養陰、寧心為主，兼用調整腸胃，以促其恢復。并可適當採取百會、神門、心俞、鳩尾、章門、氣海等穴，用中等刺激或輕刺激，每日或隔日一次，作較長時期的治療。

第四方 唐山市中醫門診部 張學增介紹

主治：癲狂。

症狀：（癲症）自言自語，不願見人，不眠，（狂症）妄見妄聞，罵詈，狂歌狂笑，損壞東西，甚則棄衣而走。

取穴：鳩尾

取穴法：仰臥位。鳩尾于蔽骨下五分，无蔽骨則于歧骨下一寸处取之，須护理人员扶助。

手法：用圓利針刺入皮內后直下不捻轉，深度一寸五分至二寸，即捻轉出針；再以大火罐拔之。每五天針一次，按病情輕重定出适当疗程。

禁忌：針后須保持患者精神安靜，忌食魚、肉类食物。

治驗：（一）本市丰潤区左家塢刘××，男，二十九岁。一九五四年六月十七日就診。主訴（其父代述）：“患病已二月，經常哭笑打鬧，不知羞耻、損物、罵人，入夜不眠。前二年曾患此病，經服藥治愈；此次发病，服前藥无效。”診斷：癲狂。經針鳩尾三次后，即能安眠；針五次后，症狀大減，精神已趨安靜。共針八次，痊愈。

（二）本市盛德里甄××，女，三十七岁。一九五六年七月来診。主訴：“經常自言自語，不知飲食，昼夜不眠，不欲見人，并常发生恐怖感觉。”診斷：癲狂。經針鳩尾穴一次后，症狀大減；复診时自称已恢复家庭正常操做。只針一次，痊愈。

第五方 石家庄市立第二医院 李曾树介紹

主治：癲狂。

症状：发作前自觉头晕、心烦，目中生花，发作时如木僵状态，不飲不食亦不語，或胡言乱語，或突然昏倒，口吐白沫，不省人事，醒后又如常。

取穴：百会 风府 风池(双) 大椎 神門(双)
間使(双)

加减法：牙关紧闭加列缺(双)、颊车(双)、合谷(双)。

手法：用毫针沿皮刺百会五至六分，风府、风池、大椎各刺入一寸，大椎针尖向上，风池针尖向对侧眼窝进针，神门刺五至六分，间使刺七至八分。用平补平泻手法，旋捻二至三分钟的予留针。每日针一次，症状减轻后，隔日一次或七日一次，可酌量行之。

治验：(一)本市花市街王×，男，花匠。患癫痫年余。每于痫发前感觉有预兆时来针，连针数次，今已数年未复发。

(二)本市师范学院王××，男，学生。症状：经常晕倒，口吐白沫，不省人事。用上述穴位治愈后，今已四年未复发。

第六方 易县梁各庄人民公社医院 馬宪武介绍

主治：癫痫。

症状：突然昏倒，吐沫，神志不清，四肢抽搐。

取穴：涌泉(双)。

取穴法：平卧位，足跟伸直，于足心陷中后一寸取之。

手法：用毫针捻转进针，向足跟方向刺入三分。捻转刺激，留针一至二小时。

附注：此法适用于癫痫发作期，针三至五次后即不再发作。

第七方 河北省精神病院 王振周介绍

主治：癫痫。

症状：突然昏倒，四肢抽搐、口吐白沫、目上视。

取穴：第一组：十宣 泉中(双) 百会 前顶

第二组：上星 百会 列缺(双) 筋缩

风池(双) 风府

取穴法：泉中穴卧位，两足平伸，于涌泉穴后一寸五分取之。

手法：发作时使用第一组穴位。以三棱针刺十宣出血；泉中穴用毫针捻转向足跟斜刺入三寸，用泻法；百会进针后，沿皮向前顶穴进针，针尖进入前顶穴位后勿使透出，旋捻发生感应后即留针。

未发病时使用第二组穴位。以毫针刺上星三至四分；针尖向上，百会刺入五分，沿皮向下；列缺刺四至五分；针尖斜向肘尖，筋缩刺入三寸；风池刺入一寸五分，针尖斜向对侧眼球；风府直刺进针一寸五分。各穴捻转发生感应后留针十至十五分钟。隔日针一次。七至十日为一疗程，中间休息四至五天。症状减轻后，针刺间隔日数可以适当延长。

第八方 滄县中医学校 顾炳熙介绍

主治：癲癇（羊癲風）。

症状：卒倒、神昏、抽搐，口吐白沫。

取穴：主穴：百会 巨闕 神門(双) 合谷(双)

腰奇 太冲(双)

配穴：上星 风池(双) 太阳(双) 曲池(双)

通里(双) 丰隆(双) 行間(双) 照海(双)

申脉(双) 大椎 涌泉(双) 心俞(双) 肝俞(双)

上脘 内关(双)

配穴法：每次主穴不可缺少，应和配穴輪流交替使用。如巨闕、鳩尾、上脘每次用一穴；神門与通里，行間与太冲，百会与上星都可交替应用。

如身热煩躁可取大椎、內关、涌泉；发作时此三穴可重刺激。痰多者配丰隆，夜間发作配照海，日間发作配申脉，失眠取神門、內关、足三里，并可用艾条灸印堂。

手法：实症多煩躁，可取穴大椎、涌泉，須用泻法；体虚用补法，少取穴，手法要輕，留針時間应短些。一般可用平补平泻手法。腰奇穴可沿皮刺入三寸，捻轉使感应到头頂部。刺巨闕、鳩尾时針尖稍向下，除腰奇穴深刺外，其他穴位使用时，掌握一般深度，留針三十分钟至一小时。每天一次或間日一次，十次为一疗程。

禁忌：治疗过程中，須安靜休养，不可过劳，注意节欲和避免精神受刺激。

治驗：一般患者在第一疗程內症状显著好轉；二至三个疗程可基本痊愈。茲举典型病例介紹如下：

(一) 本县紀家洼村賴××，男，十八岁，农民。于三月十九日就診。主訴：“自十三岁患癇风，发无定时，伴有惊悸、目赤，視物模糊，經針、药治疗未效。”运用上述穴位配合治疗三次，症状減輕；針至十六次中間曾有一次小的发作，眼病亦已恢复；繼續針三十一次，疗程两月已基本痊愈。

(二) 本县商业局卜××，男，三十九岁。三月十一日就診。主訴：“七年前患癇风，发无定时，常有头痛、眩暈、周身麻木等。”运用上述穴位治疗，每日一次，症状減輕；針十五次后因

調理不慎曾小发作一次，症狀輕微；繼續針至二十八次，历时五十天，各症消失，基本痊愈。

第九方 杜宗昌介紹

主治：癲癇。

症狀：突然昏倒，不省人事，手足搐搦，兩目上吊或斜視，角弓反張，怒目直視，牙關緊閉，兩手緊握，面肌歪斜，咬傷唇舌，喉中發畜鳴，口吐涎沫。經五至二十分鐘清醒，醒則飲食起居如常，發作日期不定。

取穴：長強

取穴法：膝腹位。伏身屈膝于腹部，使臀部仰起，在尾骨端與肛門之中間陷凹中取之。

手法：局部嚴密消毒後，左手掇起穴位之皮肉，右手持三棱針重刺長強穴及其前後左右各一針（即長強穴位之上下左右，中為長強，呈十字形），深二至三分，邊以雙手拇食指擠壓刺處，以出血為度（不出血時再刺一下）。每七日針一次，十次為一療程，中間休息觀察一個月；未愈時再進行第二療程，最多以三個療程為限。

附注：术前對患者進行說服解釋，使其合作，並堅定其治愈信心。

治驗：使用長強穴放血法，治療癲癇共計三十一例。僅舉二例介紹如下：

（一）天津市和平區北馬路德源里三號李××，女，二十六

岁，干部。門診病历九一九二号，一九五八年来診。主訴：“自幼即患癲癇，每历二十天发作一次，曾在××医院治疗无效。”检查：脉搏每分钟八十至，脉象弦；呼吸每分钟十八次；血压：八十至一百二十毫米汞柱；营养中等，神志清醒，皮肤无破潰，无出血点，浅表淋巴腺未触及，头部器官无异常，瞳孔两侧均等，对光反射正常，心、肺无异常；腹部平坦柔軟，肝脾未触及，腸鳴音正常，腱反射（一）。神經系检查：无异常发现。印象为特发性癲癇。于一九五八年十月开始治疗，共刺长强穴放血十余次，观察八个月未見发作，痊愈。

（二）天津市河北区进步路十九号张××，女，十一岁，学生。門診病历八七六三号。一九五七年八月三日来診。主訴：“一九五六年因气恼引起抽风一次，現每数日发作一次，发作时突然昏倒，不省人事，清醒后則如常，經×医院脑系科检查，确诊为癲癇，治疗未效。”检查：发育正常，营养中等，两眼微有斜視，心、肺正常。肝脾无触及，腹平軟。經我院儿科治疗，針后谿、大敦、印堂、人中、百会、风府、足三里、风池等穴，前后針治三十八次，历时年余未能生效。通过本科会诊，改刺长强穴放血，两次后，抽风停止。共刺长强穴放血十三次，观察十个月以上，未見复发，痊愈。

第十方 磁县双庙乡毛家坟保健所 张占元介紹

主治：癲狂。

症状：歌哭无常，弃衣狂走，不識亲疏，打人、罵人。

取穴：主穴：鳩尾 巨闕 上脘

配穴：合谷(双) 印堂 上星 橫竹(双)

加减法：体质衰弱者加大杼(双)、风門(双)、陶道、肺俞(双)、十宣。

取穴法：病发时患者不能协作，須护理人员帮助，将患者平放，手足固定后再施术。

手法：用五寸毫针直刺鳩尾、巨闕、上脘各三寸，合谷一寸五分，印堂、上星、攒竹各刺入五分。均用平补平泻手法，留针二至九小时（按病情酌定时间）。視患者精神状况，可酌量隔日针一次或二至三日针一次。体弱者背部穴与腹部穴輪流用。

禁忌：保持精神安靜，避免情緒刺激，忌食鸡、魚。

治驗：用上述穴位經治三十例病人，均已完全治愈。一般针一至二次后，症狀好轉。輕者二至五次即愈；重者須耐心坚持治疗。

第十一方 吳桥县庙鎮乡卫生院 李汝鈞介紹

主治：癲癇。

症狀：突然跌仆，不省人事，痰涎抽搐，斜視，吐沫。

取穴：主穴：腰眼中穴 腰奇 鳩尾 气海 中脘
人中 百会

配穴：上星 神門(双) 間使(双) 丰隆(双)

太冲(双) 心俞(双) 肝俞(双) 足三里(双)

阳陵泉(双) 絕骨(双)

加減法：昼发者可加申脉(双)；夜发者可加照海(双)。

取穴法：俯臥，腹部垫枕头，腰眼中穴位于背部十七椎下，两腰眼正中取之；腰奇穴在尾閭骨尖端直上二寸处；鳩尾穴以两手抱头取之。

手法：腰眼中及腰奇两穴用二十六号长针刺入，进针后沿

皮向上斜刺，进入脊髓腔内，慢慢提插捻转，使感应向上到肩部，向下达足跟后留针；鳩尾穴刺入后针尖向中脘方向；心、肝俞向外斜刺五分；其他配穴深度一般。留针一小时，隔日针一次，十次为一疗程。中间休息一周，再继续治疗。

附注：腰眼中穴避免强刺激。每次选穴不可太多，配穴每次可选五至六个，轮流使用。

治驗：（一）本县庙鎮梁庄孙××，女，十八岁。患羊癇风症，約十二年，时輕时重，甚至每日发作二、三次，面色痿黃，現呆痴状，月經未見。”經用上穴針治二十次，面色轉为紅潤，月經通調，神志清楚，痊愈。

（二）本县庙鎮押庄，张××，男，四十八岁。患癲癇約二十余年，神志失常，一月中連发四、五次，发病时喉中有痰鳴，两目斜視。經二十五次針治，已痊愈。

（三）本县庙鎮苏庄苏××，女，十八岁。患癲癇已十年，发作时，痰涎很多，全身抽搐，反視。患者在检查时面色痿黃、浮腫，腹部胀大，月經不調。經二十二次針治，全部症状消失痊愈。

第十二方 易县城关医院 李占奎介紹

主治：羊癇风。

症状：突然昏倒，神識消失，四肢抽搐，醒后又如常人。

取穴：百会 崑崙 合谷 頰車 地仓

加减法：二目天吊加絲竹空；舌卷不語加人中、臚中、哑門、中冲。

手法：用毫針先刺百会二分，崑崙六分，合谷直針三寸，

透至劳宮穴处，再針地倉、頰車各五分，用泻法。

絲竹空刺向眉心五分，人中向上斜刺三至五分，臚中直刺三分，啞門刺入四分，中冲捻刺二至三分。

用平补平泻手法，留針三十分钟。隔日針一次。

治驗：（一）本县东北奇村刘××，女，二十六岁。症状：神志昏迷，不省人事，二目天吊，牙关紧閉，舌卷，四肢抽搐。經用上
述穴位治疗，一次即痊愈。

（二）本县西关村郝××，女，四十岁。症状：四肢抽搐，神志昏迷，不省人事，牙关紧閉，二目天吊。取穴：百会、崑崙、合谷、頰車、地倉、啞門、絲竹空。用平补平泻手法，共針二次即痊愈。

第十三方 霸县后奕人民公社医院 錢沛介紹

主治：羊癇风。

症状：突然昏倒，四肢抽搐，口吐白沫，意識消失，发作后如常人。

取穴：主穴：身柱 筋縮 腰奇

配穴：百会 风府 心俞(双) 臚中 中腕

下腕 气海 梁門(双) 腎俞(双)

手法：用毫針刺腰奇穴二寸五分（进針后沿皮向上刺），身柱直刺五分，百会二分，风府、心俞、腎俞各三分，用平补平泻手法；筋縮灸五壮。臚中刺二分，上腕七分，中腕、气海各一寸，梁門七分，手法同上，留針三十至六十分钟。隔日針一次，以十次为一疗程。如患者为未滿十周岁的少年儿童，可以照上穴

单用灸法。

禁忌：治愈后忌食死牲畜肉，或其他不洁食物，保持情绪的安定。

治驗：本县庄窠村刘××，男，十九岁，农民。主訴：“于十七岁时曾患羊癇风，时间是三月初旬，在室内突然发作，倒地抽风，不省人事，二十分钟后緩解，自那天以后，每五至十天就发作一次。

将发作以前感觉有心窝堵悶、头晕，发作时间白天或夜間不定。”

检查：脉象平稳，面色及精神活动正常。印象：羊癇风。經用上述穴位治疗，共針灸三十次，在治疗过程中始終未发作。

第十四方 蕪县馬起乏管区保健站 白福增介紹

主治：癲狂。

症状：精神不正常，自言自語，語无伦次，时哭时笑，日夜不眠。

取穴：胆俞 风府 心俞(双) 脾俞(双) 鳩尾

加减法：食欲不振加中脘、足三里(双)；失眠加神門(双)、百会。

手法：用二十八号毫針先刺胆俞，斜向外方刺入八分，风府进針后徐徐捻針直刺三寸，鳩尾刺入后針尖向下，中脘进針后斜向下刺，足三里直刺一寸，各穴留捻三十分钟。出針后胆俞、脾俞、鳩尾各拔火罐。心俞以艾球灸二十壮，脾俞不針，在拔火罐以前，以艾炷灸二十壮。对失眠者，神門、百会各灸二十壮，不針。每三天施术一次，每三次为一疗程。

附注：患者年齡在十九岁以下者，易于治愈。

第十五方 隆化县精神病院 于海洲介绍

主治：癲狂、癰病（脏躁）、癰风。

症状：各随本症。

取穴：第一组：手足十宣 手足十奇 手足十絶
鼻丘 人中

第二组：大椎 陶道 腰奇 地仓(双)

颊车(双) 百会 迎香(双) 和髎(双)

攒竹(双) 印堂 上星 太阳(双)

加减法：癰病不語可加海泉、廉泉、舌根、金津、玉液、哑门。

取穴法：十奇穴在指、趾爪甲根内侧（相当少商、商阳、隐白、厉兑等穴位）。十絶穴在指、趾爪甲根外侧，去爪甲根一分许（相当关冲、少冲、足窍阴、至阴的部位，余仿此）。鼻丘穴在鼻孔内，鼻中隔的下部有毛处。

治疗癰、癲、癰病发作时取第一组穴位；未发作时取第二组穴位。

手法：手足十宣、十奇、十絶、鼻丘、人中等穴用三棱针点刺一至三分深、出血，不留针。癲狂重症者刺稍深，轻者稍浅，微出血即可。鼻丘穴在使用时男左女右只刺一侧，在躁动时可使用较粗毫针，留捻三至十分钟，躁动即可停止。第二组穴位应使用毫针，腰奇穴向上沿皮刺入二至三寸，其他穴位刺法、深

度与針灸书中相同。不語者，刺海泉出血，廉泉穴刺入二寸，向舌根方向进針；再刺哑門穴五分，用搗刺手法，不捻轉；同时教患者說話，不語即可恢复。

治驗：（一）姚××，男，二十六岁。患癲狂症。发病刚暴，打人罵人，忽哭忽笑，踰垣上屋，幻視，不眠，不辨亲疏，大便便秘。經針手足十宣、十奇、十絕，并配用其他治疗精神病穴位，針十二次，完全治愈。

（二）刘××，女，二十二岁。患羊癇风。发作时突然跌倒，昏迷不省人事，眼紅，口吐沫，四肢抽搐。經針十宣、十奇、十絕、攢竹、人中等穴，結果治愈。

（三）吳××，女，二十岁。患癲癇症。发作时卒然仆倒，項背强直，角弓反张，四肢抽掣振动，目反視，舌短縮，发作后日夜不眠达九天。經針刺风府、风池、翳风、十宣、十奇、十絕、人中、印堂、迎香、百会等穴，已完全治愈。

（四）田××，男，五十六岁。患脏躁症。发作时則大声叫喊，乱跑乱走，罵詈不休，二十日不眠，不发作时意識如常。于其发病时針会阴、鼻丘、十奇、十絕、十宣等穴，症状立即緩解，已基本治愈。

第十六方 永年县洛关人民公社医院 游佩丰介紹

主治：癲狂。

症状：神經錯乱，不辨亲疏，打人罵人，弃衣狂走。

取穴：合谷(双) 人中 睛明(双) 百会 阿是(双)

膈俞(双) 长強 足三里(双) 崑崙(双)

上腕 肝俞(双)

取穴法：伏臥。阿是穴于大椎兩旁外開一寸處取之。

手法：用毫針刺合谷三至五分，人中向上斜刺三分，睛明直刺三至五分，百會沿皮向后刺入三分，阿是穴向下斜刺一寸，膈俞、肝俞各向下刺入三分，長強沿皮向上斜刺一寸，足三里直刺五至八分，崑崙刺入八分，上脘直刺一寸。各穴均用旋捻強刺激手法，留針一小時。如針後患者仍不能安靜時，可去針在膈俞、肝俞部位拔大火罐，患者全身汗出後躁動即停止。此法初時隔日針一次，迨症狀減輕後可酌量延長間隔日數，改為三至七天針一次。

輔助治療：每次針後服牛黃清心丸一粒，或服用下方：犀角五分、朱砂五分、琥珀三分。水煎。每劑可服三至四次，日服一次。

治療：共治五百餘例，其中三百多例已完全治愈。

第十七方 天津市和平區興南路保健院 遠紹良介紹

主治：小兒癇。

症狀：小兒陣發性抽搐，呵欠，兩目上翻，日夜均有發作。

取穴：風府 后谿(雙) 大椎 天突 間使(雙)
申脉(雙)

手法：用毫針刺風府四分至一寸，后谿刺入三分，大椎刺入六至七分，天突進針後平刺入一寸，間使針八分，申脉針二分。各穴左右捻轉，用平補平瀉手法。大椎、申脉、后谿三穴手法應用強刺激後出針。每天針一次。

反应：針后可能出現发热反应。

第十八方 天津市河东区大直沽門診部 楊秀峰介紹

主治：癇症。

症状：卒然仆倒，口吐涎沫，不省人事，醒則如常。

取穴：阿是穴(双)

手法：自大椎旁开一寸处，开始向长强穴兩側部分，用手由上向下推压三次，使局部发紅。此时长强穴兩旁部分充血，压手勿放开，右手持三棱針在长强穴兩旁会阳穴处刺出血，不留針。

附注：在发病前出現前趋症时針刺之。此法有預防发作效果，輕症二次即痊愈。

治驗：(一)本市河东馬××，男，十九岁。患癇症，曾經 医治未效。經用上法針治三次，痊愈。

(二)本市河东区大直沽王××，男，三十六岁，工人。患癇风。症状：卒然倒地，口吐白沫，不省人事，发作約三分钟，醒后如常，一日发作两次。經依此法在长强穴兩旁刺出黑血，一次即痊愈。

按：癲、癇症，有阴、阳經脉发病的不同。灵枢經脉篇載：“胃、足阳明之脉，……是动，則病洒洒振寒，善伸，数欠，顏黑；病至則恶人与火，聞木声則惕然而惊，心欲动，独閉戶塞牖而处，甚則欲上高而歌，弃衣而走，贲响腹胀……。”“膀胱、足太阳之脉，……是主筋所生病者，痔、瘡、狂、癲疾……。”素問大奇論載：“二阴（手、足少阴）急为癲厥。”从以上几节經文里可以看出，癲、癇是有着区分的。上面的阳經发病則是罵詈妄行为狂；癇的症候則是：发則昏不知人，卒然眩仆，甚則痙攣、抽搐，或发畜

鳴，吐涎沫。至于病因，中医則认为是痰热所作。因之在治疗上均以豁痰、安神为主。在向愈的机轉上，一般新病，‘正氣未衰者易治；久病，发作頻繁，正氣已虛的恢复則較慢。在針灸治疗取穴方面：內經多取穴于手足太陽、陽明、太陰等六經；迄至近代，在取穴方法上向前发展了，均以取任、督兩脉为綱，以其他經脉为紀；泻其有余，补其不足，以全面調整其机能，恢复其阴平阳秘的健康状态。上列諸方，或先取井、榮、十宣、十奇、十絕等穴以泻其邪，或取于督、任兩脉，前后对刺，以通其痹；或取穴于头部、足心以恢复其知觉，鎮止其发作；或取穴于四肢，以降痰、行气；或配用五藏的輸穴，以泻去五藏的实热；或执一法单行，或数法并用，但要根据患者的具体情况而定。在行針补、泻方面，灵枢根結篇載：“……形气不足，病气有余，是邪胜也，急泻之。形气有余，病气不足，急补之。……形气有余，病气有余，此謂阴阳具有余也，急泻其邪，調其虛实……。”然而宜补、宜泻这两大治疗原則，在不同的病理机轉上，也是要灵活掌握的。例如在上面的癲癇症发作时，以鋒針泻血；而在未发作时的治疗上，則不能繼續用鋒針一泻再泻，应用毫針給予适当的刺激，以透邪、通滯、降逆；在症状被制止已趋向稳定后，并应繼續針治几次，以巩固疗效。

三十三、癔病 (共十三方)

第一方 霸县南孟人民公社医院 魏尹川介绍

主治: 脏躁症。

症状: 精神失常, 哭笑不定, 哭时有时气闭, 出凉汗。

取穴: 风岩(双)

取穴法: 风岩穴在翳风与风池穴相平, 翳风后二寸。

手法: 用毫针直刺风岩穴二寸, 得气后留针。

治验: (一) 南孟人民公社刘××, 女, 二十五岁。忽然大哭气闭, 经针风岩穴后立愈。

(二) 供销社赵××, 男, 二十四岁。发生哭笑无常、打人, 经针风岩穴立愈。

按: 风岩穴, 为目前新发现的经外奇穴。从此穴部位的经脉循行上来讲, 风岩穴的前后均为足少阳胆经经脉所过, 对于此穴的疗用, 目前尚无文献报道。从部位解剖来看, 此穴正位于枕骨下际, 针法刺入二寸留针, 对脑神经刺激影响是比较重的, 更由于留针而产生镇静作用。至于机制问题, 还有待将来再做进一步研究; 同时也希望读者在临床上, 进行总结经验及机制方面的探讨。

第二方 霸县城关乡医院 郭福泉介绍

主治: 歇斯底里病。

症状: 哭笑无常。

取穴: 天灵 鳩尾 人中 风岩

取穴法：天灵穴在腋上紋头上一寸里开五分是穴；风岩穴在頸鎖骨乳突肌后风池前一寸。

手法：用长毫針旋捻进針。天灵穴刺过梁針法，針尖达对側皮下；鳩尾針七寸，針尖向下刺，呈十五度，使針尖达中腕穴下；人中斜向上刺入三分；风岩穴直刺二寸，旋捻得气后留針三十至六十分钟。針后患者即安靜入眠。

按：过梁針法，为針术中一种独特手法。即从一端的穴位刺入，針向另一端穴位部分。天灵穴一針横扭手厥阴、手少阴、手、足少阳經脉的循行部位；鳩尾一針豎貫四个穴位，以及后面处方里的条山穴等，都属于这种刺法。这种針法，既能減輕患者多針刺的痛苦，又提高了治疗效果，但必須掌握好适应症。对于神經麻痹，或痹症等，前人也有这样的刺法，例如刺顏面神經麻痹，由地仓透向頰車，以及风府透向风池等，都是很好的例子。其目的在于通过較重的刺激，以喚起局部組織功能的恢复，或远隔部位痛痹的緩解。針响和抑止作用都非常强烈，所以能收到鎮靜或恢复作用。但天灵穴刺时应注意避开胸膜和胸外側的动、靜脉，刺时手法应徐徐捻进。

第三方 天津中医学院附属医院 王紹中介绍

主治：癱病。

症状：精神受刺激后突发神經錯乱，哭笑无常，或昏迷抽搐。

取穴：脊柱兩側 腰、骶、尾椎兩側 頸椎

手法：用七星針彈刺脊柱兩側常規刺激，腰、骶、尾椎兩側縱橫重刺激，頸椎部縱橫重刺激。用彈刺沖力直

刺、勿使出血。每日針一次。

治驗：（一）天津医科大学刘××，女，十九岁，学生。門診病历八八九四号。主訴：“头晕昏迷，摔倒抽搐，五个月来已发数次，不能用脑力，睡眠惊悸不安，胃痛，食欲不振，二便正常。月經初潮十三岁，周期二十五天至三十五天；行經期每二至三天；行經腹痛，白帶多。在×医院脑系科診斷为神經官能症。”既往史：曾患盲腸炎动过手术。家族史：父母健在，五个弟弟均健康。检查：体温三十七度，脉象細弦，舌苔白，五至八胸椎旁有索条状物压痛，骶椎旁痠。診斷为癔病。处理：用針灸刺激神經疗法，刺常規脊椎兩側，重刺腰、骶、尾椎，胸五至八椎；頸椎、头部、下腹部，彈刺手法。治疗經過：第一次治疗后，即始終未暈倒；三次睡眠良好；六次头暈大輕；八次后諸症消失，痊愈。

（二）吳××，女，四十四岁，干部。一九五八年八月十八日門診，病历七五九七号。主訴：“六年来，头痛头暈，心悸失眠，惊惧，并有时抽搐，昏迷，不省人事，每次发作二至四小时，約十多天至一月发作一次。曾在×医院脑系科治疗无效，最近十天又发作一次，心煩食欲不好，便溏腹痛，两腿浮肿，月經不調。”既往：身体无任何疾病。检查：脉象沉細。体温：三十六度七，胸五至十二椎旁有索条状物，頸椎和骶椎旁有压痛。診斷为癔病。处理：用刺激神經疗法，彈刺常規，腰、骶、頸部重刺，上下腹及两下肢。治疗經過：二次后昏迷未发作；十次症状大輕；治疗两个疗程症状消失。因病久体弱，奏效較慢，并針刺內关一寸，神門三分，照海五分，太冲三分。用强刺泻法，留針二十分钟。只針刺一次，癔病未犯，后陸續痊愈。

第四方 石家庄市立第二医院 李曾树介紹

主治：脏躁症（癔病）。

症状：神智不清，哭笑无常，或突然发作，四肢抽搐、昏迷。

取穴：第一组：合谷(双) 风府 神門(双) 間使(双)

第二组：曲池(双) 内关(双) 足三里(双)

阳陵泉(双) 三阴交(双) 中脘 天枢(双) 气海

取穴法：仰臥、俯臥。发作时使用第一组穴位，平时使用第二组穴位，或两组穴位同时并用。

手法：发作时用毫针直刺合谷七分至一寸，风府直刺一寸，神門刺入五分，間使刺六至七分。每穴捻轉提插三至五分钟，出针。第二组穴位曲池以毫针直刺八分至一寸五分；内关直刺五分，足三里直刺五分至一寸，阳陵泉直刺八分至一寸五分，三阴交刺五分至八分，中脘直刺一至二寸，天枢刺五分至一寸，气海八分至一寸。各穴均用平补平泻手法，留捻五分钟。每隔二至三天针一次。

第五方 宁晋县寨子乡凤翔保健所 王炳瑞介绍

主治：脏躁症。

症状：哭笑无常，胡言乱語，或突然昏迷、抽搐，不省人事，发作頻頻。

取穴：百会 人中 承浆 劳宮(双) 少商(双) 印堂
气海 中脘 隐白(双) 合谷(双) 风府 上星
足三里(双)

加减法：重症可加会阴。

手法：用毫針捻轉快速進針。百會向前沿皮刺入三分，承漿向上斜刺三分，人中直刺三分，勞宮三至五分，少商一分，印堂一分，氣海八分至一寸，中脘一至二寸，隱白一至二分，合谷三至七分，風門三至五分，足三里五分至一寸，上星向後沿皮刺入三至四分。如取會陰時，可直刺三寸。人中及承漿進針後重刺激，其他穴輕刺激。氣海針用補法，各穴留針三十分鐘，隔日針一次，一般六至七次即痊癒。

治驗：經用上法治療六十餘例，均已痊癒。僅舉一例介紹如下：

本縣鳳翔村張××，女，二十六歲。於一九五七年就診。主訴：“於一九五五年發病，屢經治療未效。”症狀：胡言亂語，有時昏迷，不省人事，一日一發或一日數發。經針治三次亦無效，後又值其發作，經採用上述穴位先刺頭部及四肢穴位，繼針會陰穴，深達三寸，再用二寸五分長針針氣海穴，快速下針，二十分鐘後患者清醒，出針。症狀消失而癒，觀察二年，未復發。

第六方 阜平縣砂窩鄉百么台衛生所 張惠生介紹

主治：躁症。

症狀：哭笑無常，或歌或舞，煩躁不安。

取穴：間使(雙) 上巨虛(雙) 中脘 神門(雙) 人中

手法：用圓利針直刺間使一寸二分，上巨虛二寸，中脘三寸，神門二分，人中一至三分。手法用強刺激，留針二至四小時。

附注：周圍環境要清靜，使患者針後安靜入眠，勿驚動，令其自醒。

治驗：用上述穴位曾治脏躁症五例，均針一至二次痊愈。茲举典型一例介紹如下：

本县砂窝乡徐××，女，十八岁。一九五八年九月，在田間劳动，初感心悸，继則昏迷在地，醒后即哭笑歌唱，不能禁止。經針刺間使、上巨虛、中脘、神門、人中。下針后安靜入睡，留針三小时；醒后自訴全身疲倦，无其他感觉。只針一次，痊愈。

第七方 兴隆县医院 陈广文介紹

主治：癔病（歇斯底里）。

症状：心悸，四肢抽搐，或冷厥，窒息，不語或独語。

取穴：内关（双） 人中 百会

手法：用毫針刺两内关五分深，捻动一分钟，人中直刺二至三分，百会沿皮刺入五分。各輕度捻轉一分钟，留針二十分钟。

治驗：本方共治愈癔病患者三十余例。茲举两例介紹如下：

（一）孙××，女，二十岁，农民。自訴：“于一九五八年二月来县开会，晚間自覺身体不适，后即发现四肢抽搐，昏迷不語，四肢厥冷，脉微弱，曾用針刺及服药未效。”經刺两内关穴，立即苏醒，抽搐停止，語言恢复，脉搏亦逐見恢复。留針時間，頻作輕度捻轉，留針二十分钟，痊愈。

（二）徐××，女，年四十一岁，农民。患歇斯底里，昏迷不語。經針刺人中、百会、内关而痊愈。

第八方 永年县洛关人民公社医院 游佩丰介紹

主治：脏躁症。

症状：不食不眠，意識不清，大小便不能自理。

取穴：主穴：胆俞(双)

配穴：阿是(双) 足三里(双) 崑崙(双)

加减法：如病人躁动不安加入中、睛明(双)、心俞(双)、中脘。

取穴法：针胆俞穴时，俯卧屈肘挟胸，针其他穴时再转换体位。阿是穴在第七颈椎旁开一寸处。

手法：右手持毫针，令患者咳嗽一声，随即进针，快速刺入，先刺上部穴，后刺下部穴。如躁动不安则先刺人中二至三分，睛明三至四分，心俞向下刺入一寸，中脘刺入一寸至二寸；再刺主穴胆俞一寸（针尖向下），阿是穴向下刺入一寸。捻转后将针拔去，随即以火罐拔胆俞及阿是穴，拔三十分鐘。火罐拔上以后，将其余针全部起出。每隔二、三日针一次。

禁忌：忌饮酒及刺激性食物。

第九方 定县产德人民公社北水峪村 王作楫介绍

主治：脏躁症。

症状：发作突然，有时清醒，有时人事不知，四肢不抽搐，但两目直视。

取穴：左侧京門

取穴法：侧卧，伸下足屈上足，于十二肋骨端取之。

手法：用毫针直刺五分至一寸，用泻法（男则大指向前，女则大指向后），留针三十至六十分钟。每日针一次。

第十方 怀安县万全医院 楊宁武介紹

主治：精神性癱病。

症狀：情緒变幻无定，多語，哭鬧不休。

取穴：奇穴(双) 膝关节穴

取穴法：坐位屈膝。奇穴在腋前綫(即腋橫紋)上方一寸处；膝关节穴在股內側膝橫紋头之后方一寸处，屈膝取之。

手法：刺奇穴用过梁針(长毫針)向外与皮肤面呈七十五度斜角，捻轉刺入达腋后皮下；膝关节穴亦用长針从內側刺入，針尖向外側面，勿刺透对側皮肤。行針手法向一側捻轉，强刺激，达鎮靜后出針。每日針一次或隔日一次。

第十一方 天津市汉沽区医院 邵鐸年介紹

主治：癱病失語。

症狀：意識朦朧，失語。

取穴：主穴：中冲(双) 間使(双)

配穴：人中 肝俞(双) 心俞(双) 足三里(双)

中腕

手法：用三棱針点刺中冲出血，以毫針刺間使五分，捻轉提插，强刺激以患者清醒为度。人中刺二至三分，肝俞刺入五分，心俞刺入三分，中腕刺入一寸。除主穴外均使用中度刺激，留針二十至三十分钟。

附注：此方效果很好，經治几例，均痊愈。

第十二方 河間中医学院 王洪印介紹

主治：癰病性鼓腸。

症状：每日午后腹脹。

取穴：足三里(双) 中脘 曲池(双)

手法：用毫針刺中脘三寸，用平补平泻手法；足三里穴直刺入三寸，用透天凉手法（針刺到三寸后，上提一分倒捻六下，留一分钟，再将針提出二分之一，再倒捻六下，再提至皮下倒捻六下，如此反复行之三次）；曲池刺入一寸五分，用平补平泻手法。各留針一小时。

禁忌：針后忌辛辣食物三天。

治驗：保定市张××，女，二十六岁。主訴：“患癰病已二年，每天下午鼓腸，似六、七个月怀孕状，发作約一小时后漸消。”根据检查，一般属热，經針刺足三里、中脘，一次見輕，共針三次，痊愈。观察半年未复发。

第十三方 河北省精神病院 王振周介紹

主治：癰病性鼓腸。

症状：腹部膨脹。

取穴：阴委(双) 气海

取穴法：仰臥屈膝于曲泉穴上一寸处取之。

手法：針阴委一穴时，令病人张口吸气，隨以毫針直刺，針尖达对側皮下，拇指向后捻轉用重刺激手法；气

海穴捻轉刺入一寸五分，留針十分鐘。

治驗：石家庄市焦××。一九四六年以前，被敵機炸傷，縫過腹部及截肢。一九五六年因癔病在精神病院住院期間，突然鼓腸，肚皮脹得發亮。經與河北省醫院會診，在觀察中症狀復發，乃針陰委配氣海，自針後鼓腸症狀即消失，痊癒。觀察三年，未見復發。

按：脏躁症，今稱癔病，是大腦皮質官能性疾病。因此在治療上，適于精神安慰，解除其精神上的創傷，運用精神療法，非常重要。本病症狀複雜，所以針灸治療，必須隨症施治，根據患者身體情況及症狀的不同，採取適當的穴位和手法。不過本病多屬實症，因此在治療時一般是用強烈而較重的刺激手法，即“實則瀉之”。這樣就能通過神經傳導抑制病灶的興奮，而達到鎮靜大腦皮質的目的，從而使神經機能失調現象消失達到治癒。治療中并宜注意強壯穴位的使用，則恢復較快，療效可以巩固。

三十四、牙 痛 (共七方)

第一方 天津中医学院附属医院 刘天成介绍

主治：牙痛。

症状：上、下牙痛。

取穴：主穴：合谷

配穴：下关 颊车

手法：用毫针捻转进针，合谷刺入一寸。用强刺激的飞经走气手法（将针尖斜向上刺，强烈捻转，使感应传导至头部，再将针提起至皮下，针尖再向下刺，使感应传至指端，如此反复三次），留针三十分钟。每天针一次，一般一次即痊愈。

第二方 承德市矿山机械厂 吴家义介绍

主治：牙痛。

症状：风、火牙痛，不能饮食咀嚼。

取穴：主穴：合谷 下关 颊车

配穴：中腕 足三里

手法：用毫针刺健侧合谷穴八分。如上牙痛取患侧下关刺入八分至一寸；下牙痛再刺患侧颊车穴八分。以上具用泻法。中腕、足三里各刺一寸五分（中腕针尖向下斜刺），均用补法，留针三十分钟。每日针一

次。

禁忌：痛止后，宜慎用过凉、过热食物。

治驗：用此法治疗牙痛，共治愈毕荣庭等十一名，均一次痛止，不再复发。

按：天津中医学院附属医院王紹中大夫治疗齿痛取穴手法，均与本方主穴相同，王大夫介绍治疗效果，均一至二次治愈。本方配用中脘、足三里二穴，取标本同治，故取效甚捷。

第三方 天津市南开区东姓里卫生院 王殿槐介绍

主治：牙痛。

症状：上、下牙痛，齿龈肿。

取穴：合谷 内庭 太谿

手法：用毫针取健侧合谷穴，针尖向掌心捻进，要透至劳宫穴处，手法用强刺激。下牙痛则配内庭，刺入五分，用补法；虚性牙齿隐痛，则配太谿，刺入六分，用补法。留针三十分钟。

第四方 正定县团泊人民公社医院 李玉田介绍

主治：牙痛。

症状：齲齿痛或齿龈肿痛。

取穴：主穴：颊车 合谷 列缺

配穴：人中 承浆

手法：用毫针刺颊车八分至一寸，合谷五至八分，列缺六分。门齿痛则取人中，针尖向上刺入三分，承浆直刺三分，用平补平泻手法，使感应达于患部，痛止

即出針。齒齦腫脹，可以三棱針刺局部，使出血。
每日針一次。

第五方 易县城关鎮医院 李占奎介紹

主治：腎虛牙痛。

症狀：長期牙痛不止，脈虛弱。

取穴：商陽 二間 腎俞

取穴法：左痛取右側穴；右痛取左側穴。

手法：用毫針斜刺健側商陽二分，針尖向上沿皮刺，二間直刺三分，均用平補平瀉手法。腎俞直刺六分，將針捻轉，發生感應後，將針提至皮下再向外斜刺一寸，用搗針法。留針一小時。

第六方 唐山市胥各庄人民公社医院 趙宪如介紹

主治：牙痛。

症狀：齒痛、局部發涼，感涼後痛劇，患側顏面發麻，脈沉細。

取穴：主穴：二間

配穴：合谷 下關

手法：用毫針直刺二間二至三分，合谷六至八分，下關五分。用補法，捻轉針柄慢提緊插，反復行之至局部發熱，留針三十分鐘。一至三次即痊癒。

第七方 滄縣中醫學校 顧炳熙介紹

主治：牙關緊閉，因牙疼所致。

症状：齿痛，口噤不开。

取穴：主穴：翳风 列缺

配穴：颊车 下关

取穴法：取患侧穴位。

手法：用毫针刺翳风一寸五分，列缺针尖向上斜刺三至五分，颊车三至八分，下关三至五分。各穴手法均用强刺激，捻转捣动，留针三十分钟。

治验：侯××，女，三十四岁。患牙痛筋急，牙关紧闭，口不能开，饮食困难。按上法针治二次痊愈。

按：一切齿痛，均应先针合谷，因合谷穴为制止牙疼的特效穴位。盖合谷为手阳明大肠经之原穴，灵枢经脉篇载：“……是动，则病齿痛。”实痛可直泻本经之邪。其余配穴可随症加减。如上牙痛：配颊车、下关、人中；下牙痛：配颊车、大迎、承浆、足三里；风热牙疼：配尺泽、内关、足三里、内庭；虚火牙痛：配曲泽、内关、神门、曲泉、三阴交。如为龋齿痛，痛止后须考虑拔除，或行固齿法：于排尿时，将牙齿叩紧，排尿后再松开。初步可下意识练习，迨至形成条件反射后，即可自动地转为经常。此法对龋齿或残余的齿根拔除困难者亦有良效。

三十五、胃 痛 (共五方)

第一方 永年县南沿村医院 宋子笏介绍

主治：九种心痛。

症状：气、血、寒、食、虫、痰、火、湿、注痛，阵发性心、腹部疼痛。

取穴：中脘 内关(双) 公孙(双)

手法：用毫针直刺中脘、内关、公孙各一寸。捻转提插泻法(紧提慢按)，留捻三十分钟。隔日针一次，五次为一疗程。

治验：此方治疗九种心胃疼九百余例，一般针治三至五次即痊愈，不超过一个疗程。

第二方 邢台县羊饭村 宋三同介绍

主治：胃口痛。

症状：长年不愈的心口痛，不发生恶心、呕吐、腹泻者。

取穴：鸠尾

取穴法：仰臥。于剑突下一寸处取之。

手法：用毫针直刺鸠尾穴，进针三分后，令患者咳嗽，乘吸气时捻针直入一寸五分至二寸。得气后用平补平泻手法(用手法时令患者吸气)，留针一小时。针一、二次即痊愈。

第三方 易县城关乡医院 李占奎介绍

主治：胃内停饮。

症状：头、目眩晕，两目难睁，动摇即吐，脉弦细无力。

取穴：巨阙 中脘 厉兑(双) 百会 足三里(双)

手法：用毫针直刺巨阙五分，中脘一寸五分，厉兑二分，足三里向下斜刺五分，百会向后沿皮刺二分。用平补平泻手法至发生感应为度，留针一小时。隔日针一次，二次即痊愈。

第四方 黄驊县旧城人民公社卫生院 张辅卿介绍

主治：胃痛。

症状：胃痛剧烈，四肢厥冷。

取穴：中脘 内关(双) 梁丘(双)

手法：用毫针直刺中脘二寸，内关五分，梁丘五至六分。用平补平泻手法，以得气后捻捣至手足转温为度，留针一小时。

第五方 藺县医院三河分院 孙宝廷介绍

主治：胃神经官能症（贲门痉挛）。

症状：上腹部刺痛，按之疼痛减轻，局部不发热，发作时间长短不定。

取穴：中脘(双) 足三里(双)

手法：用毫针直刺中脘五分，足三里一寸二分。用强刺激手法，留捻十五分钟，以痛止为度；然后出针。每

日針一次。

按：以上五方，均属于肝气痛的范围，即现代医学所谓胃神经官能症。其病因祖国医学认为是由于喜、怒、忧、郁引起的肝气横逆所致的胃、胁部疼痛，所以治疗均以舒肝、调气为主。针灸疗法，或循经取穴以调气；或局部取穴以缓解疼痛。应用手法，一般治痛均用重刺激，局部可行置针术，或兼用温针法。并可常灸肝俞、胃俞、中脘、三里等穴，每穴灸三至五壮（艾条可灸五分钟）。但治疗之前应进行确诊，如果是胃部或背部（第七胸椎至第三腰椎脊柱两侧）有压痛点，心窝部常有烧灼感觉等症状的，则不属于神经痛的范围，应考虑胃及十二指肠溃疡症进行治疗。

三十六、腹 痛 (共七方)

第一方 汉沽盐场储运场保健站 韓志英介紹

主治：肚子疼。

症状：滿腹部疼痛。

取穴：内关(双) 公孙(双)

手法：直刺捻轉进針三至五分深，得气后用平补平泻手法，留針五分钟。

治驗：宁河农場張××，男，二十四岁。于一九五六年七月間来院就診。检查为胃神經疼。針上穴用平补平泻手法，一至三秒钟痛即止，留針三十分钟，出針后即痊愈。

按：本方取穴，系灵龟八法的配穴法。公孙二穴通于冲脉，内关二穴通于阴維脉，这两支奇經經脉交会于心、胸、胃部，所以主治心腹諸疾。历代針灸医家，对以上两穴配用的疗效，頗多贊許。

第二方 邯鄲市第二医院 游貞祥介紹

主治：腹痛。

症状：肚臍周围疼痛。

取穴：下脘 阴交 天枢(双) 足三里(双)

手法：用毫針捻轉直刺下脘、阴交、天枢、足三里各一至一寸五分。用平补平泻手法，留針十至二十分钟。

急性者，每日針一次；慢性者，隔日針一次。一般

針一次可痊愈。

第三方 河間县九吉医院 王俊峰介紹

主治：腹痛。

症状：突然腹痛（中脘部），不能平臥。

取穴：主穴：中脘

配穴：天樞 足三里 合谷

手法：用毫針捻轉直刺中脘八分至一寸，天樞五至八分，足三里八分至一寸，合谷五分。用平補平瀉手法，留針一小時。

第四方 灤平县巴克什营人民公社医院 李占林介紹

主治：腹痛便秘。

症状：腹痛，三、四日不大便。

取穴：关元 天樞(双) 中脘 长強 崑崙

手法：用毫針捻轉進針直刺关元三寸，天樞二寸，中脘三寸五分，崑崙四分，长強五分向上刺。均用瀉法（捻轉緩慢出針），留針三十分钟。

第五方 正定县城关人民公社医院 朱从吾介紹

主治：奔豚气病。

症状：气从少腹向上攻，心腹脹痛，甚至发作昏迷。

取穴：关元 大敦(双)

手法：用毫針捻轉進針直刺关元一寸，大敦二至三分。均

用平补平泻手法，留针二十至三十分钟。针后用艾条灸之。

治驗：用上述穴位曾治疗十例，一般针三次即痊愈；最多的针五次而痊愈。

第六方 蕪县馬起乏管区保健站 白福增介紹

主治：中寒腹痛。

症状：腹中寒痛，四肢发凉，縮成一团，面唇发紫。

取穴：神闕 足三里(双)

手法：用三十号毫针直刺神闕一寸，足三里一寸。慢进针，慢提针，十分钟捻轉一次，留针三十分钟。针后均灸二十壮。

禁忌：针后忌生冷，并謹避风寒。

按：滄县崔尔庄卫生院王紹丹大夫治疗中寒腹痛(絞腸痧)，取穴与此方相同。惟神闕穴不针，单用隔姜灸法。于神闕穴中放少許麻油、胡椒末，姜片置其上，以大艾炷灸至腹中覺热为度。足三里穴用烧山火手法，使针下覺热，留针三十至六十分钟。据王大夫介紹，此法治疗七例患者，均获痊愈。

第七方 高阳县刘明庄人民公社医院 秦占奎介紹

主治：腹痛。

症状：腹痛，心煩，全身起紅斑，发痒。

取穴：金津 玉液 中脘 足三里(双) 内关(双)

气海 合谷(双)

手法：先用三棱针刺金津、玉液出血，再用毫针直刺中脘

二寸，足三里二寸，内关一寸，气海一寸，合谷一寸。均用平补平泻手法，留针二十分钟。

治驗：（一）本县刘名庄村张××，女，三十六岁。主訴：“患腹痛心煩，身上起紅点，发痒。”經他医治疗无效，用上述穴位治疗，一次即痊愈。

（二）本县刘名庄村韦××，女，五十三岁。曾患腹痛，心中覚煩，而身上有紅斑点作痒。經用此法針二次即痊愈。

按：腹痛这个症候，包括了多种疾病在內，每一疾病都有其一定的誘发因素。药物疗法应辨明病症，不能混同施治。惟針灸疗法，則不与用药相同，或按循經取穴以通其滯閉，或以痛为輸，刺其局部以鎮痛。如选穴与手法用之得当，每获致滿意效果。但取穴治疗的同时，亦必須照顾到原因，才能达到根治。如食积、便閉腹痛，可采用章門、太白、照海；虛症用补法；热結用先补后泻法；寒結用先泻后补法，則便閉可通。內經，刺灸腹痛之法有：（一）灵枢五邪篇：“……邪在脾胃，……阳气不足，阴气有余，則寒中、腸鳴、腹痛，阴阳俱有余，若俱不足，則有寒有热，皆調于三里。”經脉篇載：“足太阴之別，名曰公孙，……实則腸中切痛，……取之所別也。”（二）邪气脏腑病形篇載：“大腸病者，腸中切痛，而鳴濯濯，感于寒即泄，当臍而痛，……取巨虛上廉。”（三）灵枢經脉篇載：“任脉之別，名曰尾翳（鳩尾），下鳩尾，散于腹；实則腹皮痛，虛則痒搔，取之所別也。”其他古人經驗穴位尚多，不再一一列举。至于第三方主治的腹痛，似屬痧症，故取金津、玉液刺泻毒血；亦可采用民間疗法，将患者肛門內的紫色疙瘩以鋒針刺破出血，則痧毒去，腹痛亦止。

三十七、腰 痛 (共八方)

第一方 河北省中医研究院門診部 景象介紹

主治：腰痛。

症状：腰痛，俯仰不便。

取穴：主穴：腎俞(双) 大腸俞(双)

配穴：承山(双) 崑崙(双)

手法：用毫針取腎俞穴刺向两脊柱方向二寸，承山一寸五分，崑崙一寸（針尖刺向內踝），大腸俞五分。用平补平泻手法，留針三十分钟。隔日針一次。

第二方 唐山市东矿区古林联合診所 李玉良介紹

主治：腰痛。

症状：腰痛，不得俯仰，臥起不便，属于急性风湿痛者。

取穴：条山

取穴法：仰臥。条山穴于犢鼻、解谿之間，离脛骨邊緣一横指处取之。

手法：用毫針直刺条山穴，針尖向承山穴捻进，达承山穴位之皮下。用捻轉提插手法，使感应达于腰部（但手法不宜过重），留針五至十分钟。

第三方 河北省中医研究院門診部 景象介紹

主治: 坐骨神經痛。

症状: 一側下肢由髖关节向下疼痛。

取穴: 主穴: 秩边

配穴: 阳陵泉 崑崙

手法: 用毫針捻刺秩边三至四寸, 发生感应后行补法(右拇指向前进), 使感应放散到足尖。阳陵泉直刺一寸, 崑崙向內踝斜刺五分, 用平补平泻手法, 留針三十分钟。

第四方 易县城关乡医院 李占奎介紹

主治: 腰痛。

症状: 风热性腰痛, 脉象沉数。

取穴: 风門(双) 肺俞(双)

手法: 用毫針直刺风門、肺俞, 进針一分后向外斜刺各一寸。用平补平泻手法, 留捻三十至六十分钟。一次可痊愈。

第五方 河北中医学院 刘殿元介紹

主治: 腰痛。

症状: 腰部疼痛, 不能俯仰、行动。

取穴: 主穴: 志室(双) 腎俞(双)

配穴: 命門 委中(双)

手法：用毫針直刺志室五分至一寸五分，行六、九捻轉法，針尾加灸；委中八分至一寸五分，命門五至八分，均用平補平瀉手法，針后加灸；腎俞二寸（腎俞、志室交替使用），用呼吸補瀉法（呼氣進針，吸氣出針，隨呼吸捻轉），留針三十分鐘。隔日針灸一次。

治驗：（一）阜平县刘××，男，三十九岁，农民。初診：一九五九年三月四日。主訴：“腰部隱隱疼痛，走路牽引兩腿亦痛，妨碍食欲，二便尚正常。”检查：脉緩，两尺沉弱。触診：两肾脏部有压痛。印象为腎虛腰痛。經取穴腎俞用補，委中用平補平瀉手法；第二次加命門，針后灸之。至三月十九日症狀完全消失，痊愈。

（二）阜平县王××，女，四十六岁，农民。初診：一九五九年三月七日。主訴：“腰痛剧烈，俯臥困难，走路远时痛剧。”检查：脉浮緩。印象为風寒痹腰痛。治疗取穴志室、用九、六捻轉法，針尾加灸；委中用平補平瀉手法。二次減輕，第三次加命門，共針灸五次痊愈。

按：九、六捻轉法，亦名阳中隱阴，又名烧山火。其作用是先寒后热，其方法是捻針刺入五分，得气后左捻九下，針下覺稍热再捻針刺入一寸，再右捻六下，得气留針以止痛。本方治疗驗例，診斷为風寒痹痛，使用烧山火手法，以祛除寒痹。烧山火为楊氏八法之一；治頑麻、冷痹，其法是三进三退，慢提紧按，得气留針。

第六方 石家庄市立第二医院 高輔汉介紹

主治：腰痛。

症狀：偶然閃、銕、岔气，腰痛不能动轉。

取穴：人中 委中(双) 气海 环跳(双)

取穴法：坐位。新病者取人中；久痛者针后三穴。

手法：用毫针刺人中穴二分，随进针时令患者行深呼吸，委中、气海各直刺一寸，环跳刺入二寸五分，用平补平泻手法。委中使感应到足部，不留针。新痛者一次即痊愈，再针可隔日一次。

治验：本市市委会王××，男，四十岁。自诉：“于一九五八年麦秋时，晨起劳动，突然岔气，引起腰痛，不能动转，影响呼吸。”经针刺人中、委中、环跳，行泻法，使酸、麻感应上通下达，针下即觉轻松，起针后即能下床活动。后又针一次，迄未复发。

第七方 天津市立第一医院 楊景輝介紹

主治：风湿性关节痛。

症状：腰、腿疼痛，时轻时重，感寒则痛剧，活动障碍。

取穴：主穴：委中 肾俞

配穴：关元俞 次髎

取穴法：俯卧。腰痛重先取肾俞，配委中、次髎；腿痛重先取委中，配肾俞、次髎、关元俞。

手法：用毫针直刺委中一寸五分至二寸，行呼吸补泻法，五至十分钟后，腰痛停止，再针肾俞一寸至二寸，关元俞、次髎各针五分（这两穴配合主穴可以轮用），亦行呼吸补泻法。留针时间内即用大火罐拔于针刺的穴位上，留针时间二十至三十分钟。取下大火罐，出针。每日治疗一次，三次后，再隔日一次。

治驗：此种罐針疗法，适应于寒性风湿症，神經、肌肉麻痹及神經痛等，疗效确实令人滿意。凡热性风湿症或局部紅肿及孕妇等禁用此法。茲举典型病例介紹如下：

(一) 本市第一食品加工厂冷藏庫刘××，男，三十六岁，工人。主訴：“三年来經常腰腿痛，自一九五六年三月，突然加重，髖、膝疼痛，脊柱强直，屈曲則痛剧，影响工作。”經检查肢体各部无紅肿和畸形。印象为风湿关节痛。經針刺十一次后腰痛基本好轉，至十六次后因不慎感寒，疼痛又加剧，第十七次复診治疗时；即于針上拔以火罐，經過十五次治疗，腰疼痊愈；再以針刺治疗髖、膝痛，数次即痊愈。

(二) 本市第一食品加工厂刘××，女，二十八岁，工人。主訴：“自十三岁患腰疼、腿疼，时輕时重，逢天寒或阴雨則加剧。十几年来經中、西药屢次治疗未愈。于一九五六年因产育复引起剧烈疼痛，腰部弯曲困难，影响走路。”經透視检查，确诊为类风湿性脊柱炎。經罐針治疗两次后即显著好轉。共治疗三十余次痊愈，恢复工作。

(三) 肃宁合作社周××，男，五十岁。主訴：“来天津办事，偶感风寒，腰痛剧烈，屈曲困难，两腿走路不灵活。”检查印象为风湿性腰疼。經刺腎俞，复以火罐治疗；次日复診时，腰痛已基本消失，腰膝运动已趋灵活，第三次加刺委中，共治疗二次即痊愈。

第八方 元氏县高邑人民公社医院 陈仲玉介紹

主治：腰痛。

症状：风、寒腰痛，屈曲不利。

取穴：阿是 委中

取穴法：俯臥。腰骶部兩側按压最痛处，即阿是穴刺点。

手法：用毫針刺阿是穴五分，委中直刺一至一寸五分。用强刺激手法，留捻二十至三十分钟出針。随以两手指由两风門穴向下起推按到腰部痛区，連續推按三次。在第三次推按到痛区时，令患者咳嗽三声，再将手放开即痊愈。

治驗：此法經治疗我县供銷社邢××、高邑人民公社吳××、咱家营人民公社苗××、高邑专卖处薛××等多人，均一次痊愈。

按：腰痛的发生，有多种原因，其治疗原則亦随症而异。如第二、四两方，一为急性风湿腰痛，一为风火腰痛，同属新病。第二方取条山、奇穴，以一針貫串阳明、太阳两經，来治新发的上部阳經痹痛，取效甚捷，但刺激反应亦大，用者应掌握适当手法，勿太过，毋不及；第四方取风門、肺俞，以泻去风热为治，适应于初期风热性的腰背痛；至于第六方取人中，治疗閃挫引起的腰痛，其目的为激发諸阳之气，并随針行深呼吸，古名运气法，此与第七方刺阿是以手循經推而助之同一意义，为伸針行气之法，使經絡間留結滯气得通，而腰痛可愈。其余三方取穴則均以太阳、少阳为主，符合以阳治阳的原則。古今医家在治疗腰痛方面，积累了很多的宝贵經驗，如針灸大成所載之四总穴：“肚腹三里求，腰背委中留，头項寻列缺，面口合谷收。”后人更增入“痠痛寻阿是，胸脇内关謀”两穴，成为六大总穴，进一步总结了經穴的主导作用和使用經驗。讀者可在用方的基础上，結合参考使用。在治疗慢性以及腎虛腰痛时，如能結合火罐气吸之，疗效当更好。

三十八、肋 痛 (共三方)

第一方 河北中医学院 刘殿元介绍

主治：肋痛。

症状：肋肋部疼痛，深呼吸或咳嗽，轉側則痛甚。

取穴：主穴：章門(双) 食竇(双)

配穴：支沟(双) 阳陵泉(双)

手法：用毫針刺章門八分至一寸，食竇斜刺八分，用平补平泻手法；支沟直刺一寸，阳陵泉直刺一寸二分，这两个穴的进針法和手法，要求吸气时捻进和捻轉，刺激要重，使感应直达患部后稍停再出針。每日針一次。

治驗：唐县制鞋厂李××，男，三十四岁，工人。初診：一九五九年七月十五日。主訴：“于七月十二日感右肋七、八肋間隱隱作痛，現在疼痛加重，不敢咳嗽及深呼吸，既往无其他病患发生，飲食、二便正常。”經与乡医院会診检查：系肋膜炎症，脉象弦緩，打診患区，无特殊音响。印象：系气逆胸肋作痛。經依上法取穴治疗，一次后即減輕，二次后疼痛消失，痊愈。

第二方 张家口市桥西区人民医院 庞汉卿介绍

主治：季肋痛。

症状：季肋部疼痛（俗名岔气）。

取穴：支沟

取穴法：平臥位。于外关穴上一寸五分取之。左痛取右侧，右痛取左侧。

手法：用毫针刺支沟一寸五分，用平补平泻手法，留捻三十分钟。痛止后出针，一次即痊愈。

第三方 天津中医学院附属医院 王紹中介绍

主治：肋間神經痛。

症状：肋間痛，有时障碍呼吸。

取穴：支沟 章門 期門（章門、期門輪流使用）

手法：用三十号毫针直刺支沟、章門各一寸，期門进针后向外方斜刺五分至一寸。用平补平泻手法，留针三十至六十分钟。根据症状轻重，每日或隔日针一次。

禁忌：忌劳碌及精神刺激。

治驗：（一）本市汽車公司邢××，男，二十八岁，职工。一九五九年八月十一日門診，病历一一六〇二号。主訴：“两肋肋疼痛，已有三天，呼吸稍有障碍，睡眠、二便正常。”既往：有全身关节炎症。检查：脉象細弦，舌苔白。印象为两肋間神經痛。經针刺支沟二穴，用泻法予以重刺激，留针十五分钟。起针后疼痛消失。

（二）本市第七五金社张××，男，二十八岁，工人。于一九五九年七月一日門診，病历四〇一十二号。主訴：“右肋間痛已四日，深呼吸时更痛，影响睡眠及飲食，二便正常。”检查：脉細弦，舌苔白，呼吸略有障碍。印象为右肋間神經痛。經取穴支沟、期門，用重刺、泻法，起针后疼痛消失。

按：上列三方，虽主治症名不同，但同属于肋痛的范围，或

取穴于手足少阳之会，或取穴于肝、脾之募，或两相配用，内取本脏，外通经络，则滞气得除。取穴方法，治疗胁痛多于远隔部位循经取穴，配合局部穴位，但局部穴位刺激要轻，远距离穴位刺激宜重，使感应放散到患部，并适当留针，常可获致良好的效果。如在局部取穴浅刺留针，亦有止痛作用；惟局部呈现炎症时，则局部不宜刺激。

三十九、背 痛 (一方)

第一方 河北中医学院 刘殿元介绍

主治：背心痛。

症状：胸椎脊柱两旁肌肉，隐隐作痛。

取穴：主穴：夹脊

配穴：委中 脊中

取穴法：坐位或伏臥。夹脊穴于胸椎（脊柱）两旁約五、六分有压痛点处是穴。

手法：用毫针刺夹脊两旁压痛点处，或每隔两椎节即刺入一針，針尖向外方斜刺五分深。用平补平泻手法，針后加灸。委中可刺一寸二分，用阴中隐阳手法，（吸气时捻針向外，呼气时向内捻針，随呼吸一退、一进）。脊中穴可刺入五分，針尖斜向上刺，手法同上，留針三十分钟。

治驗：（一）武清县刘××，女，二十二岁，农民。一九五八年八月十日門診。主訴：“背部脊柱两旁隐隐作痛，发病已两月余。既往无其他疾病，月經正常，已結婚二年未育。”检查：胸椎一至七两旁有压痛，脉濡緩。印象：湿痹。治疗：取夹脊穴，斜向外針入五分，每隔二椎刺一針，用平补平泻手法；取委中刺一寸二分，留針三十分钟。共針治三次，痊愈。

（二）唐县崔××，男，四十岁。患背心痛已十余年，屡治无效。經針上穴三次后痛減大半，后因故中止治疗，未能繼續观察。

按：夹脊穴一名肘椎。取法是令病人伏卧，两手并身体，以绳在其两肘尖横引，当绳下之脊柱处作假点，复从假点各外开五至六分或一寸，有压痛点是穴位。华陀疗霍乱，心腹胀，吐痢烦闷不止，灸之，一般该穴治疗局限性痉挛、转筋、腓肠肌痉挛有效。本方可配合委中，符合四总穴的“腰背委中求”的原则，故用治背心痛有效。

四十、风湿痹 (共四方)

第一方 徐水县漕河人民公社医院 孙起尚介绍

主治：四肢麻痛。

症状：外受风邪，周身疼痛难忍，四肢麻痛（游走性疼痛）。

取穴：外关 中渚 肩髃 曲池 合谷 后谿
环跳 风市 阴市 阳陵泉 足三里 崑崙
内庭

手法：用毫针捻转直刺。外关针一寸，中渚四分，肩髃一寸，曲池一寸五分，后谿三分，环跳二寸，风市一寸五分，阴市八分，阳陵泉一寸，足三里一寸，崑崙三分，内庭三分。痛者用泻法；麻者用补法，并灸外关、曲池、风市、阴市、阳陵泉各三壮。

第二方 唐山市卫协联合诊所 孙绍亭介绍

主治：游走性关节痛。

症状：风湿性关节痛，游移不定。

取穴：主穴：风池(双) 合谷(双) 崑崙(双)

配穴：曲池 手三里 中渚 足三里

阳陵泉 风市 丘墟 太冲

手法：用圆利针刺风池一寸五分，针左侧向右眼窝进针，

針右側向左眼窩進針。刺合谷、崑崙一寸，曲池一寸五分，手三里五至七分，中渚三至五分，足三里、陽陵泉各一寸，風市五至八分，丘墟、太沖各三至五分。用平補平瀉手法，留針一至二小時。針後以艾條每穴灸五分鐘。上列配穴可以靈活選用，隔日針一次。

禁忌：針後忌受涼。

第三方 襄城縣無極人民公社醫院 劉成德介紹

主治：感冒後，風邪流入關節。

症狀：四肢疼痛，不得屈伸。

取穴：曲池(雙) 風市(雙) 外關(雙) 足三里(雙)
三陰交(雙) 合谷(雙)

手法：用毫針直刺。曲池針一寸，風市一寸至一寸五分，外關一寸，足三里一寸，合谷一寸。先刺左側上下肢，再刺右側上下肢。用平補平瀉手法，不留針。

第四方 霸縣大范莊衛生所 陳炳玉介紹

主治：痹症。

症狀：四肢關節紅腫，活動受限制。

取穴：主穴：肩髃(雙) 曲池(雙) 合谷(雙) 環跳(雙)
陽陵泉(雙) 足三里(雙)

配穴：腰陽關 絕骨 外關

加減法：寒濕者加關元、氣海、三陰交、足臨泣，針後

灸。风多者加风市、膈俞、大杼；合并心悸者加神門、大陵。

手法：用毫針捻轉进針。肩髃、曲池各一寸五分，合谷一寸，环跳二寸五分，阳陵泉、足三里各一寸，腰阳关、絕骨、外关各刺五分；关元、气海各一寸，三阴交五至八分，足临泣五分，神門三分，大陵五分，风市五至八分，膈俞向外方斜刺五分，大杼五分。均用平补平泻手法，留針一小时。隔日針一次。

禁忌：忌肉类、芹菜、辣椒等食物。

按：以上四方，同属痹症，但轻重不同。关于痹症，古典籍论述頗多，景岳全书风痹內載：“风痹一証，即今人所謂痛风也。盖痹者閉也，以血气为邪所閉，不得通行而痛也。如痹論曰，风气胜者为行痹。盖风者，善行数变，故其为痹則走注历节，无有定所，是为行痹，此阳邪也。曰寒气胜者为痛痹，以血气受寒則凝而留聚，聚則为痛是为痛痹，此阴邪也。曰湿气胜者为著痹，以血气受湿則濡滯，濡滯則肢体沉重而疼痛、頑木，留著不移，是为著痹，亦阴邪也……。”治疗方面，灵枢五色篇載：“……其病生于阳者，先治其外，后治其內，反者益甚。”明确了病在外，先取阳經，后取阴經的治疗原則。上列四方取穴均以手、足三阳为主，符合于以上原則。在取穴方面，除以外关、合谷、曲池、风市、阳陵泉、足三里等穴为主，配合其他穴位治疗外，并可按疼痛的部位取穴針治。

四十一、下 痿 (共三方)

第一方 霸县县医院 王茂林介紹

主治：截瘫。

症状：下肢不能为用，肌肉不萎缩，二便不能自主。

取穴：八髎(双) 白环俞(双) 秩边(双) 环跳(双)
风市(双) 阳陵泉(双) 复溜(双) 条口(双)
绝骨(双) 水道(双) 中极 关元 归来(双)

(背部穴、腹部穴交替使用，下肢穴可轮换使用)

手法：用毫针旋捻，平补平泻手法。八髎刺入五分，白环俞刺入七分，秩边五分，环跳刺入三寸，风市八分，阳陵泉一寸，复溜五分，条口七分，水道、中极、关元、归来各一寸。(刺下肢穴位的同时，不刺背部穴位)留针九十分钟，隔日针一次。

附注：针后注意休息，并适当练习活动。

治验：本县李庄李××，女，二十一岁，农民。住院号二一六八八号，于一九五八年十月二十八日入院。主诉：“初起腰疼，数日后下肢突然失去知觉和运动，大小便不知道。在家治疗多次未效。”
现症：下肢截瘫，面黄肌瘦，语音低细无力。家族病史：外祖母因下痿死亡。检查：爱克斯光透视，两侧胸膜肥厚粘连，左肺上部有结核，已钙化，无显著结核症状表现。脉象：迟细无力。印象：气血之虚以致下痿。治疗：依上述穴位针治，前五次未显任何效果；针至二十次后，大小便能自主的控制；三十次后自己能下床行

走，飲食大小便如常，出院回家休養。

第二方 徐水县漕河人民公社医院 孙洛瑞介紹

主治：下痿。

症状：下肢截癱，肌肉已現萎縮（腓腸部），下肢不能自主的伸屈。

取穴：太冲(双) 解谿(双) 飞揚(双) 承山(双)
环跳(双) 风市(双) 阴市(双) 阳陵泉(双)
足三里(双) 崑崙(双)

手法：用左手指重切穴位，右手持毫針緩緩旋捻进針。刺太冲一寸，解谿三分，飞揚、承山各一寸，环跳二寸，风市、阴市各一寸，阳陵泉一寸五分，足三里、崑崙各一寸。均用补法，留針一小时。出針后隔姜灸风市、阳陵泉、崑崙，灸至皮肤潮紅为度。隔日針灸一次。

治驗：运用本法，曾治疗十例，均已痊愈。但病程在三年以上，肌肉已經萎縮，且患者年龄在四十岁以上者，本方不能治疗。

第三方 河北省精神病院 王振周介紹

主治：下肢癱瘓。

症状：下肢不能运动，肌肉萎縮消瘦，但二便自如。

取穴：主穴：天灵(双) 中平(双)
配穴：环跳(双) 承扶(双) 足三里(双)
委中(双)

取穴法：天灵穴正坐，手臂下垂，在腋横紋上一寸内开五

分是穴。中平穴，正坐屈膝垂足，在髌骨(膝蓋骨)下緣与解谿穴联綫的中央点，在脛、腓骨之間是穴。

手法：用长毫針直刺天灵穴，向对側进針，使針尖达对側皮下，再刺中平穴，深度达对側皮下。用重刺激泻法(大拇指向前捻針)，留捻十分钟出針。再側臥取环跳穴刺入三寸五分，承扶三寸，足三里二寸，委中四分。用泻法，留捻十分钟。

治驗：(一) 保定市完滿区安阳人民公社康官村王××，男，四十二岁。自訴：“一九五七年十二月在施工中，被石块砸伤，当时昏迷，醒后下肢不能活动，經中西医药針灸治疗四十余次，初时見效，继而不效，反更形加重，两腿不能站立，臥床不起。”一九五九年四月就診。检查：两下腿不能自主活动，下肢肌肉瘦削萎縮，二便自如，脉虛。第一次取穴：天灵(左)、中平(双)，暗示后皆能活动，針后第二天自己能拄杖行走，第二次針本方主、配穴，針后弃杖能自己行动，第三次針后已活动如常，痊愈。六月十五日随訪已参加劳动。

(二) 田××，男，三十七岁。自訴：“一九五七年三月参加水庫工程，因不慎从房上摔下，腰部被摔伤，疼痛不止，两腿发軟，不能站立，經多次針药未效。”一九五九年四月开始为之治疗。取穴：天灵(双)、中平(双)，觉腰部热甚，感应很大，通过暗示能屈膝，針后能起立試步，又連針两次，痊愈。六月間去訪視，已参加劳动。

按：以上三方，从症状上看，都是下肢痿縮不遂，而手法上却是一补一泻。第一、二两方适用于病程較长的虛症，治疗上以循經接續取穴法，針灸并施以通阳开痹。第三方通过驗案可以看出，因外伤造成了經絡痹塞，营卫不能暢通，以致下肢痿而不用，仍属于实症，所以用泻法达到治愈。

四十二、偃 僂 (一方)

第一方 黃驊县城关医院 董健亭介紹

主治：脊椎結核后遺症。

症狀：在第八椎棘突处出現駝背，不能起立。

取穴：第一組：膈俞 肝俞 三焦俞 腎俞 筋縮
命門

第二組：上髎 中髎 小腸俞 胞育
腰陽關

手法：交替刺之，隔日一次。

治驗：本县城关南上園曹××，女，三十岁。曾患脊椎結核，經用抗生素、睡石膏床半年不愈，不能行走，起立須用人扶持，在第八椎棘突处出現駝背。用毫針先刺第一組穴，隔日刺第二組穴，針十次后能在炕上行动；二十次后能下地行走；二十五次后即恢复健康。

按：脊椎結核，是骨之慢性疾患中最常見的一种病，常以結核性骨膜炎、骨髓炎引起，或肺結核、腺結核轉移而成，发病在脊椎的叫脊椎結核。祖国医学中沒有这个名称，常把这类病包括在骨疽、阴疽、下痿等病以內。內經灵枢刺节真邪篇載：“……有所結深中骨，气因于骨，骨与气并，日以益大，則为骨疽。”痛疽篇載：“热气淳盛，下陷肌肤，筋髓枯，內連五脏，血气竭，当其痛下，筋骨良肉皆无余，故命曰疽。”諸源病候論載：“疽者五脏不調所生也，五脏主里，气行經絡而沉，若喜怒不測，飲食不节，阴

阳不和，則五脏不調，荣卫虛者，腠理則开，寒客經絡之間，經絡为寒所閉，則荣卫稽留于脉，荣血得寒則涩而不行，卫气从之与寒相搏，壅遏不通，寒热不散，积聚而成为疽。”这些記載充分說明疽发病的原因，是内由气血亏损，外受虛邪賊风，六淫之邪所成。因寒邪客于經絡之間，所以針灸采用上述穴位，以开腠理，解凝結，行气血，使局部血液循环旺盛，由阴而轉阳，从而达到治愈的目的。

四十三、上臂不舉 (共五方)

第一方 河北中医学院 刘殿元介绍

主治：上臂不举。

症状：一侧或两侧臂膊不能上举，活动障碍。

取穴：主穴：条山

配穴：曲池 肩髃 环跳

取穴法：条山穴在条口内方五分。

手法：用毫针轻捻进针，刺条山二至三寸，针锋向承山方向捻进，抵承山穴下。曲池、肩髃、环跳各直刺一寸五分，用平补平泻手法。条山穴刺后，令患者试举上臂，如恢复活动，配穴可不用；但久病者须用之。每日针一次。

治验：条山穴治疗风多湿少之痹症效果良好，对寒痹效果较差。

仅举一例介绍如下：

唐县张××，女，四十二岁。患上臂不举，举则腋间拘紧、隐痛，已一年余。当针刺条山后，臂部立能上举，疼痛消失。

第二方 邯郸市第三医院 游贞祥介绍

主治：上臂痛（包括指、腕、肘、肩各部疼痛）。

症状：患部关节痛，障碍活动。

取穴：肩髃 曲池 合谷

手法：用毫針捻轉進針。肩髃、曲池各直刺一寸，合谷七至八分。根據症狀用虛補、實瀉、不實不虛用平補平瀉法，留捻十至二十分鐘。一次即痊癒。慢性久病患者可每日針一次。

第三方 懷來縣涿鹿鎮 韓壽三介紹

主治：肩痛。

症狀：肩臂痛，不能活動。

取穴：主穴：肩貞 天宗

配穴：肩外俞

取穴法：坐或伏臥。肩貞在肩胛崗下緣，從腋縫尖端上方一寸處，斜上一寸七分爲天宗穴，當肩胛骨上方寸許。肩外俞從陶道穴外開三寸處。

手法：用毫針直刺肩貞、天宗各八分，用瀉法（拇指向前捻），肩外俞以大火罐拔之，拔至皮膚紫紅爲度。留針二十至六十分鐘。

第四方 天津中醫學院附屬醫院 王文錦介紹

主治：肩凝。

症狀：上臂疼痛不能抬舉。

取穴：阿是

取穴法：在足三里穴下三寸左右脛骨外找壓痛點是穴；如果找不到壓痛點可用條山穴代替。

手法：用毫針捻轉向承山方向刺入二至四寸，留針五分鐘。每日針一次；症狀減輕後可隔日針一次。

按：风湿性肩臂痹痛，是临床上常見的一种症候，如手臂不能高举，手臂不能展轉，肩臂痛等。用針灸治疗取穴，都是以手太阳、阳明、少阳三經为主，在灵枢經筋篇上已經指出該三經之筋与本病的关系。因此在实际临床上所取的穴位，如曲池、肩髃、合谷、肩貞、天宗、肩外等穴，这些穴的主治作用，均可以治疗肩臂痹痛病患。根据病情輕重新久，而选用各穴，运用各种手法或灸法，都可以收到一定的疗效。第一方的条山，配环跳、曲池上下相应，調整半身机能，这是一种局部和邻近病所的腧穴，結合四肢的腧穴的配穴法，已成为古今針灸家所一致采用的規律；第二方是属于邻近的穴和循經取穴的方法。总之，不論局部取穴、邻近取穴、循經取穴，只要运用得当，都可以应手获愈。

第五方 国营青县农場 馮鉄城介紹

主治：扭伤。

症状：臂肿胀疼痛，不能抬举。

取穴：外关 阳池

手法：用毫針直刺，留針三十分钟。

治驗：本农場任××的爱人。主訴：“因打草不慎将臂扭了一下，未治越来越加重，影响工作，患肢不能抬起梳头。”检查：左臂肿胀，按之而痛。經用此方針治三十分钟后，肿胀消失，活动自如。

按：治疗扭伤取外关、阳池，是循經取穴法。凡病呈现在某經循行所属的脏腑軀干及头面时，可取某經在四肢肘膝以下的俞穴来进行处方配穴，名曰循經取穴，这对急性病和痛症的疗效最好。本方取外关、阳池治疗臂肿胀疼痛，疗效显著，因为这是根据手少阳經的循行路綫取穴，也是符合“經路所通，主治所在”的規律。

四十四、落枕 (共五方)

第一方 吳橋縣廟鎮鄉人民公社衛生院 李汝鈞介紹

主治：落枕。

症狀：頸歪、痛，不能動。

取穴：懸鐘 新識

取穴法：坐位。新識穴在風池穴直下方，後髮際下一寸五分處。

手法：用毫針先刺懸鐘穴一寸至一寸五分，針尖向上下提插兩次，用平補平瀉手法；然後再刺新識穴八分，向外開斜刺，留捻三十分鐘。每日針一次，二次即痊癒。

治驗：（一）本縣廟鎮鄉大屯村田××，女，四十一歲。於一九五九年三月十日初診。主訴：“起床後，頸項強痛，不能左右回顧。”檢查：脈象浮大而虛，兩關尤甚。印象：落枕，系由於睡眠時體位失常，為風寒所客，以致筋脈失和所致。治療：取穴懸鐘一寸五分，針後捻之，患者反應酸、麻感應達于足背，復將針提起，針尖微向上斜刺，捻轉後，患者自覺酸麻上行，已達半个身軀；然後再刺新識穴一寸，用平補平瀉手法，留針一小時。共針刺兩次即痊癒。

（二）本縣廟鎮鄉夏××，女，五十六歲。一九五九年三月二日初診。現症與第一例相同，既往患過淋病。檢查：脈象左虛而無力。印象：落枕，系腎、肝俱虛，筋失所養。治療：取穴、手法與第一例相同。共針刺三次而痊癒。

第二方 承德市矿山机械厂 吴家义介绍

主治：落枕。

症状：颈肩部肿、痛，不能回顾。

取穴：风池(双) 肩井(双) 风府 翳风(双) 大椎

手法：用毫针直刺风池八分，肩井六分，风府四分，翳风六分，大椎四分。用强刺激手法，留捻三十至四十分钟。每日针一次。

治验：本市汤左君、李兆珍、王景才、田晴等九名患落枕，均针治一次痊愈。

第三方 安国县祁州人民公社医院 李鹤鸣介绍

主治：落枕风。

症状：一侧项强，不能回顾。

取穴：绝骨

取穴法：坐位。从外踝骨尖直上三寸是穴。

手法：用毫针捻转进针，刺入五分至一寸。用平补平泻手法，每三十分钟捻动一次，以发生酸、麻感应为度。留针二小时。

治验：本县针线厂王××，女，三十四岁，工人。一九五九年二月来诊。主诉：“颈项右侧痛，不能回顾，经中、西医治疗不见功效。”该患者惧针，经说服动员方始合作。依上法针治，留捻至一小时后，患者自觉颈部轻松，试作活动，疼痛已消失；又留捻一小时，出针。共经两次治疗即痊愈。

按：绝骨穴又名悬钟，在足外踝上三寸，属足少阳经，乃足

三阳之大絡，髓之会穴。本經自上而下循行身之兩側，主脉与支脉均循頸側下合于缺盆。而落枕一症，主征是項强、不能回顾。正如灵枢經筋篇所指出“足少阳之筋，……其病……頸維筋急”的症狀。又杂病篇載：“項痛不可俛仰，刺足太阳，不可以顾，刺手太阳也。”以上两篇指出主病及治疗重点。再按諸痛为实，痛随利減的說法，頸項强痛是上气有余，灵枢終始篇載：“刺諸痛者，……病在上者，下取之……。”調之于絕骨穴，即今称誘導取穴法，使营卫通調，則結解痹开而痛止。

第四方 涇源县王安鎮卫生院 刘继忠介紹

主治：落枕。

症狀：頸項强直，轉动时剧烈疼痛。

取穴：风池(双) 絕骨(双)

取穴法：坐位。风池与风府平，外开一寸五分；絕骨在外踝上三寸。

手法：以毫針刺风池八至九分，絕骨一寸。徐徐捻动之，留針三十至六十分钟。

治驗：本县照象館馬××，男，二十九岁，工人。患落枕，服药未效。經按上法針治，一次即痊愈。

按：本方与靜海县医院公茂德大夫所介紹处方相同。公大夫經驗治疗此症，有时仅取絕骨一穴，风池則偶尔配用。手法方面，系强刺激，而絕骨刺針深度为一寸五分，針尖向上斜刺。經治十余例，均一至二次痊愈。証明絕骨穴治疗落枕疗效确实。

第五方 滄县中医学校 顾炳熙介紹

主治：落枕。

症狀：頸項強，回顧困難。

取穴：天柱 肩中俞 列缺

手法：以毫針刺患側天柱、肩中俞、列缺三至五分。用重刺激手法，留捻三十至六十分钟，或感覺頸部活動恢復即起針。如未愈翌日再針一次。

治驗：徐××，女，二十五歲。睡醒後，突感項強不能活動。經用上法針治二次，痊愈。

按：以上五方，或取穴患側局部或上肢，或取穴于下肢，均以手足少陽為主，間以督脈或它經為配。手法均使用重刺激，以導氣、瀉實，陽邪去而疾愈。

四十五、手足指趾痛 (共五方)

第一方 河北中医学院 刘殿元介绍

主治：手指痛。

症状：五指麻木或红肿疼痛。

取穴：主穴：三间 后谿

配穴：八邪

取穴法：八邪穴在手五指歧缝间，握拳取之；左右共八穴，如液门之取穴法。

手法：用毫针捻转进针，三间、后谿两针锋相对刺向掌心劳宫穴处。八邪穴深刺五分，用强刺激手法，留针三十分钟。

治验：阜平县罗××，男，三十二岁。自诉：“十年前腕部受创，此后手指即疼痛，局部不红不肿，恶热、喜凉。”经治疗取用它穴，效果不大；继采用上法，疗效显著。共针治四次痊愈。

按：八邪，一名八关，在手五指歧骨间，左右手各四穴。其一大都二穴，在手大指次指、虎口赤白肉际，握拳取之，治头风牙痛；其二上都二穴，在手食指、中指本节歧骨，握拳取之，治手臂红肿；其三中都二穴，在手中指、无名指本节歧骨，又名液门，治手臂红肿；其四下都二穴，在手无名指、小指本节后歧骨间，一名中渚，中渚穴在液门下五分，治手臂红肿。两手共八穴，故名八邪。

第二方 河北中医学院 刘殿元介绍

主治：足趾痛。

症状：足趾或麻或木，或疼痛，红肿。

取穴：主穴：公孙 八风

配穴：解谿

取穴法：八风穴在足五趾趾缝间赤白肉际。

手法：用毫针刺公孙一寸五分至二寸五分，针向掌心方向捻进；八风穴由趾缝进针，刺向足背三分，如某一足趾肿痛，即刺其患部两侧之八风穴。用平补平泻手法，留针二十至四十分钟。倘系寒痹麻木，针尾用艾灸之。

治验：阜平县顾××，女，三十二岁，农民。初诊一九五九年四月二日。主诉：“一九五九年一月间自觉左足大次趾发凉微麻，以后即感觉疼痛，过劳或天阴则痛剧。”既往：未生过其他疾病，经期正常。检查：脉缓，印象为寒痹之足趾痛。治疗：取穴公孙，深刺三寸，用阳中隐阴手法。配刺八风，由足趾缝进针，手法同上，针尾加灸，留针三十分钟。共针三次而痊愈。

按：八风，一名八冲。千金内记载是足十趾去指缝一分；针灸大成记载是在足五指歧骨间。两足共八穴，治脚背红肿。

第三方 涿县涿镇人民公社医院 史星三介绍

主治：足跟痛。

症状：气虚，足跟疼痛，局部无红肿。

取穴：主穴：承山

配穴：崑崙

取穴法：坐位或臥位，取患側穴。

手法：用毫針捻轉進針，直刺承山二寸，崑崙一寸。捻搗使感應放散到足跟（男子拇指向前，女子拇指向後，午前如此，午後反之）。每日或隔日針一次，一至四次即痊癒。

第四方 獻縣小范第三醫院 孫仲邦介紹

主治：足跟痛。

症狀：足跟痛，不能履地。

取穴：女膝

取穴法：側臥，兩足平伸。女膝穴于足跟正中赤白肉際取之。

手法：用二十八號毫針直刺女膝穴，進針後斜向涌泉穴方向捻進三寸，留捻一小時後出針。一次即痊癒。

第五方 河北省中醫研究院門診部 景象介紹

主治：足背神經麻痺。

症狀：足掌伸屈不能，局部知覺喪失。

取穴：主穴：行間 俠谿 內庭 解谿

配穴：陽陵泉

手法：用毫針捻轉進針。刺行間、俠谿、內庭、解谿各二至三分，陽陵泉直刺一寸五分。均用補法捻針（右手大指向前），留針三十分鐘。每天針一次。

按：以上五方，都是局部取穴。凡病呈現于某部，即在某部取穴，名局部取穴。這種取穴方法，除適用於体表局部發病以外，對內臟或深處的疾患以及慢性的疾患，療效都很好。

四十六、手 顫 (共二方)

第一方 河間中医学院 王洪印介紹

主治：手振顫。

症状：手顫抖，不能持物。

取穴：内关 大陵 外关

取穴法：坐位，两臂平放取穴。急性者取内关；慢性者取大陵、外关。

手法：用毫针直刺内关、外关各一寸五分，大陵向掌心与皮肤面呈四十五度刺入一寸。用平补平泻手法，留针六十分钟。

治驗：（一）滄县六区陈××，男，二十九岁。因突然受惊，自觉心跳，口、眼肌肉颤动，两手振顫。当即针人中、承浆、太阳，面部肌肉颤动停止，惟手顫依然；又针刺两内关。下针五分钟，振顫停止。

（二）滄县水利局楊××，男，四十岁。患心慌手顫，搖动不停。刺内关两穴，留针三十分钟；出针后振顫停止，迄未复发。

第二方 涉县城关鎮医院 李墨香介紹

主治：手顫。

症状：手顫动不定。

取穴：少海 后谿

手法：用毫针直刺少海一寸，后谿一寸五分，针直透至三

間穴下，一針刺到底，得氣后将針提起五分稍停，再提出五分；第三次再提出五分至皮下后再捻進。留針十五至三十分钟。每日針一次。

治驗：（一）本縣城关鎮王××，女，二十八岁。主訴：“一九五五年因精神过度激动，自己強力抑制，翌日即感覺手掌发麻，第三天即发生手顫，迄今已經二年，陣陣发作。”診斷印象：心气虛、肝气上冲、气血郁結于上肢所致。治疗：取穴少海針一寸，后谿針一寸，用呼吸补泻法提插捻轉，留針十五至三十分钟。每日針一次，針两次后痊愈。

（二）本縣清凉村程××，女，六十岁。主訴：“因在冷水中洗菜，手部受凉，第二天手发生振顫不遂。”診斷：脉見浮濡，气血虛弱，因水冷刺激，气血凝滯以致发生手臂振顫。治疗：以补气化滯为主。取穴少海一寸，太淵五分，后谿一寸。用迎隨补泻法，留針三十分钟。每天治疗一次，治疗三次后痊愈。

按：手顫症，中医认为是心气虛、肝邪上乘所致。虽无运动障碍，但时发不自主的震顫，久不得愈則轉为慢性。灵枢邪客篇載：“……肺、心有邪，其气留于两肘，……”而四肢为諸阳之本，內經載：“……实則肢肿，反之，阳气虛則易于留邪，……”以上第一方取穴于手厥阴与三焦，以調其阴阳；第二方取穴于手太阳之俞穴后谿，及手少阴之合穴少海，表里同治，使邪去正复，均达到治愈。除以上穴位外，还可加取曲池、手三里、中渚等穴輪換使用。

四十七、中毒急救 (共三方)

第一方 唐山市卫协联合诊所 孙紹廷介紹

主治：巴比妥中毒所致的昏迷。

症状：呼吸浅、慢，昏睡不醒，发鼾音。

取穴：手足十宣 涌泉 人中

加减法：如手紧握加劳宫。

手法：用較粗毫針先刺人中、手足十宣，重刺激，再刺涌泉及其附近，反复重搗；劳宫可于手中指、无名指指縫中下針刺之。以上各穴均反复捻轉提插，至患者发出呻吟为止。不留針。同时并可用葡萄糖、强心剂等輸液。

第二方 唐山市开灤医院赵各庄分院 傅敬培介紹

主治：煤气中毒（一氧化碳中毒）。

症状：胸高，呼吸促迫，煩躁不安。

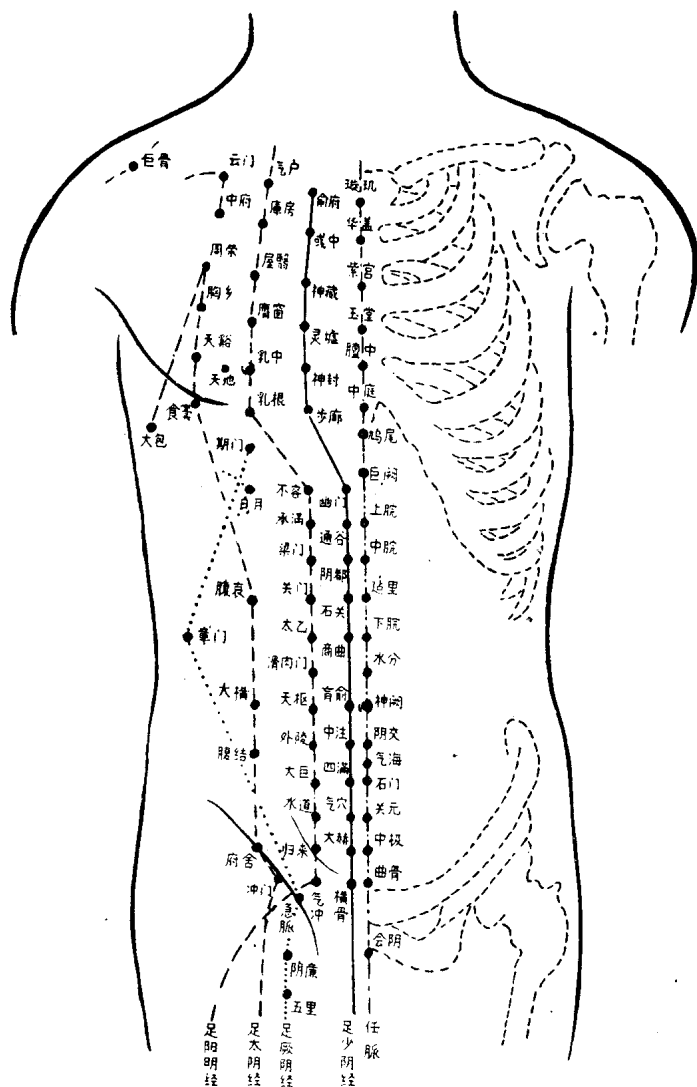
取穴：少商(双) 印堂 膻中 通谷

手法：用圓利針刺少商出血；印堂进針斜向左側五分，令出血；膻中輕捻刺向下方二分；取左側通谷穴刺入一至二分，旋捻留針，然后用手指叩打通谷針之周圍，留捻三至五分鐘起針。一次即痊愈。

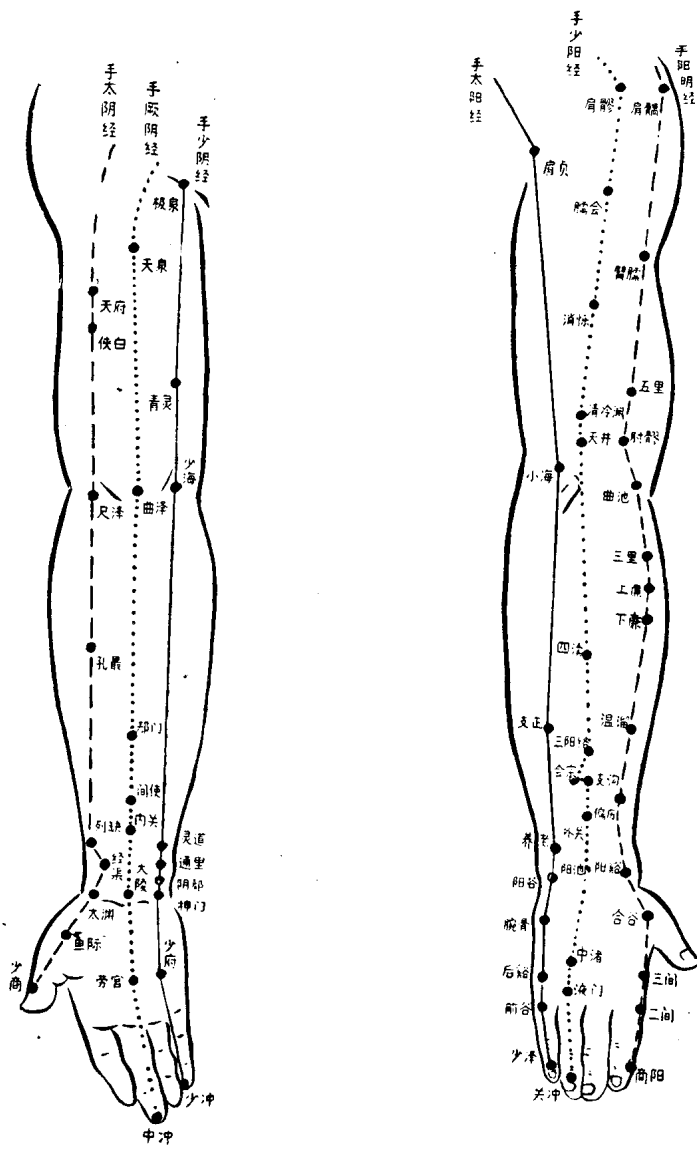
按：煤气中毒是由吸入一氧化碳气体而引起的損害。輕的可

以引起头痛、眩晕、心悸、气促、疲乏、四肢无力；重的则可以引起视力模糊、恶心、呕吐、虚脱、昏迷、抽搐痉孪，最后心脏呼吸抑制死亡。至于用针灸治疗煤气中毒，文献记载不多，治愈中毒机转，亦尚不清楚。按现代学说，主要是由于刺激穴位，达到激发调整神经机能，增加新陈代谢，促进血液循环，而便于一氧化碳排出和氧的交换；同时针灸疗法可以引起镇静镇痛作用，故一氧化碳中毒症状消失。而中医认为中毒所发现的一系列症状，多是由于气血阻滞所造成的。少商为十井穴之一，能使气血流通，是一般急救的妙穴；印堂有清头热、去风邪的作用；通谷主治胃气下留五脏，气乱于头；膻中可以去胸腹的苦闷，理气健脾。所以用针刺疗法，能以“疏通经络，宣导气血，驱除邪气，恢复正气”，故能治愈。至于第一方巴比妥中毒所采的穴位，主要是加强气血的运行，故亦有效。因煤气中毒及巴比妥中毒都是由于吸入该种毒质较多所致，这也符合祖国医学内经所说“邪之所凑，其气必虚”的病因。

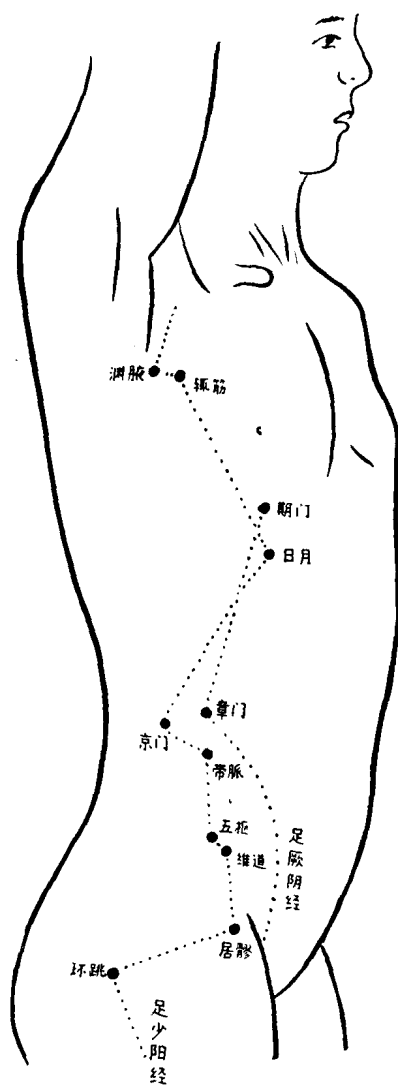
(三) 胸膈胁腹部



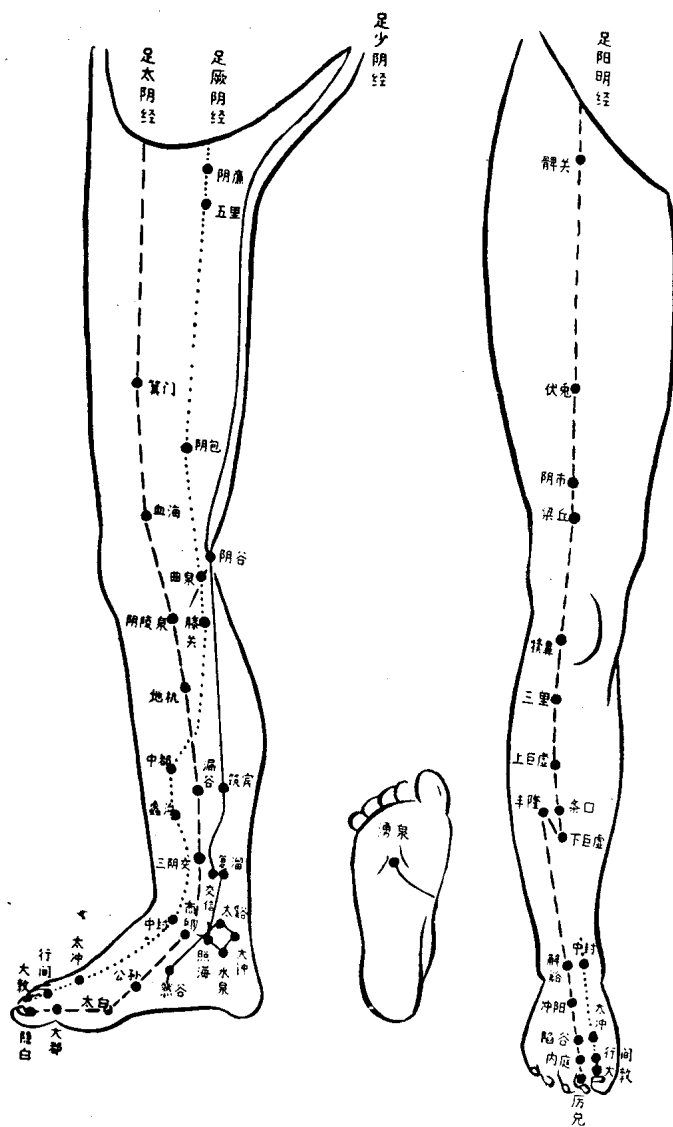
(四) 上肢部



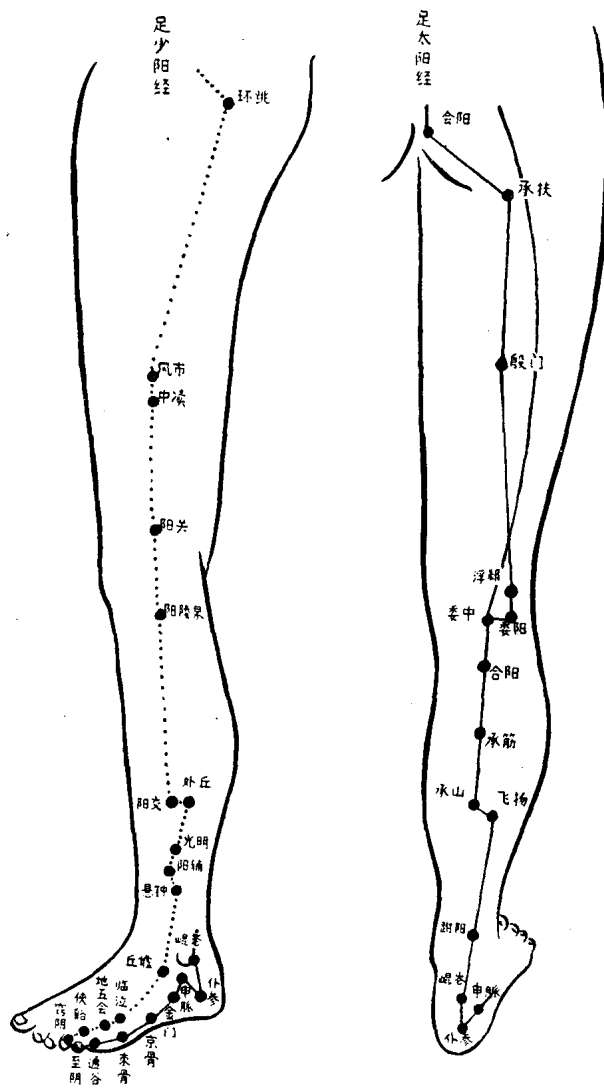
(五) 腋胁侧腹部



(六) 下肢部 (甲)



(七) 下肢部 (乙)



[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=十万金方 针灸第一集 (内科)

作者=河北省中医研究院编

页数= 2 1 7

出版社=河北人民出版社

出版日期= 1 9 6 0 年 0 1 月 第 1 版

S S 号= 1 1 1 9 2 3 5 0

D X 号= 0 0 0 0 0 0 8 2 5 9 2 2

u r l = h t t p : / / b o o k 1 . d u x i u . c o m /
b o o k D e t a i l . j s p ? d x N u m b e r = 0 0 0
0 0 0 8 2 5 9 2 2 & d = 9 A 6 E 5 9 5 0 1 6 F 9 C 2 1
3 5 F 3 A 1 0 5 5 7 3 3 D 5 9 3 5 & f e n l e i = 1 6
0 5 1 7 & s w = % C A % A E % C D % F 2 % B D % F 0 %
B 7 % B D

封面
书名
版权
前言
目录

- 一、流行性“乙型”脑炎
- 二、疟疾
- 三、肠伤寒
- 四、痢疾
- 五、流行性感冒
- 六、肺结核
- 七、咳嗽痰喘
- 八、梅核气
- 九、腮腺炎
- 十、扁桃体炎
- 十一、胃肠炎
- 十二、胃十二指肠溃疡
- 十三、便血
- 十四、五更泻
- 十五、便秘
- 十六、脱肛
- 十七、遗尿尿闭
- 十八、疝气偏坠
- 十九、膈肌痉挛
- 二十、脾脏肿大症
- 二十一、肝硬变
- 二十二、膨胀
- 二十三、黄疸
- 二十四、中消
- 二十五、贫血症
- 二十六、神经衰弱
- 二十七、中风
- 二十八、口眼歪斜
- 二十九、暴瘖不语
- 三十、高血压
- 三十一、头痛
- 三十二、癫痫

三十三、癰病

三十四、牙痛

三十五、胃痛

三十六、腹痛

三十七、腰痛

三十八、胁痛

三十九、背痛

四十、风湿痺

四十一、下痿

四十二、伛偻

四十三、上臂不举

四十四、落枕

四十五、手足指趾痛

四十六、手颤

四十七、中毒急救

附：针灸经穴图